



**แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗- ๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗**





แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คำนำ

จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (East West Economic Corridor) เส้นทางที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออกของการคมนาคมเพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศและหัวเมืองสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับการยอมรับว่าเป็น “มหานครแห่งอาเซียน” ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านต่างๆ รวมถึงด้านการค้าและการขนส่งระดับอาเซียน เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพทั้งด้านบวก และด้านลบ จากสถานการณ์ในปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายหลากหลายด้าน เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเผชิญกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate change) รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นมีการถ่ายโอนร้อยละ 100 ในขณะที่ประชาชนมีความคาดหวังต่อระบบบริการสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นในฐานะหน่วยงานตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขในระดับจังหวัดจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มจากการทบทวนจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการทำงานในอนาคต ภายใต้กลไกการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องในทุกกระดับ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ร่วมกันจัดทำ ยกร่าง แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ระยะ ๕ ปี ดังกล่าว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์สุขภาพระยะ ๒๐ ปี ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงบริบทของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นเป้าหมายกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นให้กับหน่วยงาน หน่วยงานบริการในสังกัดตลอดระยะเวลา ๕ ปี เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ระบบบริการได้มาตรฐาน คนขอนแก่นมีสุขภาวะที่ดี” ต่อไป

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนา และจุดยืน ตำแหน่งของแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐	๔
ความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ เิงนโยบาย	๑๕
ความจำเป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก	๓๘
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น	๔๒
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์	๔๓
บทที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๔๕
วิสัยทัศน์ (Vision)	๔๕
พันธกิจ (Mission)	๔๖
เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goal)	๔๖
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	๔๖
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)	๖๕
ภาคผนวก	
ภาพประกอบการประชุม	
รายชื่อผู้ร่วมประชุม	
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ	

บทที่ ๑ บทนำ

๑.๑ เหตุผลความจำเป็นในการจัดทำแผน

การบริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ การบริหารงาน ยุทธศาสตร์เพื่อให้ประสบผลสัมฤทธิ์ จะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน โดยทั้งนี้ จะต้องอาศัยความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และการติดตามพัฒนางานอย่างต่อเนื่องของนโยบาย แผนปฏิบัติการ รวมไปถึงกรอบการประเมินผลตามตัวชี้วัดของหน่วยงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้นำรูปแบบการบริหารงานยุทธศาสตร์เข้ามาใช้ในการ บริหารจัดการองค์การอย่างต่อเนื่อง และได้มีการศึกษา ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์เพื่อ ตอบสนองต่อนโยบายสุขภาพในระดับเขตสุขภาพที่ ๗ สำนักงานปลัดกระทรวง และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาองค์กร และการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพบรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่จากการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขที่ผ่านมาพบว่า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนินการ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่พึงประสงค์ ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทวีความรุนแรงของการแข่งขันในตลาดโลก ทำให้ประเทศต่างๆ เร่งผลิตและพัฒนา นวัตกรรมเพื่อให้สามารถแข่งขัน ขณะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาของข้อจำกัดด้านทรัพยากรทั้งด้าน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และงบประมาณภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติ ราชการ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ๔ ด้านได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (PP Excellence) บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และบริหารเป็นเลิศด้วย ธรรมภิบาล (Government Excellence) เพื่อให้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข สามารถผลักดัน นโยบายดังกล่าว สู่การปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแผนพัฒนาระบบสุขภาพ และกระบวนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไปยังหน่วยงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

๒. เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยเชื่อมโยงสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับแผน ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และสามารถจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น

๑.๓ ระยะเวลาของแผน

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น มีกรอบระยะเวลาของแผนระยะ ๕ ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑.๔ กรอบแนวทางการดำเนินการ/ปฏิทินการจัดทำแผน

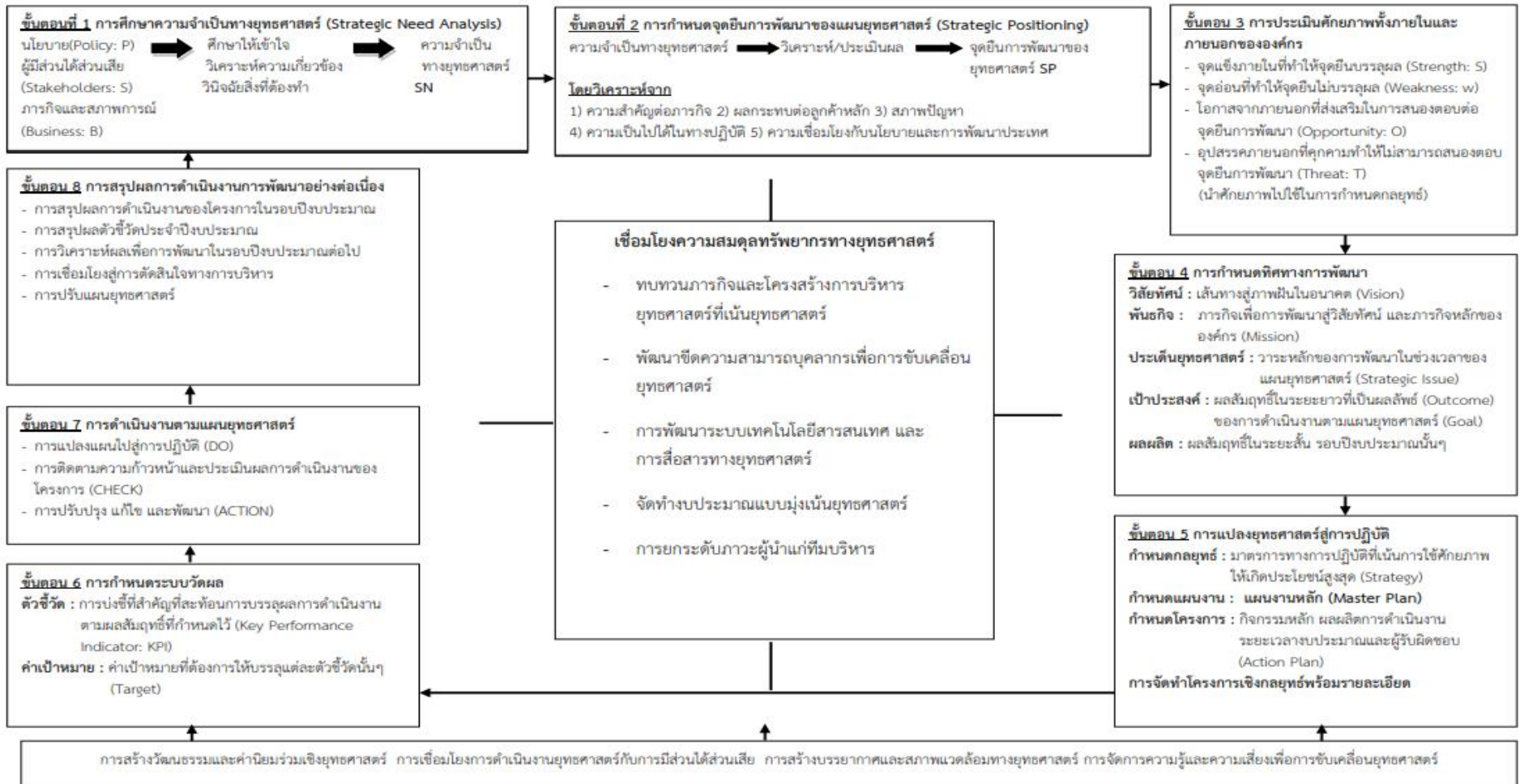
แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่องค์กรกำหนดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๑.๕ ภาพรวมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ โดยการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมเชิงยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์กับการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียในการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงความสมดุลทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ทบทวนภารกิจ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางยุทธศาสตร์จัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ยกระดับภาวะผู้นำแก่ทีมบริหารซึ่งในภาพรวมการดำเนินการซึ่งในภาพรวมของการดำเนินการดังนี้

- ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Need Analysis)
- ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดจุดยืนการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)
- ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินศักยภาพขององค์กรการประเมินศักยภาพขององค์กร (TOW's Matrix)
- ขั้นตอนที่ ๔ การกำหนดทิศทางการพัฒนาวิสัยทัศน์
- ขั้นตอนที่ ๕ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์
- ขั้นตอนที่ ๖ การกำหนดระบบวัดผล - ตัวชี้วัด
- ขั้นตอนที่ ๗ การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- ขั้นตอนที่ ๘ การสรุปผลการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจร



บทที่ ๒

ความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาและจุดยืน ตำแหน่งของแผนยุทธศาสตร์

พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

๒.๑ ความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์ เชิงนโยบาย

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ

- พัฒนาและเสริมสร้างคนให้เข้มแข็ง ตระหนักถึงเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
- สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
- สร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพ

๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

- แก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างจริงจังจนยุติ ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
- ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาใหม่ที่อาจเกิดขึ้น
- สร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

๓. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

- พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ
- พัฒนากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงพร้อมเผชิญภัยคุกคาม
- พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม

๔. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช้ภาครัฐ

- สร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
- เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
- ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มีใช้ภาครัฐ

๕. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ

- พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ อย่างเป็นรูปธรรม
- บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ
- พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

๑. เพิ่มผลผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษารายได้เดิมและสร้างรายได้อีก
๒. เปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะความรู้ตามความต้องการของตลาด
๓. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูง ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
๕. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีทักษะและมีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน
๖. มีนวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ สินค้าและบริการ และกระบวนการผลิตและบริการ

ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

๑. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
๒. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีวินัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
๓. ปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
๔. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๕. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ สติปัญญา และสังคม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
๖. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวยุคใหม่และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ ใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาในการเสริมสร้างสุขภาวะ พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๑. การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
 - ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระจายการถือครองทรัพย์สิน โดยการปฏิรูประบบภาษี
 - สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
 - ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
 - กำหนดจังหวัดหลักที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
 - กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ
 - จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเตรียมรองรับสังคมสูงวัย
 - สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม
 - จัดตั้งกองทุนที่มีการระดมทุนร่วมระหว่างรัฐ เอกชน วิชาการ ประชาชนและประชาสังคม เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย
 - ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
 - เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
 - ปรับดุลอำนาจระหว่างประชาชนกับนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสร้างประชาธิปไตยระดับฐานรากชุมชน

ยุทธศาสตร์ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
 - เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
 - ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองให้ครอบคลุมแม่น้ำลำคลอง
 - รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 - ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
 - เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
 - ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
 - ลดพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
 - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย
 - มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
 - มีการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 - จัดทำแผนผังภูมินิเวศ
 - พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม
 - จัดการมลพิษ ขยะ น้ำเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - จัดให้มีองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน
๕. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - พัฒนาการจัดการน้ำทั้งระบบ
 - เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ
 - พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ
 - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

๖. ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศไทย
 - ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
 - พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม

ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย ทนต่อการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง
๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพในการพัฒนาประเทศ
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค ความเป็นกลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสาธารณสุข

วิสัยทัศน์(Vision) : เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ (Mission) : พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร (Core Values) :

M: Mastery คือ เป็นนายตนเอง

O: Originality คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่

P: People centered approach คือ ใส่ใจประชาชน

H: Humility คือ ถ่อมตนอ่อนน้อม

เป้าหมาย (Ultimate Goal) : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ตัวชี้วัดหลักระดับองค์กร (Corporate KPIs) :

๑) อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy: LE) ไม่น้อยกว่า ๘๕ ปี

๒) อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health Adjusted Life Expectancy: HALE) ไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

๓) ดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๔) ดัชนีสุขภาวะองค์กร (Happy Public Organization Index) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐

๕) อัตราการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย (Access ร้อยละ ๑๐๐

๖) ความครอบคลุม (Coverage) สัตว์ส่วนแพทย์ ๑ คน ต่อประชากร ๑,๕๐๐ คน และสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๒ ต่อประชากรพันคน

- ๗) มีคุณภาพ (Quality) โรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ร้อยละ ๑๐๐ และโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ ๙๐
- ๘) มีธรรมาภิบาล (Governance) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ใน ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาศาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพและการเสริมสร้างสุขภาวะ และสถานบริการสุขภาพและความงาม และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดย ต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางแพทย์ของภูมิภาคในระยะต่อไป ๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกัน สุขภาพ และ ๔) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ปรับ โครงสร้าง และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่ต้องอาศัยการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนาปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง ลดความซ้ำซ้อน รวมถึงเปิดโอกาส ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเหมาะสม

แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย

๑. ด้านการเมือง
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
๓. ด้านกฎหมาย
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม
๕. ด้านเศรษฐกิจ
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านสาธารณสุข
๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
๙. ด้านสังคม
๑๐. ด้านพลังงาน
๑๑. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีแผนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ๑ ด้าน ดังนี้

ด้านสาธารณสุข

หมวด ๖ แผนนโยบายแห่งรัฐ **มาตรา ๗๑** รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของสังคม จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และพัฒนาการเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และรัฐพึงส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และความสามารถสูงขึ้น และรัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง ให้การบำบัด พ้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระทำดังกล่าว และในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคำนึงถึงความจำเป็น และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการยกระดับ กระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ สนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปแบบมุ่งเป้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมและขยายผลงานวิจัยจากหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบัน อาชีวศึกษา ภาคเอกชน และองค์กรเกษตรกรที่มีส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูป ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป มูลค่าเพิ่มสูงที่มี ศักยภาพทางการตลาดในอนาคต

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ กำหนดแผนที่นำทางในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตภาคเกษตร และผลพลอยได้อื่น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม กระบวนการผลิต ที่หลากหลาย รวมทั้งการใช้คลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปสู่การผลิต สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ รณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีการตระหนัก เลือกใช้ และบริโภคสินค้าเกษตรและ เกษตรแปรรูปที่ปลอดภัย มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการมีการใช้สินค้าเกษตรและ สินค้าเกษตรแปรรูป ที่ได้คุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจากแบบอย่าง ความสำเร็จในประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการ ทาเกษตรยั่งยืนที่ตระหนักถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการขยายผลรูปแบบเกษตรกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ จัดให้มีการบริหาร อนุรักษ์ เพาะพันธุ์ เพาะเลี้ยง พื้นที่ป่าชายเลน ชายฝั่ง น้ำตื้น น้ำลึก และประมงพื้นบ้าน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ ขยายผลแบบอย่างความสำเร็จในการบริหารจัดการเพื่อผลิตสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน รวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ส่งเสริมและผลักดันการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ / ป่าเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ เร่งพัฒนาและฟื้นฟูระบบชลประทานและการกระจายน้ำในพื้นที่เขตชลประทาน และพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการจัดการตะกอนที่เหมาะสม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ ดำเนินการให้มีการจัดการตะกอนอย่างเหมาะสม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ บริหารจัดการและวางแผนการใช้น้ำอย่างเป็นระบบและสมดุลตลอดจนพัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า กลุ่มปศุสัตว์และประมง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อและจูงใจให้เอกชนลงทุนและ พัฒนาตลาดกลางภูมิภาค / ตลาดในชุมชน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ ผลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลราคาสินค้าเกษตรเปรียบเทียบระหว่างตลาดภูมิภาค และตลาดส่วนกลางอย่างเนื่อง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๓ พัฒนาความรู้และทักษะให้เกษตรกรสามารถซื้อขายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์ สินค้าเกษตร

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร แปรรูปที่เกษตรกรเข้าถึงได้

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๑ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันภัยสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลายและเหมาะสมกับรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๒ ดำเนินการให้มีการปรับลดต้นทุนการทำธุรกรรมของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๓ สนับสนุนบทบาทของเอกชนในการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๔ เจริญหรือทำข้อตกลงให้มาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทย เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๕ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ รวมถึงกระบวนการทดสอบ คุณภาพที่จำเป็น

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๑ สนับสนุนบทบาทสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร / วิสาหกิจชุมชน) ในฐานะหน่วยธุรกิจของเกษตรกร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและขนส่ง สินค้าเกษตร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๓ พัฒนาให้มีการจัดเก็บข้อมูลความสูญเสียในกระบวนการผลิตของภาคเกษตร (Farm Loss) สำหรับใช้เป็นฐานในการวัดในอนาคต

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต การเกษตร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๒ คุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรมที่มีศักยภาพและขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทำกิน

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๑ พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านเกษตรให้เชื่อมโยงกัน และเป็นข้อมูลเปิด

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับการเข้าถึงคลังข้อมูลต่าง ๆ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๑ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถเข้าถึงความมั่นคงอาหารทั้งด้านปริมาณและโภชนาการ ครอบคลุม รวมถึงระบบสำรองอาหาร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๒ เตรียมการบริหารจัดการการกระจายสินค้าเกษตรและอาหารในภาวะวิกฤต

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๑ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการฟาร์มและการดำเนิน ธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๒ ยกระดับความความเข้มแข็งและความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพิ่มมูลค่าของ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสนับสนุนบทบาทภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในพื้นที่

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๓ ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงและเอื้อกับการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาโลกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ นักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๒.๑ สนับสนุนบทบาทขององค์กรหรือสภาเกษตรกรในกลไกความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการในแต่ละจังหวัด
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๒.๒ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับสถาบันเกษตรกร และ เกษตรกรในรูปแบบธุรกิจต่างๆ

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดโมเดลอารมณดีมีความสุข
ในแผนการปฏิรูป ประเทศด้านเศรษฐกิจ ฉบับปรับปรุง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวคุณภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งและบริการการท่องเที่ยวคุณภาพในพื้นที่เมืองรองที่มี ศักยภาพและกระจายเส้นทางท่องเที่ยวให้หลากหลายอย่างทั่วถึง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในเมืองรอง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมให้เอกชนมีความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ของชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ ตลาดสากล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ สนับสนุนการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ สนับสนุนให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวเข้า “กองทุนเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวไทย”

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ยกระดับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้บุคลากรภาคการท่องเที่ยวและบริการ ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของภาครัฐและมีการขึ้นทะเบียนแรงงานภาคการท่องเที่ยวอย่างถูกต้อง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ กำหนดแนวปฏิบัติตนที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากร และนักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล่าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและ การขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบด้านงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เอื้อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการลงทุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนและภาครัฐ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ ปรับปรุงข้อกำหนดของกฎหมาย และลดขั้นตอนกฎระเบียบที่ล่าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการขอใบอนุญาตของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๓ ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๑ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเป็นเอกภาพ น่าเชื่อถือ และทันสมัย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๒ สนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของภาครัฐและเอกชน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการท่องเที่ยว และบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในระบบขนส่งสาธารณะ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการมหาชน ในทุกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ สนับสนุนให้ประชาชนดัดแปลงรถยนต์เก่าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ยานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์

กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ สนับสนุนการขยายตลาดยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการรักษาฐานการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความสามารถในการทำตลาดในประเทศคู่ค้าหลักของไทย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่

กลยุทธ์ที่ ๓ การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ ๕ ปี

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ส่งเสริมการผลิตยานยนต์ที่มีคุณสมบัติ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย”

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงชิ้นส่วนสำคัญ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ ส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๕ ส่งเสริมให้สุดยอดผลิตภัณฑ์ (Product Champion) ของประเทศไทย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๖ รักษาความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่ยังมีความสามารถในการทำตลาดและยังไม่สามารถพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าในระยะเวลาอันสั้น
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๗ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดิมที่มีศักยภาพให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่สายการผลิตของยานยนต์ไฟฟ้าได้
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๘ ศึกษาแนวทางการกำจัดซากรถยนต์ และซากชิ้นส่วนยานยนต์ที่ใช้แล้วในประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและไม่กระทบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ กำหนดสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนด้านการเงิน ด้านภาษี
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ ส่งเสริมการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าในรถเก่า
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๕ ส่งเสริมการร่วมทุนหรือการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ

กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของรถยนต์สันดาป ภายในที่ต้องการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอื่น
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ กำหนดมาตรการเยียวยาให้ผู้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๑ จัดตั้งกิจการร่วมด้านการวิจัยและนวัตกรรม
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๒ ส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของภาครัฐที่สร้างขึ้น
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๓ ส่งเสริมงานวิจัยและการจัดทำระเบียบรองรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ปลอดภัยเป็นศูนย์และระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติ การเชื่อมต่อ การปรับให้เป็นระบบไฟฟ้าและการแบ่งปันกันใช้งาน

กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๑ ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาจุดอัดประจุหรือเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและกิจกรรมประจำวันของผู้ใช้รถ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพที่จะรองรับปริมาณความต้องการการประจุไฟได้เพียงพอตลอดเวลา
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๓ ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านสมาร์ตกริด

กลยุทธ์ที่ ๘ การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เอื้อกับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๑ จัดทำและปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๒ ผ่อนคลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๘.๓ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๑ พัฒนาบุคลากรรองรับยานยนต์ไฟฟ้า เยียวยากำลังคนรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๒ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและสถานศึกษา

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๙.๓ กำหนดแนวทางดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๑ กำหนดและพัฒนามาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๒ กำหนดมาตรฐานสำคัญเพื่อส่งเสริมให้เกิดการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๓ จัดทำแผนพัฒนาด้านมาตรฐานให้กับสถานประกอบการยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๔ พัฒนาและต่อยอดศูนย์ทดสอบและยางล้อแห่งชาติ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๕ กำหนดมาตรฐานและหน่วยงานให้การตรวจสอบรับรองสำหรับยานยนต์ที่ดัดแปลงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๖ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนศูนย์ทดสอบในประเทศ ในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและระดับมาตรฐานผู้ผลิตยานยนต์ ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าและการบริหารคุณภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๐.๗ จัดทำมาตรฐานที่สำคัญ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๑ สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑๑.๒ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเขียวและธุรกิจหมุนเวียน

หมวดหมู่ที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ สนับสนุนให้ภาคเอกชนยกระดับบริการทางการแพทย์บนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยภาครัฐกำหนดมาตรฐาน สนับสนุนและกำกับดูแล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ

กลยุทธ์ที่ ๒ ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ นวัตกรรมในบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพบนฐานความโดดเด่นของเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ยกระดับมาตรฐานสถานบริการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถแข่งขันได้
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพรูปแบบใหม่ที่น่าไปสู่การสร้างสังคมสูงวัยที่มีสุขภาวะ

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการยกระดับอุตสาหกรรม
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปฏิรูประบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ส่งเสริมการลงทุนและการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพออกสู่ตลาด
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ ส่งเสริมแนวคิดการซื้อและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาทางการแพทย์
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาศูนย์ข้อมูลและการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ สร้างระบบนิเวศการวิจัยให้เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๕ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ บริหารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ พัฒนากลไกกำกับดูแลและบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริการทางการแพทย์

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบต่องานบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๑ ปฏิรูประบบเฝ้าระวังและบริหารจัดการโรคระบาดและภัยคุกคามสุขภาพ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๒ วางระบบการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงด้านสุขภาพในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

หมวดหมู่ที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ของภูมิภาค

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ รักษาความสมดุลกับมิตรประเทศ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ วางบทบาทของไทยในการนำกลุ่มประเทศ CLMVT
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ ปรับปรุงกลไกสนับสนุนการสร้างฐานเศรษฐกิจในบริบทโลกใหม่
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ พัฒนากฎหมายและแนวปฏิบัติที่ยกระดับไทยสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญ

ของภูมิภาค

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนพื้นที่ที่มีศักยภาพและเขตพัฒนาพิเศษทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงไร้รอยต่อตั้งแต่ระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน ให้เป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation)
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ให้ความสำคัญกับการขนส่งระบบรางอย่างต่อเนื่อง
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำนํ้า
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการค้าการลงทุน
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ สนับสนุนให้มีแผนการลงทุนพัฒนาศูนย์บริการโลจิสติกส์
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๗ สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
- #### กลยุทธ์ที่ ๓ ผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ เร่งรัดการปรับการผลิตมาสู่ระบบอัตโนมัติมากขึ้นทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกส์
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกส์ให้เข้าแนวทาง BCG มาใช้เป็นมาตรฐาน
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ สร้างระบบดิจิทัลที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน
 - กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ พัฒนาศูนย์กลางสู่มาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

หมวดหมู่ที่ ๖ ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาบริการและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรวมถึงนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและ ความสามารถในการทำกำไรให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะของภาครัฐเพิ่มขึ้น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีพ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาเป็นผู้รับจ้างผลิตและผู้รับจ้างออกแบบและผลิตขั้นสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์ (Product Champion)

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ พัฒนามาตรฐานและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นสากล รองรับการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐและระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและภูมิภาค

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ ดึงดูดและพัฒนาให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุมเพียงพอและเข้าถึงได้ ทั้งในด้านพื้นที่ และราคา

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับกับการปรับตัวทางเทคโนโลยีในอนาคตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและบริการต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ ผลักดันและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องมือทางนโยบายทางการเงินและการคลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละอุตสาหกรรม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๕ ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนด้านนโยบายความเป็นเจ้าของอาชีพไทยทางข้อมูลจากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ทำธุรกิจจากคนไทย

หมายเหตุที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ แข่งขันได้

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับผู้ประกอบการรายใหญ่

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ เพิ่มความสะดวกในทุกขั้นตอนของการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบมาตรฐานให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ด้วยต้นทุนต่ำ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ จัดให้มีระบบไอทีเดียวของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ในการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาพอร์ทัลกลางเชื่อมโยงข้อมูลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ากับระบบการให้บริการภาครัฐ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและความรู้สำหรับให้บริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบออนไลน์และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ส่งเสริมให้สถาบันการเงินหรือธนาคารและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ใช้ข้อมูลธุรกิจและรอยเท้าดิจิทัลในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ กำหนดบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้มีมาตรการการสินเชื่อและการค้ำประกันสินเชื่อที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเซกเมนต์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ส่งเสริมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมระดมทุนผ่านตลาดทุนหรือแหล่งทางเลือกที่หลากหลาย สอดรับกับโมเดลธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ เสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการลงทุนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในการบริหารจัดการ การยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการให้บริการ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ พัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วไปเข้าถึงได้

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในสาขาและกับรายใหญ่ภายในห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ ขยายการให้บริการพัฒนาธุรกิจ ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ และพัฒนาระบบส่งต่อการให้ความช่วยเหลือ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ สนับสนุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในฐานะหน่วยงานนโยบายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บูรณาการการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างครบวงจร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๓ ปรับกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๑ ปรับปรุงกฎหมายและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสตาร์ทอัพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๒ ผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการระดมทุน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๖.๓ ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ตลาดโลก

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๑ เร่งออกกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๒ ส่งเสริมการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและยั่งยืนของวิสาหกิจเพื่อสังคม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๗.๓ ให้สิทธิประโยชน์และสิ่งจูงใจให้เกิดการร่วมทุนกับวิสาหกิจเพื่อสังคม

หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาภาคให้ป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนกลยุทธ์ย่อยที่

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ ส่งเสริมการจัดการกลไกตลาดของท้องถิ่น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ แก้ปัญหาของกลุ่มเปราะบางในเมือง

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมือง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่และเมืองด้วยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมืองร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติรวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมือง

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและเมือง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพียงพอ และได้มาตรฐาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีคุณภาพเพียงพอและปรับตัวได้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายในพื้นที่

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุน

กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ เสริมสร้างสมรรถนะของท้องถิ่นทุกระดับ ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการพื้นที่และเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกระดับความสามารถทางการเงิน การคลังและการจัดการทุนในระดับพื้นที่
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ สร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพื้นที่และเมือง

หมวดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอ เหมาะสม

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนากลไกการแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นในระดับพื้นที่

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ สนับสนุนครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นให้สามารถเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อสร้างหลักประกันสำหรับวัยแรงงาน
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ ยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ บูรณาการระบบความคุ้มครองทางสังคม
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ปรับปรุงรูปแบบการจัดความคุ้มครองทางสังคม
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ จัดทำระบบการเยียวยาช่วยเหลือในภาวะวิกฤต

กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ พัฒนาฐานข้อมูลรายบุคคล
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล

หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและบริการ โดยการพัฒนาสินค้า บริการและตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ สร้างความเชื่อมโยงกับสาขาเศรษฐกิจอื่น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าและบริการ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ การใช้เครื่องมือและกลไกในตลาดเงินตลาดทุนเพื่อการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ เพิ่มรายได้ชุมชนจากแนวทางขยะสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งจากขยะและวัสดุทางการเกษตร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดคาร์บอนเพื่อการสร้างรายได้จากการเก็บกักคาร์บอนในภาคป่าไม้

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในระดับชุมชน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๕ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๖ พัฒนาระบบและกลไกสร้างแรงจูงใจการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๓ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ สร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตให้เพียงพอและมีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากส่วนเหลือให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลายปราศจากเศษเหลือและของเสียจากอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และขยะอาหาร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ บริหารจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบโมเดลธุรกิจ และกลไกความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบวงจร

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลดและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรและเพิ่มมูลค่าของเสีย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๔ ส่งเสริมเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๕ สร้างความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีกับต่างประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๖ พัฒนาระบบข้อมูล/องค์ความรู้/มาตรฐาน/กฎหมาย/มาตรการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ สร้างความตระหนักรู้ให้เกิดในสังคม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ สร้างแรงจูงใจ และทัศนคติในการดำรงชีวิตของผู้บริโภคเพื่อการปรับเปลี่ยน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๓ ส่งเสริมแพลตฟอร์มเศรษฐกิจแบ่งปันและตลาดสินค้ามือสอง
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๔ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและนวัตกรรมประหยัดพลังงานในครัวเรือน
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๕ ส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๖ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่สำคัญ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ส่งเสริมการใช้มาตรการเชิงป้องกันก่อนเกิดภัยในพื้นที่สำคัญ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ระบุพื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกตามประเภทภัย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ ทบทวนการจัดสรรงบประมาณ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ นำแบบจำลองระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชน ในการรับมือกับภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความเสี่ยงและปรับตัวรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและชุมชนในการรับมือและปรับตัวต่อภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ เพิ่มศักยภาพของประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๔ สนับสนุนมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ สนับสนุนการสร้างบุคลากร นักวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยด้านภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาประสิทธิภาพของระบบเตือนภัย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๓ พัฒนาระบบข้อมูลสำหรับการจัดทำแบบจำลองระดับชาติเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๔ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ ภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบ จากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกระดับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ เพิ่มบทบาทภาคประชาชน ชุมชน และภาคเอกชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๓ สนับสนุนการใช้แนวทางธรรมชาติในการจัดการปัญหาภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๑ พัฒนากลไกความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการภัยธรรมชาติ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๕.๒ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ในด้านภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต
กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ พัฒนาเด็กช่วงตั้งครรภ์ถึงปฐมวัยให้ มีพัฒนาการรอบด้าน มีอุปนิสัยที่ดี โดยการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครองและสร้างกลไกประสานความร่วมมือ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ พัฒนาผู้เรียนระดับพื้นฐานให้มีความตระหนักรู้ในตนเอง มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงาน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๓ พัฒนาผู้เรียนระดับอุดมศึกษาให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเชื่อมโยง กับโลกของการทำงานในอนาคตและการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดสรร ทรัพยากรให้เป็นไปตามอุปสงค์

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๔ พัฒนายัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการประกอบอาชีพ และเชื่อมโยงกับโลกของการทำงานในอนาคต โดย ส่งเสริมและกระจายโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะ ให้กับแรงงานทุกกลุ่ม

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๕ พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นพลเมืองมีคุณค่าของสังคม โดยพัฒนา ผู้สูงอายุให้เป็นพลังของสังคม

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการและเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านการศึกษาฝึกอบรม และร่วมจัดการเรียนรู้

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ เพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาภาคการผลิตเป้าหมาย โดยสร้างกลไกระดับชาติเพื่อรวบรวมกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการผลิตและบริการ การจัดการและการตลาด โดยการสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้รอบด้านที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจยุคใหม่

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ พัฒนาทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเรียนในระบบการศึกษาปกติ

หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

กลยุทธ์การพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๑ ยกเลิกภารกิจการให้บริการที่สามารถเปิดให้ภาคส่วนอื่นให้บริการแทน

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ ทบทวนกระบวนการทำงานของภาครัฐควบคู่กับพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๑ ทบทวนบทบาทภาครัฐและกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๒ สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ

กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๑ ปรับเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นดิจิทัล

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๓.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐเป็นดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๑ ปรับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีศักยภาพมาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

- กลยุทธ์ย่อยที่ ๔.๒ ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นและพัฒนากฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ความเชื่อมโยงของหมวดหมู่กับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ และยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพสูงจะสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก ๔ ประการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยการใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและจัดบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงทางด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม ในการลดผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขของคนไทย เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ในการวางแผนทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นเป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ที่กำหนดอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่อาศัยความเชี่ยวชาญ ด้านการแพทย์ของไทย สร้างอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระดับสากล รวมทั้ง เชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ในประเด็นเป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ๒๐ปี

ความสอดคล้องของแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขมีความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ใน ๔ ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการ พัฒนาสาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพที่สอดคล้องกับบริบทโลกในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจบริการสุขภาพ และการเสริมสร้างสุขภาวะ สถานบริการสุขภาพและความงาม และการส่งเสริมธุรกิจบริการทางการแพทย์ โดยต้องมีการลงทุนอย่างจริงจังในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ รวมทั้งมาตรฐานการบริการ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้เอง ซึ่งจะเป็นการสร้างฐานที่เข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลางบริการทางแพทย์ของภูมิภาค ในระยะต่อไป ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบคลุมการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาระบบบริหารจัดการหลักประกัน สุขภาพ และยุทธศาสตร์การปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยทบทวนบทบาทภารกิจ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งถ่ายโอนภารกิจที่สำคัญเพื่อกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานพิเศษที่ต้องอาศัยการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างและระบบราชการแบบเดิม และพัฒนาปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง ลดความซ้ำซ้อน รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างเหมาะสม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๓ (SDGs)

จากการทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ ๑๓ เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้

เป้าหมายที่ ๑

ภายในปี ๒๕๗๓ ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า ๗๐ ต่อการเกิดมีชีพหนึ่งแสนคน ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้ว มีค่าเท่ากับ ๒๐ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (World Bank) และ สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ เท่ากับร้อยละ ๙๙.๖ (World Bank)

เป้าหมายที่ ๒

ภายในปี ๒๕๗๓ ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกถึง ๑๒ คน ต่อ การเกิดมีชีพพันคน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ลงให้ต่ำถึง ๒๕ คน ต่อการเกิดมีชีพพันคน พบว่า มีอัตราการลดลง ในปี ๒๕๕๘ อัตราการตายใน เด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี เท่ากับ ๑๒.๓ คน และ อัตราการตายของทารกแรกเกิดเท่ากับ ๖.๗ คน (World Bank)

เป้าหมายที่ ๓

ภายในปี ๒๕๗๓ ยุติการแพร่กระจายของเอชไอวี วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ พบว่า

๑. UNAIDS คำนวณอัตราการผู้ป่วย HIV รายใหม่ต่อแสนประชากรที่ไม่ติดเชื้อของประเทศไทย อยู่ระหว่าง ๐.๐๖ – ๐.๑๖

๒. ข้อมูลคาดการณ์โดย WHO : Global Tuberculosis Database จะมีอัตราผู้ป่วยวัณโรค รายใหม่ต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๑๗๒

๓. WHO คำนวณอัตราการผู้ป่วยโรคมาลาเรียรายใหม่ต่อประชากรพันคน เท่ากับ ๒.๖๕

๔. WHO : Global Health Observatory (GHO) , Preventive Chemotherapy and Transmission control (PCT) Databank ประมาณค่าจำนวนผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อการป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical diseases) จากข้อมูลที่ส่งให้เท่ากับ ๑๔๕,๑๔๑ คน

๕. ข้อมูลอัตราผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีอัตราผู้ป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๑๐.๑๖ ยังไม่มีรายงานหรือการคาดการณ์จาก WHO

เป้าหมายที่ ๔

ภายในปี ๒๕๗๓ เป้าหมายที่ ๔ ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี พบว่า ในปี ๒๕๕๕ WHO : Global Health Estimates ๒๐๑๓: Deaths by Cause, Age and Sex, by Country, ๒๐๐๐-๒๐๑๒. Geneva, World Health Organization, ๒๐๑๔. ประมาณการณ์อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังต่อประชากร (๓๐ – ๗๐ ปี) แสนคนเท่ากับ ๑๖.๒๔ และอัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ ๑๕.๙๙ อัตราการเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า ในประชากรไทยอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรคัดกรองโรคซึมเศร้า ได้แก่ ผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ที่ตั้งครรภ์หรือหลังคลอด และผู้ที่มีปัญหาสุรา สารเสพติด เป็นต้น

เป้าหมายที่ ๕

เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ ยาเสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย พบว่า ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษา โดยใช้ยาทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ใช้สารเสพติด ผลการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด จะเห็นได้ว่าระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ระบบบำบัดแบบสมัครใจมีอัตรา ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๔, ๗๓.๖๗ และ ๖๙.๔๕ ตามลำดับ ระบบบำบัดแบบบังคับบำบัดมีอัตราสูงขึ้นคิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๐๙, ๒๕.๙๒ และ ๓๐.๔๐ ตามลำดับ และระบบบำบัดแบบต้องโทษมีอัตราลดลงคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗, ๐.๔๑ และ ๐.๑๕ ตามลำดับ โดยร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือน หลังจำหน่ายจากการ บำบัดรักษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๘, ๘๗.๖๓ และ ๘๘.๙๐ ตามลำดับ การใช้แอลกอฮอล์ในทาง อันตราย นิยามตามบริบทของประเทศ คิดเป็นปริมาณแอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค (อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป) ในจำนวนประชากรของแอลกอฮอล์บริสุทธ์ ภายในปีปฏิทิน พบว่า ในปี ๒๕๕๓ ข้อมูลจาก Global Status Report on Alcohol and Health ๒๐๑๔ เท่ากับ ๗.๑ ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธ์ต่อคนต่อปี

เป้าหมายที่ ๖

ภายในปี ๒๕๗๓ ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง พบว่า อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๕ ข้อมูลจากการรายงาน WHO ประมาณค่าเท่ากับ ๓๖.๒ ต่อแสนประชากร และในประเทศไทยอัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนเท่ากับ ๒๒.๓ ต่อแสนประชากร (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๘, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)

เป้าหมายที่ ๗

ภายในปี ๒๕๗๓ การสร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และแผนงานระดับชาติ พบว่า ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (๑๕ - ๔๙ ปี) ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ จากข้อมูลการสำรวจ Thailand ๒๐๑๒ Multiple Indicator Cluster Survey พบร้อยละการคุมกำเนิดในสตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุ ๑๕ - ๔๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่ากับร้อยละ ๘๙.๒ อัตรา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (๑๐-๑๔, ๑๕-๑๙ ปี) ต่อผู้หญิงพันคนในแต่ละกลุ่มอายุที่กำหนดไว้ จากข้อมูลการ สำรวจ Thailand ๒๐๑๒ Multiple Indicator Cluster Survey มีผลเท่ากับร้อยละ ๖๐ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

เป้าหมายที่ ๘

บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทาง การเงิน การเข้าถึง การบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัย มี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ พบว่า ความทั่วถึงของการติดตามการรักษา (เช่น การ ฉีดวัคซีนแบบเต็มรูปแบบในเด็ก การรักษาด้วยยาต้านไวรัส การรักษาวัณโรค การรักษาความดันโลหิตสูง การดูแล การคลอดโดยผู้ชำนาญ) ในปี ๒๕๕๘ ร้อยละของประชากรในทุกภาคส่วนที่มีสิทธิประกันสุขภาพ ร้อยละ ๙๙.๘๑ ในปี ๒๕๕๖ ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนแบบครบถ้วน (EPI program) ร้อยละ ๙๐.๓ - ๑๐๐ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ ๗๘.๔๗ เทียบกับเป้าหมาย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์เข้าถึง ยาต้านไวรัส ร้อยละ ๗๙.๘๙ เทียบกับผู้ป่วยลงทะเบียนสะสม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและ/หรือหัตถการ Primary PCI ร้อยละ ๗๒.๓๓ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตัน เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดได้ ร้อยละ ๔.๑๙ จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนปี ๒๕๕๖ ทำการสำรวจโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ ข้อมูลเส้นความยากจนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ พบว่า อุบัติการณ์ของครัวเรือนที่ต้องกลายเป็น ครัวเรือนยากจนหลังจากการจ่าย ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็น ร้อยละ ๐.๔๗ ของครัวเรือนทั้งหมด

เป้าหมายที่ ๙

ภายในปี ๒๕๗๓ ลดจำนวนการตายและการป่วยจากสารเคมีอันตรายและ จากการปนเปื้อน และมลพิษทางอากาศ น้ำ และดิน ให้ลดลงอย่างมาก พบว่า อัตราการตายในครัวเรือนและ มลพิษทางอากาศต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลในปี ๒๕๕๖ ประมาณค่าเท่ากับ ๖.๔๘ ต่อแสนประชากร อัตราการตายเนื่องจากสารเคมีอันตราย มลภาวะในน้ำและในดิน และการปนเปื้อนต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลในปี ๒๕๕๘ WHO ประมาณการณ์ไว้เท่ากับ ๑.๘๗ ต่อแสนประชากร และ อัตราการเสียชีวิตจากการได้รับ สารพิษ อันตรายและมลพิษที่เจือปนในสิ่งแวดล้อมต่อแสนประชากร จากข้อมูลในปี ๒๕๕๘ WHO ประมาณการณ์ไว้ เท่ากับ ๐.๕๓ ต่อแสนประชากร

เป้าหมาย a เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม พบว่า ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของผู้ที่สูบบุหรี่ ใน ปัจจุบันในจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป พบว่า พ.ศ. ๒๕๕๘ อัตราสูบเป็น ๒๑.๕

เป้าหมาย b สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนและยาสำหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นในราคาที่สามารถซื้อ หาได้ ตามปฏิญญาโตฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าและการ สาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำสิทธิสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่จะใช้ขบัตถุญติในความตกลงว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า อย่างเต็มที่ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะ และโดยเฉพาะการเข้าถึงยา โดยถ้วนหน้า สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยา และวัคซีน ในราคาที่สมารถ หาซื้อได้ที่ตั้งอยู่บนหลักความยั่งยืน พบว่า กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นว่าวัคซีน เป็นเครื่องมือ หนึ่งในการควบคุมป้องกันโรคที่มี ประสิทธิภาพสูงที่สุด กระบวนการพัฒนาและผลิตวัคซีนใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง มีความยุ่งยากซับซ้อน มีการควบคุม คุณภาพเข้มงวด ใช้เวลานาน จึงทำให้ต้นทุนสูง จำนวน ผู้ประกอบการจึงมีน้อย ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งผลิตวัคซีนสำหรับประเทศที่มีกำลัง ซื้อสูง และหยุด/ลดการผลิต หรือไม่จำหน่ายวัคซีนให้แก่ ประเทศที่มีกำลังซื้อต่ำ ประเทศกำลังพัฒนา เช่น ประเทศไทยยังผลิตวัคซีนใช้เองได้น้อย (วัคซีนสมัยใหม่) กอปร กับมีปัญหางบประมาณ และอื่นๆ อีกหลาย ด้านในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน จึงเกิดการขาดแคลน หรือได้รับวัคซีน ไม่ทันเวลา ทั้งในภาวะปกติและภาวะ ฉุกเฉิน ทำให้มีความมั่นคงด้านวัคซีนน้อย (Vaccine security) ในส่วนของ ยาเคมี ประเทศไทยยังไม่พร้อม ในการเป็นประเทศวิจัยพัฒนายาใหม่ อุตสาหกรรมยาในประเทศ ส่วนใหญ่เป็น การผลิตยาสามัญ และกำลัง เผชิญกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะชะลอการผลิตยาสามัญ ทดแทนยาต้นแบบที่ ผูกขาดในตลาด และ ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ ยาต้นแบบที่พัฒนาขึ้นจากต่างประเทศมีราคาแพง กลไกในการควบคุม ราคา และการใช้สิทธิตามปฏิญญาโตฮายังมีข้อจำกัด และเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่าง เป็นทางการ สุทธิรวม (Total net official development assistance-ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์

และด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน พบว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เท่ากับ ๓๒.๙๒ จากข้อมูล Based on OECD, CRS databased, ๒๐๑๖ และ Gross disbursements. Constant ๒๐๑๔ USD million

เป้าหมาย c การเพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก พบว่า จากข้อมูล WHO : Global Health Workforce Statistics database, Global Health Observatory ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสุขภาพต่อพัน ประชากร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เท่ากับ ๒.๔๗

เป้าหมาย d เสริมขีดความสามารถสำหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศและระดับโลก พบว่า ร้อยละของคุณลักษณะความสามารถหลัก ๑๓ ประการที่ได้บรรลุแล้วใน ช่วงเวลานั้น ๆ จากข้อมูล World Health Organization ของประเทศไทยรายงานผลไว้ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เท่ากับ ๙๗.๘๐

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) กับ แผนที่น่าสนใจขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence) กระทรวงสาธารณสุขใช้มาตรการ PIRAB จากที่ประชุมกฎบัตรกรุงเทพ (Bangkok Charter) ได้ประกาศให้ ทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ (Sector & Setting) นำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมสุขภาพ ในการประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ ๖ ที่กรุงเทพมหานคร โดย PIRAB ประกอบด้วย

P : Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคส่วน ทุกระดับ ให้เห็นความสำคัญและร่วมกันทำงานส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน โดยเฉพาะการกำหนดเรื่องสุขภาพเป็นประเด็นสำคัญในทุกนโยบายสุขภาพ (Health in All Policy)

I : Invest กระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่เพียงพอจากระดับนโยบายในทุก ภาคส่วนเพื่อจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ

R : Regulate and Legislate ใช้การตรากฎและออกกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนจากความ เสี่ยง ต่อสุขภาพทุกด้าน

A : Advocate ชี้นำ ชูประเด็น และสนับสนุนให้การเมืองทุกระดับให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม สร้างการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน

B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนานโยบายทุกด้านที่เกี่ยวข้อง กับสุขภาพ รวมทั้งการวิจัย การกระจายความรู้เพื่อความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายตัวสามารถนำมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

โครงการที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

เป้าประสงค์ ๓.๑ ลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลกให้ต่ำกว่า ๗๐ ต่อการเกิดมีชีพ ๑ แสนคน ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชำนาญ
โครงการที่ ๒ พัฒนาคุณภาพและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
เป้าประสงค์ ๓.๗ สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริการ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัย เจริญ
พันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัว และการผสานอนามัยเจริญพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๗.๑ ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ (๑๕-๔๙ ปี) ที่พึงพอใจกับการวางแผน
ครอบครัว ด้วยวิธีสมัยใหม่

ตัวชี้วัดที่ ๓.๗.๒ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ (๑๐-๑๔ ปี, ๑๕-๑๙ ปี) ต่อผู้หญิงอายุ (๑๐-๑๔
ปี , ๑๕-๑๙ ปี) ๑,๐๐๐ คน

แผนงานที่ ๒ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โครงการที่ ๑ ควบคุมโรคติดต่อ

เป้าประสงค์ ๓.๓ ยุติการแพร่กระจายของเอชไอวี วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยและ
ต่อสู้กับโรคดื้อยาต้านจุลชีพ โรคติดต่อทางน้ำ และโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๑ จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากรที่ไม่มีการติดเชื้อ ๑,๐๐๐ คน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๒ อัตราการเกิดโรควัณโรคต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๓ อัตราการเกิดโรคมาลาเรียต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน ต่อปี

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๔ อัตราผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๓.๕ จำนวนผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือต่อการป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย

โครงการที่ ๒ ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ

เป้าประสงค์ ๓.๖ ลดจำนวนการตายและบาดเจ็บทางถนนทั่วโลกครึ่งหนึ่ง ภายในปี ๒๕๖๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๖.๑ อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (จำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทาง
ถนน ในช่วงระยะเวลา ๓๐ วัน ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน (อายุมาตรฐาน))

ตัวชี้วัดที่ ๓.d.๑ ปริมาณของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations :
IHR) และการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ

แผนงานที่ ๓ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โครงการที่ ๒ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ

เป้าประสงค์ ๓.๕ เสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยา
เสพติดในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕.๑ ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยา ทางจิตวิทยาและการฟื้นฟู
สมรรถภาพ และบริการการติดตามผลการรักษา) สำหรับผู้ใช้สารเสพติด

ตัวชี้วัดที่ ๓.๕.๒ การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตราย นิยามตามบริบทของประเทศ คิดเป็น
ปริมาณ แอลกอฮอล์ต่อผู้บริโภค(อายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป) ในจำนวนลิตรของแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ ภายในปี
ปฏิทิน

เป้าประสงค์ ๓.a เสริมการดำเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ ๓.a.๑ ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันในจำนวนผู้สูบบุหรี่ที่
มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป แผนงานที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ ๑ คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot Zone)

เป้าประสงค์ ๓.๙ ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำและดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๙.๑ อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรือนและในบรรยากาศ

ตัวชี้วัดที่ ๓.๙.๒ อัตราการตายที่เกิดจากน้ำ สุขอนามัย ที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุขลักษณะ (การเปิดเผยบริการชะล้างที่ไม่ปลอดภัย) (อัตราการตายเนื่องจากสารเคมีอันตราย มลภาวะในน้ำและในดิน และการปนเปื้อน)

โครงการที่ ๒ บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ ๓.๙ ลดจำนวนการตายและการเจ็บป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากมลพิษและการปนเปื้อนทางอากาศ น้ำและดิน ให้ลดลงอย่างมาก ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๙.๓ อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ตั้งใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

กระทรวงสาธารณสุขใช้กรอบแนวคิด ระบบสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO Health System Framework) โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวระบุ ผลลัพธ์ของ ระบบสุขภาพที่สำคัญ คือ การเข้าถึง ความครอบคลุม คุณภาพและความปลอดภัย และผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้จะทำให้ประชาชนมีสุขดีขึ้นแล้ว ยังต้องมีประสิทธิภาพ สร้างความเป็นธรรม ปกป้องคุ้มครองความเสี่ยง ทั้งด้านสังคมและการเงิน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วย โดยระบบสุขภาพที่จะ บรรลุถึงเป้าหมายเหล่านี้ได้ จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอย่างน้อย ๖ ประการ (six building blocks) ได้แก่ ๑) การให้บริการ ๒) บุคลากรด้านสุขภาพ ๓) สารสนเทศ ๔) ผลลัพธ์ทางการแพทย์ วัคซีน และ เทคโนโลยี ๕) การเงิน ๖) ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาล เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายตัวสามารถนำมาเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดังนี้

แผนงานที่ ๖ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

โครงการที่ ๔ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

เป้าประสงค์ ๓.๒ ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกถึงให้ต่ำถึง ๑๒ คน ต่อ การเกิดมีชีวิต ๑,๐๐๐ คน และลดอัตราการตายในเด็ก อายุต่ำกว่า ๕ ปี ลงให้ต่ำถึง ๒๕ คน ต่อการเกิดมีชีวิต ๑,๐๐๐ คน ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ อัตราการตายของทารกอายุต่ำกว่า ๕ ปี (อัตราการตายต่อการเกิด ๑,๐๐๐ คน)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒ ตัวชี้วัดอัตราการตายของทารกแรกเกิด (การตายต่อการเกิด ๑,๐๐๐ คน) โครงการที่ ๗ พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

เป้าประสงค์ ๓.๔ ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔.๒ ตัวชี้วัดอัตราการฆ่าตัวตาย

โครงการที่ ๑๐ พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรคหัวใจ และสาขาโรคมะเร็ง

เป้าประสงค์ ๓.๔ ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสาม ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค และสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี ภายในปี ๒๕๗๓

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔.๑ อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือโรคระบบทางเดินหายใจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคผลิตและพัฒนาบุคลากร การปรับ ระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข การสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศ (excellence) ในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งมีความสุข โดยเน้นงานด้าน human resource planning, human resource development และ human resource management เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายตัวสามารถนำมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ดังนี้

แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ

โครงการที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคน

เป้าประสงค์ ๓.๐.1 เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และการสรรหา การพัฒนา การฝึกฝน และการเก็บรักษากำลังคนด้านสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลัง พัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก

ตัวชี้วัดที่ ๓.๐.๑ ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

การพัฒนาระบบ บริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นหนักด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศ (information technology) ที่ทันสมัย ระบบการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายตัวสามารถนำมาเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ที่ ๓ ดังนี้

แผนงานที่ ๑๔ การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ โครงการที่ ๑ ลดความเหลื่อมล้ำของ ๓ กองทุน

เป้าประสงค์ ๓.๑ บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๑ อัตราความครอบคลุมของบริการด้านสุขภาพที่จำเป็น (นิยามความครอบคลุมของบริการที่จำเป็นเฉลี่ยโดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วย การเจริญพันธุ์ มารดา เด็กเกิดใหม่และสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึงบริการระหว่างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส (ความทั่วถึงของการ ติดตามการรักษา (เช่น การฉีดวัคซีนแบบเต็มรูปแบบในเด็ก, การรักษาด้วยยาต้านไวรัส การรักษาวัณโรค การรักษา ความดันโลหิตสูง, การดูแลการคลอดโดยผู้ชำนาญ)

ตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๒ จำนวนประชากรที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยหรือระบบสาธารณสุขต่อประชากร ๑,๐๐๐ คน

เป้าประสงค์ ๓.๒ บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำเป็นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจำเป็นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๑ สัดส่วนของประชากรที่เข้าถึงยาและวัคซีน ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ที่ตั้งอยู่บนหลักความยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ ๓.๒.๒ เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการสุทธิรวม (Total net official development assistance-ODA) ต่อการวิจัยทางการแพทย์และด้านสุขภาพขั้น พื้นฐาน

นโยบายรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกรัฐมนตรี แลงเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
ระยะสั้น

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

๑. เติมเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ผ่าน Digital wallet

๒. นโยบายเร่งด่วน

๑. แก้ปัญหาหนี้สิน พักหนี้เกษตรกร - ประคองภาระหนี้สิน SMS ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙
๓. ลดภาระค่าพลังงาน ไฟฟ้า - ก๊าซหุงต้ม-น้ำมัน
๔. เร่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๕. มีรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น
๖. พื้นฟูหลักนิติธรรมที่น่าเชื่อถือ

ระยะกลาง-ยาว

สร้างรายได้

๑. เปิดประตูการค้า เจรจา FTA ยกระดับ Passport ไทย
๒. พัฒนาเศรษฐกิจใหม่
อุตสาหกรรมสีเขียว-เทคโนโลยีขั้นสูง
ส่งเสริมสตาร์ทอัพ และลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของประเทศ
๓. สร้างรายได้เกษตรกร การประมง และปศุสัตว์
“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

สร้างและขยายโอกาส

๑. ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน
๒. เปลี่ยนรัฐที่เต็มไปด้วยระเบียบให้เป็นผู้สนับสนุน
๓. ผลักดัน รัฐบาลดิจิทัล
๔. ส่งเสริม ๑ ครอบครัว ๑ Soft Power
ปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมงานวิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างคุณภาพชีวิต

๑. พัฒนาหน่วยงานความมั่นคง-กองทัพให้ทันสมัย
- ๒.ปราบปรามยาเสพติด ยึดทรัพย์ผู้ผลิตและผู้ค้า เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย
๓. ดูแลสิ่งแวดล้อม อากาศที่สะอาดสำหรับทุกคน
๔. ยกระดับ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
๕. ดูแลคนตกกลุ่มด้วยสวัสดิการโดยรัฐ
๖. ผลักดันกฎหมายสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียม

นโยบายมุ่งเน้น ปี ๒๕๖๗

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ยกระดับ ๓๐ บาทพลัส

๑.โครงการพระราชดำริ/เฉลิมพระเกียรติ/ที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์

๑) เครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขต้นแบบ เขตสุขภาพละ ๑ เครือข่าย

๒) โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ (รพร./รพภ.)

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ

๓) โครงการฟันเทียม รากฟัน เทียม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓.๑) จำนวนผู้ที่ได้รับการ ใส่ฟันเทียมทั้งปากหรือเกือบทั้ง ปาก

๓.๒) จำนวนผู้ที่ได้รับการ ใส่รากฟันเทียมรองรับฟันเทียม

๓. สุขภาพจิตและยาเสพติด

มีนิธัญรักษ์ ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและ ยาเสพติดอย่างครบวงจรทุก จังหวัด

๑.จังหวัดที่เปิดนิธัญรักษ์ ได้รับการติดตาม และมีการประเมิน รับรองคุณภาพมาตรฐาน เป็นไป ตามเกณฑ์ที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด

๒.ร้อยละของผู้ป่วย จิตเวชและยาเสพติดคุณภาพ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป

- หอผู้ป่วยจิตเวชและ ยาเสพติดคุณภาพ ใน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปร้อยละ ๗๐

๓. ร้อยละของ โรงพยาบาลชุมชนที่มี กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด

- โรงพยาบาลชุมชน มีกลุ่มงานจิตเวชและ ยาเสพติด ร้อยละ ๑๐๐

๔. มะเร็งครบวงจร

๑) ร้อยละของการฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

๒) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด กรองไปไม่ตับ

๓) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด กรองมะเร็งท่อน้ำดี

๔) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด กรอง HBV และ HCV

๕) ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัด กรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

๖) ร้อยละของการผ่าตัดภายใน ๔ สัปดาห์

๗) ร้อยละของเคมีบำบัดภายใน ๖ สัปดาห์

๘) ร้อยละของรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห์

๙) เขตสุขภาพที่มีที่พักสำหรับ ผู้ป่วยรังสีรักษา (๑๒ เขตสุขภาพ)

๕. สร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากร

๕.๑ ร้อยละของเขต สุขภาพที่มีการบริหารจัดการ กำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

๑) ตำแหน่งว่างพยาบาล วิชาชีพ ๓,๐๐๐ ตำแหน่ง บรรจุบุคคลแล้วเสร็จ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๙๐

๒) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชพ. ๑๐,๑๒๔ อัตรา แต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งแล้ว

เสร็จ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐

๕.๒ ระดับความสำเร็จ ของแพทย์ผู้ลาศึกษาให้ได้รับ การเลื่อนเงินเดือน

- ๑) แพทย์ผู้ลาศึกษา หน่วยงานในสังกัด กสธ.ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
๖. การแพทย์ปฐมภูมิ
 - ๑) จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการ ปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วย บริการปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. ระบบ สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒,๗๕๐ หน่วย)
 - ๒) อำเภอสุขภาพดี (ร้อยละ ๘๔ หรือ ๘๐๐ อำเภอ)
 - ๓) อาสาสมัครสมัครสาธารณสุข มีศักยภาพในการ จัดบริการปฐมภูมิขั้นพื้นฐานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ร้อยละ ๖๕
๘. สถานชิวาภิบาล
 - ๑) ร้อยละของการให้บริการใน สถานชิวาภิบาล จังหวัดละ ๑ แห่ง
 - ๒) ร้อยละของ Hospital at Home/ Home Ward จังหวัดละ ๑ แห่ง
 - ๓) ร้อยละของบริการคลินิก ผู้สูงอายุใน โรงพยาบาลทุกระดับ (ร้อยละ ๙๕)
๙. พัฒนา โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย
 - ๑) ร้อยละของ โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการ จัดบริการตรวจ วินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และเครื่องตรวจด้วย สนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)
๑๐. ดิจิทัลสุขภาพ
 - ๑) ร้อยละของ โรงพยาบาลในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมโยงข้อมูล PHR และส่ง ต่อข้อมูลผู้ป่วยแบบ อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๑๒ เขตสุขภาพ
 - ๒) ร้อยละ ๕๐ โรงพยาบาลสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับเงินขึ้นไป
 - ๓) Virtual Hospital ๑ แห่ง
๑๑. ส่งเสริมการมีบุตร
 - ร้อยละของ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร
 - ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขมีคลินิกส่งเสริม การมีบุตร
๑๒. เศรษฐกิจสุขภาพ
 - Wellness Community อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง
 - ๑) ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชุมชนที่ได้รับการอนุญาตใหม่ตาม แผนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ร้อยละ ๖๐)
 - ๒) ร้อยละของผู้ผ่านการอบรม Caregiver/Care Assistance สามารถประกอบอาชีพและ สร้างรายได้ ร้อยละ ๕๐
๑๓. นกทองเที่ยวปลอดภัย
 - ๑) จำนวนจังหวัดนำร่องพื้นที่ ท่องเที่ยวปลอดภัยโรคและภัย สุขภาพที่ดำเนินการตามมาตรการ ขับเคลื่อนพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยโรคและภัยสุขภาพ (๑๓ จังหวัด)

กรอบแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นพ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด

๑. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรจังหวัดขอนแก่น อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี
๒. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒
๓. การกระจายรายได้ดีขึ้น ลดความไม่เสมอภาค ค่า Gini Coefficient ต่ำกว่า ๐.๔๑

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรม

การเกษตรมูลค่าสูง

๑. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพื่อการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร

๒. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs

๓. การส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมนิเวศให้มีมูลค่าสูง

๔. การส่งเสริมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน

ตัวชี้วัด

๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดด้านการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒
๒. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓. ทุนการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
๔. การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการต่อปี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค

แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้างสรรค์

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

๓. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย

๔. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนงาน MICE ที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ๑๐ งาน ต่อปี
๒. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓
๓. รายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่น

เมืองอัจฉริยะ แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด

๒. การส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม

๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ การโทรคมนาคม สื่อสาร และดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนในพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ตัวชี้วัด

๑. มูลค่าการลงทุนในจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
๒. มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/ปี
๓. จำนวนพื้นที่หรือเขตอำเภอที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ไม่น้อยกว่า ๖ อำเภอ/ปี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนา

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาวะและความเป็นอยู่ดี
๒. การส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพให้มีรายได้อย่างยั่งยืน
๓. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี

ตัวชี้วัด

๑. ดัชนีการพัฒนาคอนจังหวัดขอนแก่น ไม่เกินลำดับที่ ๒๕ ของประเทศ
๒. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุม ร้อยละ ๑๐๐
๓. อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชากรจังหวัดขอนแก่น อายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๗๕ ปี

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แนวทางการพัฒนา

๑. การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
๒. การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๓. การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
๔. การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับแหล่งน้ำเกื้อหนุนเพิ่มขึ้นจำนวน ๒,๕๐๐ ไร่/ปี
๒. ชยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ ๗๕
๓. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ๔,๐๐๐ ไร่ ต่อปี
๔. จำนวนประชาชนตระหนักรู้ด้านการป้องกันและรับมือภัยพิบัติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อย่างมีส่วนร่วม แนวทางการพัฒนา

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminalภัยทางถนน
๒. การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๓. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม
๔. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๕. การป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ตัวชี้วัด

๑. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง ร้อยละ ๕
๒. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยลดลง ร้อยละ ๕

๓. ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ (คดีที่รับแจ้ง)

๔. จำนวนอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ ๒๖ อำเภอ

๕. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนหมู่บ้านสีแดงลดลง ร้อยละ ๓

๒.๒ ความจำเป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก

๑. ความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสูงอายุ

แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกโดยเริ่มจากประเทศที่พัฒนาแล้วมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี และตามมด้วยประเทศกำลังพัฒนา เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้ปัจจัยการผลิตทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการ และการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติลดลง ทั้งนี้การที่แรงงานลดลงอาจแก้ไขโดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้แรงงานต่างด้าวซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อมการจัดสรรทรัพยากรแรงงานที่จะลดลงจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้รายได้ประชาชาติลดลงได้ ดังนั้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

ทางการผลิต เมื่อโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่วัยทำงานเท่าเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต ทำให้การผลิตและกำลังแรงงานน้อยลงผลิตภาพการผลิตลดน้อยลงหรืออุปทานแรงงานลดลงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ค่าแรงสูงขึ้นได้หรือเกิดการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้อาจแก้ไขปัญหขาดแคลนแรงงานโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น

ทางการลงทุนและการออม เมื่อมีวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการลงทุนน้อยลงวัยสูงอายุหรือวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงทำให้มีการออมลดลง ในขณะที่วัยทำงานต้องรับภาระมากขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้มีเงินออมน้อยลง และเงินลงทุนลดลงสำหรับภาครัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้นเพื่อบริการสังคม ทางด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทำให้การลงทุนและการออมของประเทศลดลง

ทางด้านผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือรายได้ประชาชาติน้อยลง และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลลดลง ผลิตภาพการผลิตลดลง

ทางการคลัง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น ภาครัฐจำเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข การแพทย์ บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นและต้องเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง เก็บภาษีรายได้น้อยลงเนื่องจากมีวัยผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนที่มากขึ้น

ผลกระทบทางด้านสังคม

ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะต้องทำงานมากขึ้นและต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น บางครั้งอาจทำให้ผู้สูงอายุขาดความอบอุ่นหรืออาจถูกทอดทิ้งได้

ปัญหาทางด้านสภาพจิตใจ เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ ไม่ได้ทำงานทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกเหงา ไม่ภาคภูมิใจเหมือนเป็นภาระกับลูกหลาน อาจรู้สึกน้อยใจ ซึมเศร้า จึงจำเป็นต้องมีคนดูแลเอาใจใส่

ปัญหาสุขภาพร่างกาย ตามปกติผู้สูงอายุจะมีสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม ไม่แข็งแรง จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่ และจะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ไม่มีรายได้ จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก หากไม่มีการวางแผนสะสมเงินออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในวัยชรา จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะต้องมีการวางแผนการออม การลงทุนและการบริโภคเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เนื่องจากเมื่อสูงอายุแล้วจะต้องหยุดทำงานและขาดรายได้ จึงจำเป็นต้องเตรียมสะสมเงินออมหรือวางแผนการลงทุนเพื่อจะได้มีรายได้หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงที่สูงอายุหรือสามารถนำเงินออมที่สะสมไว้มากใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต

ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะมีร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการร่วมกันกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การร่วมมือกันในชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุซึ่งสำหรับบางประเทศได้มีการขยายอายุผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำมากขึ้นเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าและเป็นภาระกับสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ

๒. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความมั่นคง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศตามหลักนิติธรรม ประเทศไทยยังคงมีปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่เอื้อต่อการบริหารตามหลักนิติธรรม ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารประเทศและวิกฤติศรัทธาของผู้นำ รวมถึงโครงสร้างทางการเมืองการบริหารซึ่งแม้จะมีการกระจายอำนาจมากขึ้นแต่ในภาพรวม ยังคงมีลักษณะรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลาง เป็นข้อจำกัดต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ประกอบกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐขยายตัวออกไปทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชน ในขณะเดียวกัน ประชาชนบางส่วนยอมรับกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยผลของปัญหาดังกล่าวได้กัดกร่อนพื้นฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของสังคม

๒.๒ ปัญหายาเสพติด ปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการทำลายศักยภาพของประชากร และปัญหาการขยายตัวขององค์กรอาชญากรรม นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับการลักลอบค้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นประเทศทางผ่านและประเทศปลายทาง ในขณะที่ การลักลอบขนยาเสพติด และแหล่งพักยาเสพติดอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นพื้นที่สำคัญ รองลงมาคือ

พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ กลุ่มนักค้าจากนอกภูมิภาคเข้ามามีบทบาทสำคัญในการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ในการลำเลียงยาเสพติดจากหลายแหล่งผลิตทั้งในและนอกภูมิภาค ซึ่งการจับกุมกระทำได้อย่างขึ้นเนื่องจาก ลักษณะเฉพาะตัวของการจัดองค์กรและรูปแบบและวิธีการค้ายาเสพติดที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

๒.๓ ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นพร้อมกับการเพิ่มจำนวนของประชากรโลก รวมถึงการพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก นำไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จนนำไปสู่ภัยพิบัติธรรมชาติเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย วาตภัย รวมถึงสถานการณ์แผ่นดินไหว ที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในลักษณะที่สามารถบริหารจัดการวิกฤติการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นป้องกัน การแก้ไขและการฟื้นฟูสถานการณ์ผลกระทบจากวิกฤติการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับรุนแรงมากขึ้น ควบคู่กับการขยายความร่วมมือกับประชาคมโลกเพื่อจัดการกับภัยพิบัติดังกล่าว

๓. ความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมดิจิทัล

เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการกิจกรรมของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้าน เช่น สังคม ความเป็นอยู่ การปกครอง เศรษฐกิจ แม้แต่ด้านการเมือง การปกครอง การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจ ภาคการผลิต ภาคการบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมในหลายๆ ด้านเป็นทั้งเครื่องมือที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนา รวมถึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเองก็สามารถส่งผลกระทบในด้านที่ไม่ต้องการ เช่น การสร้างมลพิษหรือการเกิดส่วนเกินจากการผลิตที่ไม่ต้องการกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาต่างของมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างปัญหารูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นด้วยการทำความเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องมองระยะยาวมากขึ้น เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ด้านบวกมากกว่าจะกลายเป็นผลเสียต่อสังคมโดยรวม

๔. เทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง สังคมยุคใหม่

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั่วโลกที่เป็นไปตามกระแสการเปลี่ยนของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศ ประสิทธิภาพของการส่งข้อมูลและข่าวสารมีความทันสมัยและรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีทำให้การรับรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งภาพและเสียง ระบบการกระจายข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วไม่จำกัดช่องทางหรือตัวกลาง ผลจากการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีทุกด้านทำให้เกิดผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายด้านแนวโน้มที่สำคัญ ประกอบด้วย

๑) เทคโนโลยีที่พัฒนาต่อเนื่องทำให้สังคมเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็นสังคมสารสนเทศ

๒) เทคโนโลยีแบบตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน เป็นการพัฒนาขึ้นมาใช้สำหรับบุคคลเทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเน้นการตอบสนองตามความต้องการ โดยสร้างพื้นฐาน

ของอุปกรณ์รองรับทั้งด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถเป็นไปได้ เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าเพื่อให้สามารถนำทุกการคิดค้นต่างๆ ขึ้นมาตอบสนองและลดปัญหาต่างๆ ของมนุษย์

๓) เทคโนโลยีทำให้เกิดรูปแบบขององค์กรที่สามารถประกอบการหรือดำเนินกิจกรรมได้ทุกสถานที่ และทุกเวลาอาศัยการสื่อสารที่ก้าวหน้าและแพร่หลายขึ้นผ่านระบบเครือข่าย การประชุมทางวิดีโอ ระบบประชุมบนเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ ระบบการค้าบนเครือข่าย ลักษณะของการดำเนินงานเหล่านี้ ทำให้ผู้ใช้ขยายขอบเขตการดำเนินกิจกรรมไปทุกหนทุกแห่งตลอด ๒๔ ชั่วโมง กิจกรรมทางเศรษฐกิจจัดการได้สะดวกมากขึ้นไม่จำเป็นที่จะต้องวางระบบเอทีเอ็มที่ทำให้การเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาและกระจายถึงตัวผู้รับบริการมากขึ้น

๔) เทคโนโลยีทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่ระดับเศรษฐกิจโลกที่ไม่มีขีดจำกัดด้านสถานที่ การซื้อขายที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดรูปแบบการค้าที่ช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ระบบเศรษฐกิจในโลกสามารถเชื่อมโยงและเอื้อประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น

๕) เทคโนโลยีส่งผลให้องค์กรมีลักษณะแบบเครือข่ายมากขึ้น องค์กรมีการวางเป็นลำดับขั้นสายการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง แต่เมื่อการสื่อสารแบบสองทางและการกระจายข่าวสารดีขึ้นมีการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กรผูกพันกันเป็นกลุ่มงานเพิ่มคุณค่าขององค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรกลายเป็นการบริหารอย่างงานที่มีลักษณะการบังคับบัญชาแบบแนวนอนมากขึ้น การออกแบบหน่วยธุรกิจขนาดเล็กลงและเน้นการทำงานเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่ายตามความเชี่ยวชาญและประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก โครงสร้างขององค์กรได้รับผลตามกระแสของเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์

๖) เทคโนโลยีทำให้เกิดการวางแผนการดำเนินการบริหารที่สร้างรายได้เปรียบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น ระบบการตัดสินใจวางแผนมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ แนวทฤษฎีทางความคิดการบริหารเปลี่ยนไปมีความยืดหยุ่นและมองหลายมิติมากขึ้น

๗) เทคโนโลยีได้กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญในทุกด้านมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม ศิลธรรม การศึกษา เศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมาก การเชื่อมโยงข่าวสารจากประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลกสามารถรับรู้ข่าวสาร ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารระหว่างกันและติดต่อกับคนได้ทั่วโลกผลกระทบที่ตามมาของการส่งผ่านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีลักษณะเป็นสังคมโลกมากขึ้น

๒.๓ จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นกำหนดจุดยืน และตำแหน่งการพัฒนาตามความจำเป็นทางยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย การสนองตอบต่อความต้องการสุขภาพของประชาชน สถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและอนาคต และการปรับตัวด้านสุขภาพของจังหวัดจากเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาสู่เมืองแห่งสุขภาพะเข้มแข็ง ศูนย์กลางความเป็นเลิศทาง การแพทย์ระดับประเทศ ที่ประชาชนสุขภาพดีด้วยตนเอง ประกอบด้วยรายละเอียด ๘ จุดยืน ดังต่อไปนี้

๑. มุ่งเน้นการสร้าง พัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง และความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยให้ภาคีทุกภาคส่วน และเครือข่าย

สุขภาพภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฏิบัติในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ (Health in All Policy and Area)

๒. มุ่งเน้นการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความตื่นรู้ ตระหนัก มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี มีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ มีจิตอาสาทางสุขภาพ ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง และมีพันธสัญญาในการสร้างชุมชนสุขภาพดี (Total Health literacy for All)

๓. มุ่งเน้นการระดมพลังภาคีทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติการอย่างจริงจังเพื่อการลด และหยุดยั้งปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบในทุกตำบล และขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Community Health Model)

๔. มุ่งเน้นการสร้างค่านิยมทางสุขภาพของประชาชนและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดมุมมองชีวิตทางสุขภาพ การมีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน ให้ประสบความสำเร็จสู่ชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ (Healthy Value and Culture)

๕. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่นให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นระบบการแพทย์ ๔.๐ และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาจังหวัดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมืองนานาชาติในอนาคต (Medical Hub)

๖. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจในศักยภาพทางการแพทย์ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้รอยต่อ สถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นระบบบริการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางหน่วยบริการมีความเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใจในการกิจสุขภาพเพื่อประชาชน (Medical Service Excellent)

๗. มุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม และการทำงานแบบบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนา สังคมเมือง สังคมเมืองในชนบท และสังคมชนบท ทัวทั้งจังหวัดมีสภาพแวดล้อมทางสุขภาพที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของทุกกลุ่มวัย (แม่และเด็ก วัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ) และจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบของการสร้างนิเวศน์สุขภาพของประเทศ (Smart Health City and Community : SHCC)

๘. มุ่งเน้นการส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาองค์กรด้านสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการกิจ ทำงานอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการสาธารณสุข และการสร้างสมดุลแห่งรัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นระบบการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล และมีมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีผลงานประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการบริหาร และการบริการสุขภาพประชาชน ในระดับเขต ประเทศ และนานาชาติ (High Performance and Modernize)

๒.๔ การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์

ปัจจัยจากภายใน

จุดแข็ง (Strengths)

๑. มีองค์กรที่มีศักยภาพ/เครือข่ายภายในระดับ Excellent พร้อมจัดบริการในโรงพยาบาล และเป็นศูนย์กลางการผลิตมือเทียม ๓ มิติ สำหรับผู้พิการทั่วประเทศ
๒. มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง พร้อมขับเคลื่อนงาน มีค่านิยมบุคลากร
๓. มีระบบบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
 - ๓.๑ มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณและกำกับติดตาม
 - ๓.๒ มีระบบการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ
๔. มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและพร้อมใช้
๕. ปฐมภูมิเข้มแข็ง จัดบริการ PCU / NPU ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๖. ชุมชนมีเครือข่าย อสม.พร้อมดูแลผู้สูงอายุและมีเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. บุคลากรมีศักยภาพ, สมรรถนะ, ทักษะไม่เพียงพอกับปัญหาเฉพาะทางในพื้นที่ เช่น ทักษะด้าน IT ที่จะพัฒนางานตาม Mega Trend, PCU / NPCU
๒. บุคลากรขาดขวัญกำลังใจ จากความเหลื่อมล้ำ เรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ เมื่อเทียบกับกระทรวงอื่น
๓. บุคลากรลดลง รับผิดชอบภาระงานเพิ่มขึ้น การกระจายบุคลากร ทรัพยากรไม่เหมาะสม
๔. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการในทุกระดับ และไม่สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัด
๕. การบริหารจัดการข้อมูล Big Data ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๖. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น Software, Hardware

ปัจจัยจากภายนอก

โอกาส (Opportunities)

๑. เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจ คมนาคมขนส่งระดับภูมิภาค
๒. นโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นเอื้อต่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาคสุขภาพความงาม
แพทย์แผนไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ Innovation & Technology
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ พัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่และยั่งยืน
๓. เป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ระดับภูมิภาค มี โรงพยาบาลต่างสังกัดที่เป็น Excellent Center
 ๔. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งทั้งภาคเอกชน รัฐ ท้องถิ่น และประชาชน
 ๕. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ ฝึกอบรม เรียนรู้ ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ / พยาบาล มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับภูมิภาคเอเชีย
 ๖. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วทั่วถึงเอื้อต่อการเชื่อมโยงทุกเครือข่าย มีศูนย์ ICT ชุมชน / Internet ชุมชน เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพทุกระดับ

ภัยคุกคาม (Threats)

๑. โครงสร้างสายบังคับบัญชาตามกฎหมายเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่เอื้อต่อระบบการประสานงาน และการส่งต่อ นโยบายและกฎหมาย ถ้าย้อน โรงพยาบาลสต. ไป อบจ. ทำให้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ ยังไม่แน่นอน

๒. พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัยเปลี่ยน ทำให้อัตราการติดยาเสพติดสูงขึ้น ปัญหาสุขภาพจิต และโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น

๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง งบดำเนินการ ค่าตอบแทน เสี่ยงภัยการบรรจุแต่งตั้ง บุคลากรเพิ่มเติมล่าช้า

๔. ภาวะเงินเฟ้อ ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำกระทบทั้งภาครัฐและเอกชน ภาวะสงคราม (น้ำมันแพง) ทำให้ค่าครองชีพสูง

๕. สังคมผู้สูงอายุแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้เป็นภาระด้านสุขภาพ และงบประมาณ

๖. เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว หลากหลาย ทำให้บุคลากรตามไม่ทันการรู้เท่าทันสื่อ และเทคโนโลยี เช่น Fake News

บทที่ ๓

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

(ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

ทิศทางแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๓.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ระบบบริการได้มาตรฐาน คนขอนแก่นมีสุขภาวะที่ดี”

กำหนดนิยามของวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

องค์กรหลัก หมายถึง

- ๑) กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยกำหนดที่จะพัฒนาความเป็นเลิศ ๔ ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย (P&P Excellence) การจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence) การพัฒนาคน (People Excellence) และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม (Governance Excellence)
- ๒) นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการทางสุขภาพของประชาชน ภาควิชาทุกภาคส่วน และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และร่วมพัฒนาระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ระบบบริการได้มาตรฐาน หมายถึง

- ๑) ระบบการบริการสุขภาพในทุกระดับของจังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพ มาตรฐาน มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคที่มีความเป็นเลิศ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาจังหวัดทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และการเติบโตของเมืองสู่เมื่องนานาชาติในอนาคต
- ๒) ประชาชนเชื่อมั่น และวางใจในศักยภาพทางการแพทย์ เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ไร้รอยต่อ สถานบริการสุขภาพทุกระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริการ มีความเข้าใจ เข้าถึงในความต้องการของประชาชน ประชาชนพึงพอใจในบริการและเข้าใจในผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการมีความสุข และความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

คนขอนแก่นมีสุขภาวะที่ดี หมายถึง

- ๑) ประชาชนมีความตื่นรู้ ตระหนัก และเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี มีทักษะในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ มีจิตอาสาทางสุขภาพ สามารถสร้างระบบการจัดการสุขภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และมีพันธสัญญาในการสร้างชุมชนสุขภาพที่ดี
- ๒) ปัญหาสุขภาพของประชาชนในโรคที่ป้องกันได้ด้วยตนเองและพลังชุมชนลดลงอย่างต่อเนื่อง ภัยคุกคามทางสุขภาพได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานที่ดี เกิดชุมชนต้นแบบความสำเร็จในทุกตำบล และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

- ๓) ค่านิยมทางสุขภาพของประชาชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดมุมมองชีวิตทางสุขภาพการมีสุขภาพดีเป็นวิถีชีวิตของชุมชน ประชาชน และประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งทางวัฒนธรรมสุขภาพในระดับประเทศ

๓.๒ พันธกิจ

- ๑) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ
- ๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ให้ประชาชน เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม
- ๓) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
- ๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์

- ๑) สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ๒) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
- ๓) พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
- ๔) การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ที่ ๑ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ที่ ๒ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม

เป้าประสงค์ที่ ๔ ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง

มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ

เป้าประสงค์ที่ ๕ ประชาชนได้รับการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ

เป้าประสงค์ที่ ๖ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและ
ธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ ๗ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ
และบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ ๘ หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ที่ ๙ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่นระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๑.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	๑.ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม	๑. ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ ๑๙-๕๙ ปีมี BMI เกินได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมี BMI ลดลง ๒. ร้อยละประชากรมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในเรื่องโรค Stroke Sepsis DM HT
	๒.ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน	๓. จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๕. ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ๖. ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ๗. ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ ๘. อัตราตายมารดา ไม่เกิน ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ๙. อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน ๓.๖ ต่อการเกิดมีชีพพันคน ๑๐. ร้อยละผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง ๑๑. ร้อยละสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ๑๒. ร้อยละของประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test ๑๓. ร้อยละกลุ่มเป้าหมาย FIT Test ที่มีผล Positive ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy ๑๔. อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๑๕.๑ อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ๑๕.๒ อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๑.สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯ (ต่อ)	๓.ระบบคุ้มครองผู้บริโภคและการ จัดการสิ่งแวดล้อมที่มี ประสิทธิภาพ	๑๖. จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital Challenges ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๗. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์
๒.พัฒนาระบบบริการ สุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชน เข้าถึงระบบบริการทุก ระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม	๔.ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบ ส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ	๑๘. อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ๑๙. ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง ๒๐. อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน ๘ ต่อแสนประชากร ๒๑. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด (Community-Acquired) ๒๒. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รายใหม่) ๒๓. ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการบริหารพื้นสภาพและติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจน Barthel index = ๒๐ ก่อนครบ ๖ เดือน ๒๔. อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง ๒๕. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๖. ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒๗. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ ๒๘. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมความดันโลหิตได้
	๕.ประชาชนได้รับการปฐมภูมิที่มี คุณภาพ	๒๙. ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓๐. อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับรพ.แม่ข่าย (๖๐ : ๔๐)

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
๓.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ	๖.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ	๓๑. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย ๒ เรื่อง ๓๒. หน่วยบริการสุขภาพได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการการจัดระบบบริการสุขภาพ(SAP)
๔.การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล	๗.มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ	๓๓.จำนวนผลงานวิจัย/ R๒R/ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดที่แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ๓๔. จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ๓๕. จำนวนอำเภอที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด
	๘.หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน	๓๖. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ ๓๗. จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ. ๓๘. ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ
	๙. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	๓๙. จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ ๑ ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมียุทธศาสตร์สุขภาพที่เหมาะสม

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑	ร้อยละของประชาชนวัยทำงาน อายุ ๑๙-๕๙ ปีมี BMI เกินได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมี BMI ลดลง	NA	๒	๓	๔	๕	๑.ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวัยทำงาน ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุคุณภาพ	๑. พัฒนาบุคลากรและแกนนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๒. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	อัตราความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	NA	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔	๑.พัฒนาศักยภาพองค์กร-ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ๒.สร้างเสริมความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ๓.เยี่ยมเสริมพลัง	๑. องค์กร- ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพประเมินตนเองผ่านระบบโปรแกรมสาสุข อุ่นใจ ๒. แต่งตั้งคณะทำงานความรู้รอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กร-ชุมชน ๓. ขับเคลื่อนกิจกรรมในชุมชนตามกระบวนการสาสุขอุ่นใจ ข้อ ๔-๑๐ ๔. เยี่ยมเสริมพลัง กำกับ และติดตาม
เป้าประสงค์ที่ 2 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน								
๓	จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	พัฒนากลไกการขับเคลื่อน พขอ. รูปแบบ One Project one plan	๑. กำหนดประเด็น พขอ. ที่เป็นปัญหาตามบริบทของพื้นที่ ๒. ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ พขอ. และ อนุกรรมการ พขอ. รายประเด็นให้เป็นปัจจุบัน ๓. วางแผนขับเคลื่อน พขอ. รูปแบบ one project one plan ทุกประเด็น ๔. บริหารจัดการบูรณาการทรัพยากรของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน พขอ. ๕. ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE ก่อนและหลังดำเนินการ ๖. เยี่ยมเสริมพลัง และติดตามการดำเนินงาน พขอ.

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๔	ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	๗๗.๖๑	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙	๑.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒. เสริมสร้างความร่วมมือการดำเนินงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	๑.ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลทศวรรษ ๑,๐๐๐ วัน สู่ ๒,๕๐๐ วัน และ สพด ๔D ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. การพัฒนาตำบลต้นแบบการพัฒนาเด็ก โดยการสร้างวินัยเชิงบวก โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม Trip P ๔.การแก้ไขปัญหาเด็กพัฒนากล้าเข้าเป็นรายบุคคล
๕	ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๖๗.๒๓	๗๖	๗๘	๘๐	๘๒	๑.พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒.สร้างความร่วมมือการดำเนินงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	๑.ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบบริการคลินิกเด็กดีคุณภาพ ตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กปฐมวัย ๒.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลทศวรรษ ๑,๐๐๐ วัน สู่ ๒,๕๐๐ วัน และ สพด ๔D ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๓. การติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กที่ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัย
๖	ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๖๓.๐๘	๖๔	๖๖	๖๘	๗๒	๑.ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา ศักยภาพเด็กวัยเรียนศตวรรษที่ ๒๑ ๒.ยกระดับคุณภาพงานอนามัยโรงเรียน ๓.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	๑.ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาตรฐานสากล(GSHPS) ๒.ประเมินรับรองตามมาตรฐานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน HPS,GSHPS ๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ทักษะสุขภาพและงานอนามัยโรงเรียน ๔.ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน
๗	ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	๙๔.๖	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙	ยกระดับระบบการดูแลผู้สูงอายุ	จัดบริการสุขภาพให้ผู้สูงอายุมีสภาพดี (Healthy Aging) ป้องกันภาวะถดถอยด้านสุขภาพ สมองเสื่อม โรคหัวใจและหลอดเลือด พัลตตกกลม และมีสุขภาพจิตที่ดี

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๘	อัตราการมารดา ไม่เกิน ๑๗ ต่อแสน การเกิดมีชีพ	๑๐.๑๔	≤๑๕	≤๑๔	≤๑๓	≤๑๒	๑.พัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ระดับโรงพยาบาล/ห้องคลอดคุณภาพ ๒.พัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑.ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุการตายของมารดา แนวทาง/ข้อปฏิบัติ/ข้อสั่งการ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตาย ๒. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงแก่หญิง ตั้งครรภ์ โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัวผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่และใช้สมุด บันทึสุขภาพแม่และเด็กและ Line OA แม่และเด็กเขต สุขภาพที่ ๗ ๓.กำกับติดตามการใช้นโยบาย/มาตรการในพื้นที่ โดยคณะกรรมการบริหารระดับจังหวัด MCHB และ Service Plan ทุก ๓ เดือนโดยการฝึกปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทาง สูติกรรม(Obstetric Crisis) ๓.พัฒนาศักยภาพ รพ.สต.ในการ คัดกรองภาวะเสี่ยง การติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ เสี่ยงและการส่งต่อ อย่างเป็นระบบ
๙	อัตราการของทารกแรกเกิดไม่เกิน ๓.๖ ต่อพันการเกิดมีชีพ	๒.๗	๒.๕	๒.๓	๒.๑	๒	๑.พัฒนากลไกการขับเคลื่อน MCHB จังหวัดและ SP-สูตินรีเวชกรรม	๑.ประชุมMCHBไตรมาสละ ๑ ครั้ง เพื่อทบทวน ระบบการดูแลมารดาและทารกกรณีDeath case and near Missed case เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ๒.ออกประเมินเพื่อรับรองโรงพยาบาลผ่านมาตรฐาน การดำเนินงานแม่และเด็ก

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๐	ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะฟันผุ	๙๔.๖๐	๙๕	๙๕.๕	๙๖	๙๖.๕	๑.สนับสนุนการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ๓.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	๑.สนับสนุนการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๒.สนับสนุนส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ ให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๓.อบรม Case Manager Care giver อาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นและสหวิชาชีพ
๑๑	ร้อยละสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA	๓๙.๕๓	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๑. พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ๒. เสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน	๑.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ ๒.เพิ่มการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Self Collection ครอบคลุมทั้งจังหวัดขอนแก่น ๓.เพิ่มหน่วยเครือข่ายบริการการกระจายชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Self Collection ไปยังร้านยา คลินิกพยาบาล ๔.สนับสนุนการฉีดวัคซีน HPV
๑๒	ประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test	NA	๕๕	๖๐	๗๐	๘๐	๑. พัฒนาระบบบริการแบบไร้รอยต่อ ๒. เสริมสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโรคแก่ประชาชน	๑.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ประชาชน เรื่อง การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
๑๓	กลุ่มเป้าหมาย FIT Test ที่มีผล Positive ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy	๕๗.๕๔	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐		

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๔	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน	๗๕.๑๒	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑. เพิ่มศักยภาพในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ๒. พัฒนาเครือข่ายการคัดกรองเชื่อมโยงกับระบบ ๓ หมอ	๑. คัดกรอง ๓ กลุ่มเสี่ยงที่พบวัณโรคสูง ให้คัดกรองแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ได้แก่ กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านสัมผัสใกล้ชิด, กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ หรือมี DM หรือมี COPD และกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง ๒. คัดกรอง ๗ กลุ่มเสี่ยง โดยบูรณาการเป็นงานประจำในคลินิกต่างๆ เช่น คลินิกยาเสพติด, คลินิกโรคเรื้อรัง, คลินิก ARV เป็นต้น และจัดบริการ Mobile X-Ray ๓. ขยายศักยภาพในการตรวจ TB Lamp ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่ม จำนวน ๗ รพ. ได้แก่ รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น รพ.บ้านไผ่ รพ.สีชมพู รพ.พล รพ.น้ำพอง รพ.มัญจาคีรี รพ.พระยืน ๔. อสม. ออกคัดกรอง HT DM ในกลุ่มเสี่ยง อายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในชุมชน เชื่อมโยงระบบ ๓ หมอ

เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๕	๑๕.๑ อัตราป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ ลดลง	-๕.๙๘	๕	๖	๗	๘	๑. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ๒. พัฒนาระบบคัดกรองเชิงรุก	๑. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้ประชาชนสามารถลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
	๑๕.๒ อัตราป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ลดลง	๐.๗๘	๑	๒	๓	๔		
๑๖	จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับมาตรฐาน (Standard)	๒๔	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๑. สนับสนุนให้เกิดบูรณาการการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน ๒. ผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อย่างเป็นรูปธรรม ๓. เสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายการดำเนินงานระดับจังหวัด อำเภอ ทุกแห่ง ๒. เยี่ยมเสริมพลัง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระดับ ๓. ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการนิเทศงาน ๔. สนับสนุน วัสดุสาธิต งบประมาณ พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืน
	ระดับดีเยี่ยม (Excellent)	๑๒	๑๔	๑๖	๑๘	๒๐		
	ระดับท้าทาย (Challenge)	๓	๕	๖	๗	๘		
๑๗.	ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์	NA	>๘๕	>๙๐	>๙๕	>๙๘	สนับสนุนระบบเฝ้าระวังและควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ	สุ่มตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทัวถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม								
เป้าประสงค์ที่ ๔ ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๑๘	อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่	๗๕.๒๖	๘๘	๙๐	๙๕	๑๐๐	๑.พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมป้องกันวัณโรคระดับอำเภอ และ Mr.TB อำเภอ ๒.พัฒนาระบบการรักษา ส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูล การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค	๑.จัดประชุม Case Conference เพื่อหารือแนวทางการรักษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต และผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน ๒. ขึ้นทะเบียน TB Clinic ในโรงพยาบาลระดับ F๓ จำนวน ๔ แห่ง
๑๙	ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับลดลง	๓.๐๗	๒	๑	๑	๑	พัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัยการส่งต่อดูแลรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งระบบอย่างบูรณาการ	ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีตาม ๘ มาตรการ
๒๐	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน ๘ ต่อประชากรแสนคน	๗.๙๙	๗.๑๙	๖.๓๙	๕.๕๙	๔.๗๙	๑.พัฒนาระบบคัดกรองเชิงรุก โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยง ๒.พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล	๑.จัดระบบบริการตามแนวทางยกระดับมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในการคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา กลุ่มเสี่ยง ให้บริการภาวะฉุกเฉินด้าน จิตเวช รวมทั้งการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต
๒๑	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด (Community-Acquired) น้อยกว่าร้อยละ ๒๖	๒๔.๙๗	๒๔	๒๔	๒๒	๒๐	๑.พัฒนากลไกการขับเคลื่อน SP สาขาอายุรกรรม ๒.พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย Sepsis ให้ได้มาตรฐาน ๓. สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ	๑.ประชุมคณะกรรมการ SP สาขาอายุรกรรม (Sepsis) เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อน ปี ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ๒. สร้างทีมงานประสานงานและติดตามตัวชี้วัดในโรงพยาบาลทุกแห่ง

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
								โดยในแต่ละโรงพยาบาลต้องมี ทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และมีผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis case manager) รวมถึงการสร้างทีมเครือข่ายชุมชนในการคัดกรองผู้ป่วย ๓. ค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็ว (early detection) โดยใช้เครื่องมือในการช่วยคัดกรองการติดเชื้อในกระแสเลือดเพื่อช่วยค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วและวินิจฉัยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ลดปัญหา Delay Detected / Delay Diagnosis/ Delay refer และการเพิ่มศักยภาพแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์แต่ละระดับ สร้างความเข้าใจ Protocol เพื่อการนำใช้ที่ถูกต้อง ๔. จัดทำแนวทางระบบการส่งต่อที่ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างแพทย์พยาบาล ในทุกโรงพยาบาล เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและ สร้างแนวทางการพัฒนางานต่อไปให้สำเร็จมากยิ่งขึ้น

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๒	อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ต่อประชากรแสนคน	๒๗๔	๒๓๗	๒๓๒	๒๒๗	๒๒๒	พัฒนาระบบบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด STROKE & STEMI ในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ	๑. เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ อาการ สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจและหลอดเลือด ๒. คัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ๓. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มป่วยโดยใช้โปรแกรม Smart NCD
๒๓	ร้อยละของผู้ป่วย IMC ได้รับการปรับสภาพและติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจน Barthel index = ๒๐ ก่อนครบ ๖ เดือน (เป้าหมายร้อยละ ๙๘)	๘๐	๙๘	๙๙	๑๐๐	๑๐๐	๑. ขับเคลื่อนการนำส่งข้อมูล (Data flow) ผ่านระบบโปรแกรม nRefer ๒. สนับสนุน ส่งเสริม การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนพื้นที่สุขภาพระยะกลาง ๓. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดระบบบริการปรับสภาพระยะกลาง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจยิ่งขึ้น ๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกายภาพบำบัด	๑. ชี้แจงการขึ้นทะเบียนระบบโปรแกรม nRefer ให้แก่หน่วยบริการปฐมภูมิสาธารณสุข ๒. ค้นหา/ ประสานงาน แหล่งงบประมาณการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางอย่างไร ร้อยต่อโดยเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนในระดับพื้นที่/ท้องถิ่น ๓. ช่วยเหลือ สนับสนุนและบูรณาการการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางของหน่วยงานภาครัฐ (สสจ. รพ. กปท. อบจ.และ พมจ.) และองค์กรเอกชน ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Hybridge Meeting ๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ๖. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย Service plan สาขาการบริการปรับสภาพระยะกลาง ๗. เสริมสร้างสนับสนุนนวัตกรรม/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๔	อัตราการติดเชื้อมียาในกระแสเลือด ลดลง ≥ 50	NA	≥ 50	55	60	65	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วย บริการสุขภาพในชุมชน ให้มีการใช้ยา อย่างสมเหตุผล	๑.โรงพยาบาลมีการจัดการการติดต่อด้านจุลชีพ อย่างบูรณาการ ประเมินตนเอง (self assessment) และรายงานผลการดำเนินงานของ ทั้ง ๕ กิจกรรมสำคัญ ๒.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการ สุขภาพในชุมชน ให้มีการใช้ยาอย่างสม เหตุผล -การกำหนดนโยบายและมาตรการ ในรูปแบบ คณะกรรมการ -การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ของการควบคุม กำกับ ดูแลการใช้ยาด้านจุลชีพ -การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน โรงพยาบาลการวิเคราะห์/ -สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ
๒๕	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรค หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	๘	≥ 20	≥ 21	≥ 22	≥ 23	ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรค หลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง(Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ	๑.โรงพยาบาลชุมชน มีการ ดูแลผู้ป่วยระยะกลาง โดยใช้แนวทางเวชปฏิบัติ (Clinical Practice Guideline) การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ด้านการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
๒๖	ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	๒๑.๔๓	≥ 21	≥ 21	≥ 21	≥ 21	พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	๑. บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคี เครือข่าย ได้แก่ พชอ. ๓ หมอ ในการ ให้บริการการแพทย์แผนไทยไทยและ การแพทย์ ทางเลือก เช่น ผู้ป่วย NCD IMC LTC PC ปวด นอนไม่หลับ หงุดหงิดตลอด ผู้สูงอายุ

เป้าประสงค์ที่ ๕ ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
๒๗	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานควบคุม น้ำตาลได้	๒๖.๖๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๑. ขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบ บูรณาการร่วมกับงาน NCD ๒.พัฒนาคุณภาพบริการตาม กระบวนการประเมิน NCD Clinic Plus ๓. ชุมชนต้นแบบลดหวานมันเค็ม	๑. พัฒนาบุคลากรและแกนนำในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ ๒.
๒๘	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตได้	๕๓.๒๒	๖๐	๖๐	๖๐	๖๐		
๒๙	ร้อยละการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐม ภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	๗๓.๐๐	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานปฐมภูมิใน การให้บริการ	ติดตามประเมินผลการจัดบริการปฐมภูมิให้ได้มาร ฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
๓๐	อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย (๖๐ : ๔๐)	๑๒.๑๒	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนใน การดูแลและจัดการระบบสุขภาพ								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Baseline Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เป้าประสงค์ที่ ๖ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ								
๓๑	ร้อยละบุคลากรใน สสอ.ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย ๒ เรื่อง (Regulator & กฎหมายและ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕)	NA	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐	พัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	๑.อบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite ๒. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเข้ารับการอบรม
๓๒	ร้อยละหน่วยบริการได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการสาธารณสุข (SAP)	NA	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐	ยกระดับหน่วยบริการตามแผนการ พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ	จัดทำแผนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรงบประมาณ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างเพื่อรองรับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล								
ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ								
๓๓	จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จังหวัดขอนแก่น	๒๘๓ (เรื่อง)	๓๐๐ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๓๓๐ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๓๖๓ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	๔๐๐ (เรื่อง) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐	สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ โดยขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	๑.กำหนดประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประชาชน ๒.สนับสนุนด้านวิชาการแก่นักวิจัย ๓.สร้างแรงจูงใจ
๓๔	จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล						๑.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน	๑.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒.ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่มเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน ๓.จัดหาและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในทุกโรงพยาบาล ๓.กำหนดมาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลให้สอดคล้องกับเครือข่ายภายในเขตสุขภาพ
	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAIT	NA	๓	๖	๑๒	๒๖	๒. พัฒนาระบบสู่องค์กรดิจิทัล	
	Tele medicine	๑๔	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	๓.พัฒนาบุคลากรรองรับระบบการแพทย์ทางไกล	
	Tele pharmacy	NA	๖	๑๒	๒๐	๒๖	ระบบคิวออนไลน์	
	คิวออนไลน์	NA	๖	๑๒	๒๐	๒๖	๔.พัฒนา platform	
	Replication รพ.สต.>สสจ	๑๘๕ (๗๔.๖๐%)	๒๔๘	๒๔๘	๒๔๘	๒๔๘	สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะโรคเรื้อรัง	
๓๕	หน่วยบริการที่มีการบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด	๑๒,๓๙๒ ครั้ง	มีจำนวน รพ.ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และมีจำนวนการให้บริการไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ครั้ง	มีจำนวน รพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และให้บริการทางไกลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครั้ง ในการนัดหมายในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รพ.ทุกแห่ง ให้บริการทางไกล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของจำนวนครั้ง ในการนัดหมายในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	รพ.ทุกแห่งให้บริการทางไกลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๐ ของจำนวนครั้งในการนัดหมายในกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	๕.เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารดิจิทัลกับประชาชน	

ลำดับ	ตัวชี้วัด (KPI)	Base line Data	เป้าหมาย				กลยุทธ์	แผนการดำเนินการ
			๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐		
เป้าประสงค์ที่ ๘ หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน								
๓๖	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน HA ผ่านการรับรอง HA ชั้น ๓						-สร้างทีมเครือข่ายพี่เลี้ยง คุณภาพ (QLN) จ.ขอนแก่น -เตรียมความพร้อม รพ. ที่รับการ Acc./ Re accreditation - สนับสนุน รพ.F๓ สู่กระบวนการคุณภาพ	-อบรมความรู้ พัฒนาทักษะ เครือข่ายพี่เลี้ยงคุณภาพ (QLN) -ลงพื้นที่เยี่ยมเตรียม ความพร้อม (Pre Survey)
	- รพศ./ รพท.	๓	๓	๓	๓	๓		
	- รพช.	๑๖	๑๗	๑๘	๑๙	๑๙		
	- รพ. ระดับ F๓ (ตามเกณฑ์ที่ กำหนด)	๔	๔	๔	๔	๔		
๓๗	จำนวนสาธารณสุขอำเภอ ผ่านเกณฑ์ SMART สสอ.	NA	๕	๑๐	๑๕	๒๐	พัฒนาสาธารณสุขอำเภอ ตามเกณฑ์ SMART สสอ.	ติดตามประเมินผลการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๓๘	ร้อยละของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทุกสังกัด ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หน่วยบริการปฐมภูมิ	๙๙.๓๒ (ประเมิน ตนเอง)	มีพื้นที่นำ ร่อง	๓๐	๔๐	๕๐	๑. พัฒนาระบบบริการปฐม ภูมิที่มีคุณภาพ ๒. พัฒนาบุคลากรปฐมภูมิ	ติดตามประเมินผลการให้ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ ๙ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้ กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ								
๓๙	จำนวนโรงพยาบาลมีการบริหาร การเงินการคลังอย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ ๕๓.๘๔ (๑๔ แห่ง)	๑๖ แห่ง	๒๐ แห่ง	๒๔ แห่ง	๒๖ แห่ง	พัฒนาหน่วยบริการตาม แนวทาง ๗Plus Efficiency Score/๔S๔C/Bright Spot Hospital/TPS Scoreและ HA Back Office	๑.อบรมพัฒนาศูนย์จัดเก็บ รายได้ ๒ ครั้ง -ลงพื้นที่ เยี่ยมเสริมพลัง รพ. ที่มี ปัญหาสถานการณ์ทาง การเงิน ๒. ติดตามกำกับ โดย นำเสนอสถานการณ์ ทางการเงินผ่าน คกก.กวป.และ Dashboard ทางการเงิน

รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน																		
เป้าประสงค์ที่ ๑	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม																		
ชื่อตัวชี้วัด	๑.ร้อยละประชาชนวัยทำงานอายุ ๑๘-๕๙ ปี มี BMI เกินได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี BMI ลดลง (๑) ร้อยละประชาชนวัยทำงาน ๑๘-๕๙ ปี มี BMI เกิน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี BMI ลดลง (๒) ประชาชนวัยทำงาน ๑๘-๕๙ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ≥ ร้อยละ ๗๐																		
คำนิยาม	๑. วัยทำงาน หมายถึง ประชาชนในกลุ่ม อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีอายุ ๑๙ ปี ๐ เดือน ๑ วัน ถึง ๕๙ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ที่ยังไม่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ทั้งหมดในพื้นที่รับผิดชอบ รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) หมายถึง ค่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม กับส่วนสูงเป็นเมตร หน่วยวัดเป็น กิโลกรัม/เมตร ^๒ สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = $\frac{\text{น้ำหนัก (กิโลกรัม)}}{\text{ส่วนสูง (เมตร)} \times \text{ส่วนสูง (เมตร)}}$ การแปลผลค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้ <table><tr><td rowspan="2">BMI</td><td><๑๘.๕</td><td>๑๘.๕-๒๒.๙</td><td>๒๓.๐-๒๔.๙</td><td>๒๕.๐-๒๙.๙</td><td>≥๓๐</td></tr><tr><td>ผอม</td><td>ปกติ</td><td>น้ำหนักเกิน</td><td>อ้วนระดับ ๑</td><td>อ้วนระดับ ๒</td></tr></table> ๓. BMI เกินหมายถึง ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ ๑ (มีค่าอยู่ระหว่าง ๒๕.๐-๒๙.๙ กิโลกรัม/เมตร ^๒) และ อ้วนระดับ ๒ (มีค่า ≥๓๐ กิโลกรัม/เมตร ^๒) ๔. BMI ลดลง หมายถึง ค่า BMI ที่ลดลงจากเดิมภายหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	BMI	<๑๘.๕	๑๘.๕-๒๒.๙	๒๓.๐-๒๔.๙	๒๕.๐-๒๙.๙	≥๓๐	ผอม	ปกติ	น้ำหนักเกิน	อ้วนระดับ ๑	อ้วนระดับ ๒							
BMI	<๑๘.๕		๑๘.๕-๒๒.๙	๒๓.๐-๒๔.๙	๒๕.๐-๒๙.๙	≥๓๐													
	ผอม	ปกติ	น้ำหนักเกิน	อ้วนระดับ ๑	อ้วนระดับ ๒														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td></td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>KPI (๑)</td><td>NA</td><td>๒</td><td>๓</td><td>๔</td><td>๕</td></tr><tr><td>KPI (๒)</td><td>๔๐.๖๕</td><td>๗๐</td><td>๗๐</td><td>๘๐</td><td>๙๐</td></tr></table>		ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	KPI (๑)	NA	๒	๓	๔	๕	KPI (๒)	๔๐.๖๕	๗๐	๗๐	๘๐	๙๐
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐														
KPI (๑)	NA	๒	๓	๔	๕														
KPI (๒)	๔๐.๖๕	๗๐	๗๐	๘๐	๙๐														
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อายุ ๑๘-๕๙ ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการที่ครอบคลุม ๒.เพื่อให้ อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อายุ ๑๘-๕๙ ปี ที่มีค่าดัชนีมวลกายอ้วนระดับ ๑ และ อ้วนระดับ ๒ มี BMI ลดลงมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๒																		
กลุ่มเป้าหมาย	อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัด PCU/รพช/รพท/รพศ/สสอ ที่มีอายุ ๑๘-๕๙ ปี																		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รายงานผลการคัดกรองชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต ดัชนีมวลกาย จาก Health Data Center (HDC) จากแฟ้ม NCDScreen และ NUTRITION หรือ จากทะเบียนรายงาน																		
แหล่งข้อมูล	๑.หน่วยบริการทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (PCU/สสอ./รพช./รพท./รพศ.) ๒. ฐานข้อมูล Health Data Center																		

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๖๖

รายการข้อมูล ๑	ตัวตั้ง A = จำนวนกลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปีที่ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด																		
รายการข้อมูล ๒	ตัวหาร B=จำนวนกลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปีทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด/รอบปีงบประมาณ																		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละกลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง มากกว่า หรือเท่ากับ ร้อยละ ๗๐ $\frac{A \times 100}{B}$																		
รายการข้อมูล ๓	ตัวตั้ง C = จำนวนกลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปี ที่มีค่า BMI อ้วนระดับ ๑ และ ๒ มี BMI ลดลง																		
รายการข้อมูล ๔	ตัวหาร D = จำนวนกลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปี ที่มีค่า BMI อ้วนระดับ ๑ และ ๒ ในช่วงเวลาที่กำหนด/รอบปีงบประมาณ																		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ประชาชนวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปี ที่มีค่า BMI อ้วนระดับ๑ และ ๒ มี BMI ลดลง $\geq$ ร้อยละ ๒ $\frac{C \times 100}{D}$																		
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก ๓ เดือน																		
Small Success ปี ๒๕๖๗																			
<table><tr><td>รอบ ๓ เดือน</td><td>รอบ ๖ เดือน</td><td>รอบ ๙ เดือน</td><td>รอบ ๑๒ เดือน</td></tr><tr><td>$\geq$ร้อยละ ๒</td><td>$\geq$ร้อยละ ๒</td><td>$\geq$ร้อยละ ๒</td><td>ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒</td></tr><tr><td>$\geq$ร้อยละ ๗๐</td><td>$\geq$ร้อยละ ๗๐</td><td>$\geq$ร้อยละ ๗๐</td><td>$\geq$ร้อยละ ๗๐</td></tr></table>		รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	$\geq$ ร้อยละ ๒	$\geq$ ร้อยละ ๒	$\geq$ ร้อยละ ๒	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒	$\geq$ ร้อยละ ๗๐	$\geq$ ร้อยละ ๗๐	$\geq$ ร้อยละ ๗๐	$\geq$ ร้อยละ ๗๐						
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน																
$\geq$ ร้อยละ ๒	$\geq$ ร้อยละ ๒	$\geq$ ร้อยละ ๒	ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒																
$\geq$ ร้อยละ ๗๐	$\geq$ ร้อยละ ๗๐	$\geq$ ร้อยละ ๗๐	$\geq$ ร้อยละ ๗๐																
วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย																		
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน																			
<table><tr><th rowspan="2">Baseline Data</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ</th></tr><tr><th>ปี ๒๕๖๔</th><th>ปี ๒๕๖๕</th><th>ปี ๒๕๖๖</th></tr><tr><td>อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อายุ ๑๘-๕๔ ปี มี BMI เกิน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี BMI ลดลง</td><td>ร้อยละ</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr><tr><td>กลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปีได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง</td><td>ร้อยละ</td><td>๖๔.๗๙</td><td>๖๓.๐๓</td><td>๔๐.๖๕</td></tr></table>		Baseline Data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ			ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อายุ ๑๘-๕๔ ปี มี BMI เกิน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี BMI ลดลง	ร้อยละ	NA	NA	NA	กลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปีได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	ร้อยละ	๖๔.๗๙	๖๓.๐๓	๔๐.๖๕
Baseline Data	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ															
		ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖															
อสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อายุ ๑๘-๕๔ ปี มี BMI เกิน ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมี BMI ลดลง	ร้อยละ	NA	NA	NA															
กลุ่มวัยทำงาน ๑๘-๕๔ ปีได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	ร้อยละ	๖๔.๗๙	๖๓.๐๓	๔๐.๖๕															
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	๑. นางรุ่งทอง วัชรนุกุลเกียรติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๑-๗๓๙๙ ๒. นางสาวเทวารักษ์ ภูครองนา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ ๐๙ ๕๖๕๒ ๗๒๒๗ E-mail : theywarak.ph@gmail.com กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ... โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน				
เป้าประสงค์ที่ ๑	ประชาชนทุกกลุ่มวัย และผู้บริโภคมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม				
ตัวชี้วัด	๒.อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน (๑) อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง (๒) อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง (๓) อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมองลดลง				
คำนิยาม	๑ ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน และได้รับการขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และได้รับการขึ้นทะเบียน/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๓. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะหรือความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ โต้ตอบ ชักถาม จนสามารถประเมิน และตัดสินใจใช้ข้อมูลด้านสุขภาพ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การมีสุขภาพที่ดี และสามารถสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพต่อผู้อื่นได้ ๔. ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแบบเฉียบพลัน รหัส ICD๑๐ (I๒๐.๐,I๒๑-I๒๔) ในปีงบประมาณ ทุกกลุ่มอายุ ๕. ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal diagnosis: pdx) จากแพทย์พบว่าป่วยด้วยโรคสมอง รหัส ICD๑๐ (๑๖๐-๑๖๙) ในปีงบประมาณทุกกลุ่มอายุ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยโรคหลักซ้ำภายในระยะเวลา ๒๘ วันขึ้นไปให้นับเป็นผู้ป่วยรายใหม่อีกครั้ง				
เกณฑ์เป้าหมาย					
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
KPI (๑)	NA	๗๑	๗๒	๗๓	๗๔
KPI (๒)	NA	๔๕	๔๐	๓๕	๓๐
KPI (๓)	NA	๑๑๕	๑๑๐	๑๐๕	๑๐๐
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ๒) เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ ๓) เพื่อลดผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง				
กลุ่มเป้าหมาย	๑) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ๒) ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑) รายงานผลการบันทึกข้อมูลใน Health Data Center ๒) รายงานจาก Google Form ผ่านเว็บไซต์ สสจ.ขอนแก่น ๓) รายงานจาก รพ.สต./PCU/สสอ./รพช./รพท. ๔) รายงานจากการสุ่มถามผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกโรงพยาบาล/PCU/รพ.สต.				
แหล่งข้อมูล	๑) ฐานข้อมูลใน Health Data Center ๒) ฐานข้อมูลจาก รพ.สต./PCU//รพช./รพท. ๓) โปรแกรมการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				

	๔) Google From HL ในเว็บไซต์ สสจ.ขอนแก่น
รายการข้อมูล ๑	A = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล ๒	A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจรายใหม่ในปีงบประมาณ B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
รายการข้อมูล ๓	A = จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ในปีงบประมาณ B = จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ๑	$\frac{A \times 100}{B}$
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ๒	$\frac{A \times 100,000}{B}$
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ๓	$\frac{A \times 100,000}{B}$
ระยะเวลาประเมินผล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗

Small Success ปี ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
-รพช./รพท./รพ.สต. ลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านโปรแกรมสุขภาพ อุ่นใจ - มีคณะทำงานการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง - มีชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ๒๐	-ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการเสริมสร้างและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง>ร้อยละ ๖๐ - มีชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง >ร้อยละ๕๐	-ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการเสริมสร้างและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง >ร้อยละ ๖๕ - ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ<๔๕ต่อประชากรแสนคน และโรคหลอดเลือดสมอง <๑๑๕ ต่อประชากรแสนคน - รพช./รพท./รพ.สต. ลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านโปรแกรมสุขภาพ อุ่นใจ ร้อยละ ๑๐๐	-ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้รับการเสริมสร้างและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง >ร้อยละ ๗๕ - ผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลอดเลือดหัวใจ<๔๕ต่อประชากรแสนคน และโรคหลอดเลือดสมอง <๑๑๕ต่อประชากรแสนคน

วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
	อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง	NA	NA	NA
	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดหัวใจ (อัตราต่อแสน)	NA	NA	๕๓.๗๕
	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง (อัตราต่อแสน)	NA	NA	๒๘๑.๖๘
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวรรณกร ตาบ้านคู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ. ๐๖๓๕๘๓๕๕๕๒ E-mail : fnmyi๘๙k@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดกระทรวง	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
ชื่อตัวชี้วัด	๓.จำนวนอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
คำนิยาม	การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) หมายถึงการประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามองค์ประกอบ UCCARE ตามประเด็นที่พื้นที่กำหนดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความยั่งยืนสืบไป คุณภาพ หมายถึง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. มีการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอที่สามารถยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือตั้งแต่ระดับสามขึ้นไปทุกข้อ ตามองค์ประกอบ UCCARE ๒. มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผ่านตามเกณฑ์ผลลัพธ์ที่กำหนด อำเภอ หมายถึง หน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองและเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับท้องถิ่นและภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนร่วมกัน โดยใช้ปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ เป็นเป้าหมายร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ จำนวน ๒๖ อำเภอ กลุ่มเปราะบาง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ขาดความสามารถในการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนเนื่องจากขาดอำนาจ การศึกษา ทรัพยากร ความเข้มแข็ง มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกคุกคามจากปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติหรืออื่นๆ เป็นผู้มีข้อจำกัดในเรื่องในการจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่ตามมา การช่วยเหลือตัวเอง การตัดสินใจ และอำนาจต่อรอง ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ต้องการการสนับสนุน การปกป้อง การช่วยเหลือทางกาย จิต หรือทางสังคม จากผู้อื่น ตัวอย่างกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คนที่ถูกสังคมตีตรา ผู้ป่วยบางประเภท แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ผู้ติดสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย คนพิการ และคนที่ทำผิด กฎหมาย/อาชญากร กลุ่มเปราะบางด้านสุขภาพ พิจารณาจากปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคม อย่างน้อย ๒ ใน ๓ ปัจจัย ดังนี้ ๑)คนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เช่น คนยากจน คนไร้รัฐ ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย แรงงานข้ามชาติ เด็กกำพร้า ผู้เคยได้รับโทษ ฯลฯ ๒)คนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ เช่น ผู้ที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ คนที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล ๓)คนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้งหรือการถูกกระทำทารุณถ้าไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในระยะยาว เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย ผู้พิการทางจิตเวช ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง

	ประเด็นการพัฒนาคูณภาพชีวิตจังหวัดขอนแก่น ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑) คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ๑.๑ ดูแลกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุติดเตียง , ผู้พิการ ๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ ๑.๑.๒ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้น หรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ๑.๒ SMART KID ๔.๐ (พัฒนาการเด็ก) ๑.๒.๑ เด็กปฐมวัย ๑) เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ๒) เด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ และ ๖๐ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ ๓) เด็กอายุ ๐-๕ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ๔) เด็กอายุ ๐-๕ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ๑.๒.๒ เด็ก ๖-๑๔ ปี ๑) เด็ก ๖-๑๔ ปีมีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ๒) เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (ความครอบคลุม) *หมายเหตุ : ประเด็นที่ ๒ – ๔ เป็นประเด็นเพื่อติดตาม												
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><th>ตัวชี้วัด (KPI)</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</th></tr><tr><td>ร้อยละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคูณภาพชีวิต</td><td>๙๖.๑๕</td><td>๘๗**</td><td>๘๙**</td><td>๙๐**</td><td>๙๒**</td></tr></table> **หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมดหมี่ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีมติ ในประเด็นคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ให้เพิ่มประเด็นย่อยในข้อ ๑.๑ ดูแลกลุ่มเปราะบางฯ จำนวน ๒ ประเด็น (ข้อ ๑.๑๑ - ๑.๑๒)และข้อ ๑.๒ SMART KID ๔.๐ (พัฒนาการเด็ก) จำนวน ๖ ประเด็น (ข้อ๑.๒.๑ (ข้อย่อย ๒ ประเด็น) - ๑.๒.๒ (ข้อย่อย ๔ ประเด็น)) เพื่อให้การดำเนินงานประเด็นการพัฒนาคูณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (พขอ.) จังหวัดขอนแก่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ จึงใช้เกณฑ์เป้าหมายตามสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	ตัวชี้วัด (KPI)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ร้อยละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคูณภาพชีวิต	๙๖.๑๕	๘๗**	๘๙**	๙๐**	๙๒**
ตัวชี้วัด (KPI)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐								
ร้อยละอำเภอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาคูณภาพชีวิต	๙๖.๑๕	๘๗**	๘๙**	๙๐**	๙๒**								

เกณฑ์เป้าหมาย (ต่อ)	เกณฑ์การประเมินผล					
	ตัวชี้วัด (KPI)	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐
	๑. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	๗๗.๖๑	๘๖	๘๗	๘๘	๘๙
	๑.๑ ร้อยละเด็ก ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ และ ๖๐ เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ	๘๐.๖๔	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖
	๑.๒ ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๖๗.๒๓	๗๖	๗๘	๘๐	๘๒
	๑.๓ ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง	๖๖.๗๑	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘
	๒.๑ ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๖๓.๐๘	๖๔	๖๖	๖๘	๗๒
	๒.๒ ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดสวนสูง (ความครอบคลุม)	๗๕.๖๙	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖
	๓.๑ ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	๙๔.๖	๙๖	๙๗	๙๘	๙๙
	๓.๒ ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้น หรือ กลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น	๒๑.๔	๒๕	๒๗	๒๙	๓๑
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ “พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑					
กลุ่มเป้าหมาย	ทุกอำเภอ (๒๖ อำเภอ)					

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑. ระบบรายงาน HDC ๒. รายงานโปรแกรม CL UCCARE ๓. ผลการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามแนวทาง UCCARE ก่อน – หลังดำเนินการรายประเด็น															
แหล่งข้อมูล	๑. ระบบรายงาน HDC ๒. รายงานโปรแกรม CL UCCARE															
รายการข้อมูล	๑. คำสั่งคณะกรรมการ พขอ. และ อนุกรรมการ พขอ. รายประเด็นที่เป็นปัจจุบัน ๒. รายงานการประเมินตนเองระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามแนวทาง UCCARE ก่อน – หลังดำเนินการ ๓. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ๔. แผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รายประเด็น ประจำปี ๕. รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอประจำปี															
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑. ระดับจังหวัด (A/B)×๑๐๐ A = จำนวนอำเภอที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ B = จำนวนอำเภอเป้าหมาย ๒๖ อำเภอ															
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส															
Small Success ปี ๒๕๖๗																
<table><tr><th>รอบ ๓ เดือน</th><th>รอบ ๖ เดือน</th><th>รอบ ๙ เดือน</th><th>รอบ ๑๒ เดือน</th></tr><tr><td>- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ พขอ./ อนุกรรมการ พขอ. - ประเมินตนเอง ตามแนวทาง UCCARE ก่อนดำเนินการ - วางแผนขับเคลื่อน พขอ.</td><td>- ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนรายประเด็น - มีการบริหารจัดการทรัพยากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง</td><td>- เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน - ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE หลัง ดำเนินงาน</td><td>- ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน - ตัวชี้วัดย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัว</td></tr></table>		รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ พขอ./ อนุกรรมการ พขอ. - ประเมินตนเอง ตามแนวทาง UCCARE ก่อนดำเนินการ - วางแผนขับเคลื่อน พขอ.	- ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนรายประเด็น - มีการบริหารจัดการทรัพยากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	- เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน - ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE หลัง ดำเนินงาน	- ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน - ตัวชี้วัดย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัว							
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน													
- ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ พขอ./ อนุกรรมการ พขอ. - ประเมินตนเอง ตามแนวทาง UCCARE ก่อนดำเนินการ - วางแผนขับเคลื่อน พขอ.	- ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนรายประเด็น - มีการบริหารจัดการทรัพยากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	- เยี่ยมเสริมพลังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน - ประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE หลัง ดำเนินงาน	- ประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน - ตัวชี้วัดย่อยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัว													
วิธีการประเมิน	๑. ประเมินจากข้อมูลในระบบ HDC สสจ.ขอนแก่น ๒. โปรแกรม CL UCCARE ๓. ประเมินการดำเนินงานจากการนิเทศงาน ประเมินผลระดับ CUP															
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี ๒๕๖๔</th><th>ปี ๒๕๖๕</th><th>ปี ๒๕๖๖</th><th>ปี ๒๕๖๗</th></tr><tr><td>เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ)</td><td>๗๕</td><td>๗๕</td><td>๘๕</td><td>๘๗</td></tr><tr><td>ผลงานอำเภอผ่านเกณฑ์</td><td>๘๙.๒๓</td><td>๘๖.๑๖</td><td>๙๖.๑๕</td><td></td></tr></table>	ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ)	๗๕	๗๕	๘๕	๘๗	ผลงานอำเภอผ่านเกณฑ์	๘๙.๒๓	๘๖.๑๖	๙๖.๑๕	
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗												
เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ)	๗๕	๗๕	๘๕	๘๗												
ผลงานอำเภอผ่านเกณฑ์	๘๙.๒๓	๘๖.๑๖	๙๖.๑๕													

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	๑.นางสาวผดาร์ณัช พลไชยมาตย์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๘๕๕ ๑๖๖๙ E-mail : phadarnuch@gmail.com ๒.นางสาวปุณณภา โพธิ์สิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐ ๔๓๒๒ ๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๙๗๑๒ ๗๕๕๒ E-mail : publico๐๐๓๒@gmail.com
-----------------------------------	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ชื่อตัวชี้วัด	๔. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
คำนิยาม	เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน เด็กพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งแรก) หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้ คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)* แล้วผลการตรวจคัดกรองผ่านครบ ๕ ด้านในการตรวจคัดกรองพัฒนาการครั้งแรก เด็กที่ได้รับการกระตุ้นภายใน ๓๐ วันมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) หมายถึง เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการภายใน ๓๐ วัน และประเมินซ้ำแล้วผลการประเมิน ผ่านครบ ๕ ด้าน การคัดกรองพัฒนาการ หมายถึง ความครอบคลุมของการคัดกรองเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ และ ๖๐ เดือน ณ ช่วงเวลาที่มีการคัดกรองโดยเป็นเด็กในพื้นที่ (Type ๑: มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตัวอยู่จริงและ Type ๓ : ที่อาศัยอยู่ในเขต แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับตรวจคัดกรองพัฒนาการโดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ ๕ ด้าน ทั้งเด็กที่ต้องแนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน ๓๐ วัน (๑B๒๖๑) รวมกับเด็กที่สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที (๑B๒๖๒ : เด็กที่พัฒนาการล่าช้า/ความผิดปกติอย่างชัดเจน) พัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการตามอายุของเด็กในการประเมินพัฒนาการครั้งแรกผ่านไม่ครบ ๕ ด้าน เฉพาะกลุ่มที่แนะนำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนาการตามวัยภายใน ๓๐ วัน (๑B๒๖๑) แล้วติดตามกลับมาประเมินคัดกรองพัฒนาการครั้งที่ ๒ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความล่าช้า หมายถึง เด็กปฐมวัยอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือน ที่ประเมินด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM) ครั้งที่ ๑ แล้วพบว่าต้องส่งต่อ และเด็กอายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒, ๖๐ เดือนที่มาประเมินซ้ำ ด้วยคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: DSPM ครั้งที่ ๒ แล้วยังพบมีความล่าช้าอย่างน้อย ๑ ด้านขึ้นไป ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน หมายถึง การที่เด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีความล่าช้า ได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมและ/ หรือ ประเมินพัฒนาการ พร้อมทั้งกระตุ้นพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention: TEDA๔) หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ เช่น คู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด-๕ ปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข คู่มือประเมินและแก้ไขพัฒนาการเด็กแรกเกิด-๕ ปี โปรแกรมการฝึก/ กระตุ้นพัฒนาการตามวิชาชีพ (นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย) เป็นต้น ตำบล合格率 ๑,๐๐๐ วัน Plus ๒,๕๐๐ วัน หมายถึง ตำบลที่มีการดำเนินงาน

	ดูแลส่งเสริมสุขภาพ และคุ้มครองสตรีและเด็กปฐมวัย ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็กแรกเกิด - ๕ ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยไทยเติบโตเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนและท้องถิ่น ระดับตำบล		
เกณฑ์เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ ประกอบด้วย ๑. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๖ ๑) ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ตรวจครั้งแรก)		
วัตถุประสงค์	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก อายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย และมีระดับสติปัญญาดี		
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	สถานบริการทุกระดับ นำข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการฯ เช่น JHCIS, Hos xp, PCU เป็นต้น ส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม		
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง		
รายการข้อมูล	A = จำนวนเด็กอายุ ๙ ๑ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน ผลรวมของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย จากตรวจครั้งที่ ๑ และ ๒ B = จำนวนเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน C = จำนวนเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการทั้งหมด D = จำนวนเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑. ร้อยละเด็กมีพัฒนาการสมวัย = (A/B) x ๑๐๐ ๒. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (ตรวจครั้งแรก) = (C/D) x ๑๐๐		
ระยะเวลาประเมิน	๑๒ เดือน		
เกณฑ์การประเมิน			
Small Success ปี ๒๕๖๗			
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
- แผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง - แผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาคัดกรองพัฒนาการภาวะ เตี้ย ผอม อ้วน และปฐมวัยรายบุคคลและรายกลุ่ม - แผนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน การ	- แนวทางแก้ปัญหาพัฒนาการ ภาวะ เตี้ย ผอม อ้วน เด็กปฐมวัยรายบุคคลและรายกลุ่ม - จำนวนตำบลที่ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ ๒,๕๐๐ วัน - จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประเมินตนเองและครูที่ผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กตามมาตรฐานชาติด้าน	- ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยของพื้นที่ - สรุปผลการติดตามสะท้อนปัญหาอุปสรรค และแผนปรับปรุงกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในรอบ ๑๒ เดือน	- ระบบคัดกรองพัฒนาการโภชนาการการเจริญเติบโตและการจัดการแก้ไขปัญหาคัดกรองพัฒนาการ ทพโภชนาการที่เข้มแข็ง - ตำบล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลในพื้นที่ - มีพื้นที่ต้นแบบ Smart kids Area ๗: SA๗ดำเนินงานคุณภาพ

ประเมินตนเอง และ การรับรองเป็นตำบล มหัศจรรย์ฯ อำเภอละ ๑ ตำบล	สุขภาพและสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยอายุต่ำกว่า ๒ ปี - จำนวน บุ ค ล า กร / ผู้ปกครองที่ได้รับการพัฒนา เพื่อสร้างความรอบรู้ด้าน พัฒนาการ วินัยเชิงบวก ความฉลาดทางอารมณ์ การ ดูแลสุขภาพ (๔D) การดูแล เด็กต่ำกว่า ๒ ปี และ ผู้อำนวยการเล่นระดับ ครอบครัว - จำนวนพื้นที่ต้นแบบ Smart kids Area ๗: SA๗ ดำเนินงานคุณภาพ		- ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ พัฒนาเด็กปฐมวัยต่อเนื่อง
---	---	--	---

วิธีการประเมินผล	ผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน HDC และผลงานเชิงคุณภาพ
------------------	---

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี

ตัวชี้วัด	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบ ปีงบประมาณ		
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑) ร้อยละเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	๗๗.๖๐	ร้อยละ	๙๗.๓๙	๙๘.๙๙	๗๗.๖๐
๒) ร้อยละของเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ตรวจครั้งแรก)	๘๐.๖๔	ร้อยละ	๙๕.๖๑	๙๗.๐๓	๘๐.๖๔
๓) ร้อยละของเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)	๓๒.๖๔	ร้อยละ	๔๐.๐๗	๓๖.๐๙	๓๒.๖๔
๔) ร้อยละของเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือน พบพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม กระตุ้นพัฒนาการ	๘๘.๗๑	ร้อยละ	๙๓.๗๙	๙๗.๓๕	๘๘.๗๑
๕) ร้อยละของเด็กอายุ ๙ ๑๘ ๓๐ ๔๒ และ ๖๐ เดือนที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้า ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน	๖๗.๕๗	ร้อยละ	๖๖.๑๘	๖๗.๗๔	๖๗.๕๗

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/กลุ่มงาน

๑. นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา	ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๒. นางวรินทร์รัตน์ ชันธะฮาด	ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๓. นางสาวธัญธร แฝงฤทธิ์	ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทร. ๐๔๓ - ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙	มือถือ ๐๙๘-๕๓๒๖๕๕๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัย สิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ชื่อตัวชี้วัด	๕.ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน
คำนิยาม	เด็กอายุปฐมวัย หมายถึง เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน สูงดี หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง) เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโตความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีความมากกว่าหรือเท่ากับ -๑.๕ SDของความยาว/ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต น้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง กรมอนามัย ชุดใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ขององค์การอนามัยโลก) โดยมีความอยู่ในช่วง +๑.๕ SD ถึง -๑.๕ SD ของน้ำหนักตามเกณฑ์ความยาว/ส่วนสูง สูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไปและมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี หมายถึง ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงในเด็กชาย และเด็กหญิงที่อายุ ๕ ปีเต็ม ถึง ๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน เด็กชายส่วนสูงเฉลี่ย ๑๑๓ ซม. เด็กหญิงส่วนสูงเฉลี่ย ๑๑๒ ซม. ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาน้ำที่ส่วนผสมของยาเสริมธาตุเหล็ก elemental iron ๑๒.๕ มิลลิกรัม สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือนถึง ๒ ปี และ ๒๕ มิลลิกรัม สำหรับ ๒ - ๕ ปี ได้รับ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์
เกณฑ์เป้าหมาย	ผลลัพธ์ ๑) ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๖ ๒) ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
วัตถุประสงค์	เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก อายุ ๐ - ๕ ปี มีพัฒนาการสมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ และมี ระดับสติปัญญาดี
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี
วิธีการเก็บข้อมูล	รพ.สต. และ PCU ของโรงพยาบาลนำข้อมูลน้ำหนักส่วนสูงของเด็กที่เป็นปัจจุบัน จาก หมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก และสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งไม่รวมการรับบริการในกรณีเจ็บป่วย บันทึกในโปรแกรมหลักของสถานบริการ เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น และส่งออกข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน ๔๓ แฟ้ม
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลทุกแห่ง /สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ/ รพ.สต.ทุกแห่ง
รายการข้อมูล	A = จำนวนเด็กอายุ ๐-๕ ปีสูงดีสมส่วน
	B๑ = จำนวนเด็กอายุ ๐-๕ ปี ทั้งหมด
	B๒ = จำนวนเด็กอายุ ๐-๕ ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง = $(B๒ \times ๑๐๐) / B๑$ ๒. ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน = $(A \times ๑๐๐) / B๒$
ระยะเวลาประเมิน	๑๒ เดือน

เกณฑ์การประเมิน			
Small success ปี ๒๕๖๗			
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
- แผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เกี่ยวข้อง - แผนการดำเนินการแก้ไขปัญห พัฒนาการ ภาวะ เตี้ย ผอม อ้วน และปฐมวัยรายบุคคล และรายกลุ่ม - แผนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สูง ๒,๕๐๐ วัน การประเมินตนเอง และการรับรองเป็นตำบลมหัศจรรย์ฯ อำเภอละ ๑ ตำบล	- แนวทางแก้ปัญหา พัฒนาการ ภาวะ เตี้ย ผอม อ้วน เด็กปฐมวัยรายบุคคล และรายกลุ่ม - จำนวนตำบลที่ประเมินตนเองตามเกณฑ์ตำบลมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สูง ๒,๕๐๐ วัน - จำนวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ประเมินตนเอง และครูที่ผ่านหลักสูตรการดูแลเด็กตามมาตรฐานชาติ ด้านสุขภาพและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า ๒ ปี - จำนวนบุคลากร/ผู้ปกครองที่ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านพัฒนาการ วินัยเชิงบวก ความฉลาดทางอารมณ์ การดูแลสุขภาพ (๔D) การดูแลเด็กต่ำกว่า ๒ ปี และผู้อำนวยการเล่นระดับครอบครัว - จำนวนพื้นที่ต้นแบบ Smart kids Area ๗: SA๗ ดำเนินงานคุณภาพ	- ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัยของพื้นที่ - สรุปผลการติดตามสะท้อนปัญหาอุปสรรค และแผนปรับกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในรอบ ๑๒ เดือน	- ระบบคัดกรอง พัฒนาการ โภชนาการการเจริญเติบโต และการจัดการแก้ไขปัญหา พัฒนาการ ทพโภชนาการที่เข้มแข็ง - ตำบล/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลในพื้นที่ - มีพื้นที่ต้นแบบ Smart kids Area ๗: SA๗ ดำเนินงานคุณภาพ - ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อเนื่อง

วิธีการประเมินผล		ผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงาน HDC และผลงานเชิงคุณภาพ			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี					
ตัวชี้วัด	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ		
			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
๑) ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี สูงดีสมส่วน	๖๗.๒๓	ร้อยละ	๗๔.๙๐	๗๓.๑๓	๖๗.๒๓
๒) ร้อยละของเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	๖๖.๗๑	ร้อยละ	๘๘.๙๘	๘๖.๔๖	๖๖.๗๑
๓) ร้อยละของเด็กอายุ ๖ เดือน - ๕ ปี ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก	๘๓.๐๗	ร้อยละ	๘๗.๖๐	๗๙.๖๗	๘๓.๐๗
๔) ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน	๗.๗๗	ร้อยละ	๒.๗๐	๓.๒๕	๗.๗๗
๕) ร้อยละเด็ก ๐-๕ ปี มีภาวะผอม	๕.๒๐	ร้อยละ	๖.๐๐	๗.๔๐	๕.๒๐
๖) ร้อยละเด็ก ๐- ๕ ปี มีภาวะเตี้ย	๘.๐๑	ร้อยละ	๖.๗๐	๕.๙๒	๘.๐๑
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/กลุ่มงาน					
ชื่อ-สกุล :					
๑. นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา		ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
๒. นางวรินทร์รัตน์ ชันธะอาด		ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			
๓. นางธัญธร แฝงฤทธิ์		ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น			
โทร. ๐๔๓ – ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙		มือถือ ๐๙๘-๕๓๖๕๕๑			
หัวหน้ากลุ่มงาน					
นางรุ่งทอง วัชรนุกุลเกียรติ		ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ			
กลุ่มงาน : ส่งเสริมสุขภาพ		สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น			
โทร. ๐๔๓ – ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙					

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน																							
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน																							
ข้อตัวชี้วัด	๖.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน																							
คำนิยาม	เด็กวัยเรียน หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปี จนถึง ๑๔ ปี (โดยเริ่มนับตั้งแต่อายุ ๖ ปีเต็ม ถึง ๑๔ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) - โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส และมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓) - สูงดี หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัยปี ๒๕๔๒ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ -๑.๕ S.D ของส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ - สมส่วน หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกราฟการเจริญเติบโต กรมอนามัย ปี ๒๕๔๒ มีค่าระหว่าง +๑.๕ S.D ถึง -๑.๕ S.D ของน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง - เด็กสูงดีสมส่วน หมายถึง เด็กที่มีส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์+ค่อนข้างสูง+สูง และมีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน (ในคนเดียวกัน) - ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง > +๒ S.D.ขึ้นไปโดยใช้กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของกรมอนามัย ปี ๒๕๔๒ - ภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์ส่วนสูงเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า -๒S.D แสดงว่าเด็กมีน้ำหนักน้อยกว่าเด็กที่มีส่วนสูงเดียวกัน - ภาวะเตี้ย หมายถึง ส่วนสูงของเด็กเมื่อเทียบกับเกณฑ์อายุเดียวกัน มีค่าต่ำกว่า -๒ S.D แสดงว่าเด็กเติบโตไม่ดี อาจเนื่องจากการขาดอาหารเรื้อรัง หรือมีการเจ็บป่วยบ่อย ๆ																							
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><th>ค่าเป้าหมาย</th><th>Base line Data</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</th><th>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</th></tr><tr><td>๖.๑ ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน</td><td>๗๑.๒๐</td><td>๖๔</td><td>๖๖</td><td>๖๘</td><td>๗๒</td></tr><tr><td>๖.๒ เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง</td><td>๗๕.๖๙</td><td>๘๐</td><td>๘๒</td><td>๘๔</td><td>๘๖</td></tr></table>						ค่าเป้าหมาย	Base line Data	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	๖.๑ ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๗๑.๒๐	๖๔	๖๖	๖๘	๗๒	๖.๒ เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	๗๕.๖๙	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖
ค่าเป้าหมาย	Base line Data	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐																			
๖.๑ ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน	๗๑.๒๐	๖๔	๖๖	๖๘	๗๒																			
๖.๒ เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง	๗๕.๖๙	๘๐	๘๒	๘๔	๘๖																			
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน																							
กลุ่มเป้าหมาย	เด็กนักเรียน อายุ ๖-๑๔ ปี ในโรงเรียนทุกสังกัด (โรงเรียนประถมศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส, มัธยมศึกษา(ม.๑-ม.๓)																							
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.ระบบรายงาน ๔๓ แฟ้ม ส่งเข้า HDC ฐานข้อมูลจากแฟ้ม NUTRITION ๒. HDC Datacenter กลุ่มรายงานมาตรฐาน งานโภชนาการ																							

แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์								
รายการข้อมูล	A = จำนวนเด็กนักเรียนอายุ ๖-๑๔ ปี ที่มีส่วนสูงในระดับดีและรูปร่างสมส่วน B = จำนวนเด็กนักเรียนอายุ ๖-๑๔ ปีที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด C = จำนวนเด็กนักเรียนอายุ ๖-๑๔ ทั้งหมด								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑. ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน สูตรคำนวณตัวชี้วัด : (Ax๑๐๐)/B ๒. เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง สูตรคำนวณตัวชี้วัด : (Bx๑๐๐)/C								
ระยะเวลา ประเมินผล	ภาคเรียนที่ ๑ (๓๑ กรกฎาคม) ภาคเรียนที่ ๒ (๓๑ ธันวาคม)								
Small Success ปี ๒๕๖๗									
<table><tr><td>รอบ ๓ เดือน</td><td>รอบ ๖ เดือน</td><td>รอบ ๙ เดือน</td><td>รอบ ๑๒ เดือน</td></tr><tr><td></td><td>๑.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน > ร้อยละ ๖๔ ๒. เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง > ร้อยละ ๘๐</td><td></td><td>๑.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดี รูปร่างสมส่วน > ร้อยละ ๖๔ ๒.เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง > ร้อยละ ๘๐</td></tr></table>		รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน		๑.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน > ร้อยละ ๖๔ ๒. เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง > ร้อยละ ๘๐		๑.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดี รูปร่างสมส่วน > ร้อยละ ๖๔ ๒.เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง > ร้อยละ ๘๐
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน						
	๑.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน > ร้อยละ ๖๔ ๒. เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง > ร้อยละ ๘๐		๑.ร้อยละเด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดี รูปร่างสมส่วน > ร้อยละ ๖๔ ๒.เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่ง น้ำหนัก วัดส่วนสูง > ร้อยละ ๘๐						
วิธีการประเมิน	๑.เด็ก ๖-๑๔ ปี มีส่วนสูงดีรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๔ ๒.เด็ก ๖-๑๔ ปี ได้รับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐								
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด									
๑.นางวรวัลย์ เกษมศรีวิวัฒน์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๑๕๕๕๕๑๐									
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗ e-mail worawalai.k@gmail.com									
๒.นายสุรัตน์ หินวิเศษ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๐๘๗๑๙๒๘									
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗ e-mail kkpho.healthpromoting@gmail.com									

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดกระทรวง	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์
ชื่อตัวชี้วัด	๗. ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ (๑) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ (๒) ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้น หรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น
คำนิยาม	๑) ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป ๒) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน (ADL ๕-๑๑ คะแนน) กลุ่มติดเตียง (ADL ๐-๔ คะแนน) ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ตามชุดสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ๓) ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง ประชาชนที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน (ADL ๕-๑๑ คะแนน) กลุ่มติดเตียง (ADL ๐-๔ คะแนน) ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสาธารณสุข ทีมสหวิชาชีพตามแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ตามชุดสิทธิประโยชน์ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ๔) แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หมายถึง แบบการวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจาก Care Manager ทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๕) การประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพขั้นพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ หมายถึง - การประเมินผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามกลุ่มศักยภาพด้วยการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันทุกราย และกรณีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการประเมินรอบ ๑๒ เดือน - ประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ๙ ด้าน ๖) การเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์ หมายถึง การลงเยี่ยมและให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพและอุปกรณ์สนับสนุน ตามประกาศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามเกณฑ์กลุ่มภาวะพึ่งพิงกองทุน Long Term Care โดยบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในแต่ละกลุ่มจะถูกประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคลและจัดทำ Care Plan โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Care Manager และได้รับการเยี่ยมบ้านตาม Care Plan โดย Caregiver ๗) คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (คณะอนุกรรมการ LTC) หมายถึง คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ โดยมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติโครงการ LTC แผนการดูแลรายบุคคล Care Plan รวมถึงค่าใช้จ่ายตามแผนการดูแลรายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน หน่วยบริการ หรือสถานบริการ

วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้ Care Manager /Caregiver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และทีมสหวิชาชีพมีการวางแผนการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูและการพัฒนาระบบการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงแบบรอบด้านในระดับครอบครัว ชุมชนเป็นรายบุคคล ๒) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอายุยืนยาวและช่วยเหลือตนเองได้ ๓) เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์
กลุ่มเป้าหมาย	๑) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ๒) ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑) รายงานผลการคัดกรอง ADL ในฐานข้อมูล Health Data Center ๒) รายงานการจัดทำ Care Plan และการอนุมัติ Care Plan ผ่านคณะกรรมการกองทุน LTC ระดับตำบลและบันทึกข้อมูล CP ที่ผ่านการอนุมัติรายงานในระบบโปรแกรม LTC กรมอนามัยและ สปสช. ๓) รายงานผลค่าคะแนน ADL การดูแลกลุ่มภาวะพึ่งพิง ๑๒ เดือน โปรแกรม LTC สปสช. และแบบรายงานผลการดูแลกลุ่มภาวะพึ่งพิงเปลี่ยนกลุ่ม
แหล่งข้อมูล	๑) ฐานข้อมูลการคัดกรอง ADL ใน Health Data Center ๒) โปรแกรม Long Term Care กรมอนามัย ๓) โปรแกรม Long Term Care สปสช.
รายการข้อมูล ๑	A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดทำ Care Plan โดย Care Plan ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ LTC และได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ LTC
รายการข้อมูล ๒	A = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ครบ ๑๒ เดือน ที่มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้น และกลุ่มติดเตียงมีค่า ADL เท่าเดิมหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น B = จำนวนผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับอนุมัติ Care Plan จากคณะกรรมการ LTC และได้รับการเยี่ยมบ้านจาก Caregiver ครบการดูแล ๑๒ เดือน ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ๑	$\frac{A \times 100}{B}$
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ๒	$\frac{A \times 100}{B}$
ระยะเวลาประเมินผล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗
วิธีการประเมิน	๑) อสม.ประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ๙ ด้าน ๒) Care Manager/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข PCU/รพสต./รพ. ประเมินผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตามกลุ่มศักยภาพด้วยการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน(ADL) ๓) Care Manager มีการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและ Care Plan ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ LTC ๔) ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan ๕) ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์

Small Success ปี ๒๕๖๗																			
<table><tr><td>รอบ ๓ เดือน</td><td>รอบ ๖ เดือน</td><td>รอบ ๙ เดือน</td><td>รอบ ๑๒ เดือน</td></tr><tr><td>- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย ๙ ด้าน และกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการจัดทำ Care Plan - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๖๖</td><td>- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๗๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕</td><td>- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๘๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น >ร้อยละ ๒๐</td><td>- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๙๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น >ร้อยละ ๒๕</td></tr></table>					รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย ๙ ด้าน และกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการจัดทำ Care Plan - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๖๖	- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๗๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕	- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๘๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น >ร้อยละ ๒๐	- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๙๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น >ร้อยละ ๒๕							
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน																
- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะถดถอย ๙ ด้าน และกลุ่มติดบ้านติดเตียงได้รับการจัดทำ Care Plan - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๖๖	- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๗๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๕	- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๘๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น >ร้อยละ ๒๐	- ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์ >ร้อยละ ๙๖ - ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น >ร้อยละ ๒๕																
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)																			
<table><tr><td>ผลงาน</td><td>ปี ๒๕๖๔</td><td>ปี ๒๕๖๕</td><td>ปี ๒๕๖๖</td><td>ปี ๒๕๖๗</td></tr><tr><td>ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์</td><td>๙๖.๗๓</td><td>๙๖.๖๗</td><td>๙๔.๖๑</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น</td><td>๔.๗๓</td><td>๑๔.๖๖</td><td>๒๑.๔๓</td><td>-</td></tr></table>					ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	๙๖.๗๓	๙๖.๖๗	๙๔.๖๑	-	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น	๔.๗๓	๑๔.๖๖	๒๑.๔๓	-
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗															
ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลในระบบ Long Term Care และเข้าถึงตามชุดสิทธิประโยชน์	๙๖.๗๓	๙๖.๖๗	๙๔.๖๑	-															
ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan มีค่าคะแนน ADL เพิ่มขึ้นหรือกลุ่มติดเตียงไม่มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น	๔.๗๓	๑๔.๖๖	๒๑.๔๓	-															
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางอังคณา อึ้งปีติมานะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ. ๐๖๑๗๙๒๙๙๔๒ E-mail :ungpitimana.ang@gmail.com																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน					
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน					
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราส่วนการตายมารดาไทย					
ชื่อตัวชี้วัด	๘.อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน ๑๗ ต่อการเกิดมีชีพแสนคน					
คำนิยาม	การตายมารดา หมายถึง การตายมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน ๔๒ วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด จากสาเหตุที่เกี่ยวข้อง หรือก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นจากการตั้งครรภ์และคลอดหรือการดูแลรักษา ขณะตั้งครรภ์รวมถึงการฆ่าตัวตาย แต่ไม่ใช่จากอุบัติเหตุและฆาตกรรม ต่อการเกิดมีชีพแสนคน					
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	
	≤ ๑๖ ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ ๑๕ ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ ๑๔ ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ ๑๓ ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ ๑๒ ต่อการเกิดมีชีพพันคน	
	< ๑ คน	๑ คน	๑ คน	๑ คน	๑ คน	
วัตถุประสงค์	เฝ้าระวังสตรีช่วงตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ให้ได้รับบริการคุณภาพตามเกณฑ์เพื่อลดจำนวนการตายของมารดา					
กลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และหญิงหลังคลอดภายใน ๔๒ วัน					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง ๔๓ แฟ้ม ๒.รายงานการตายมารดา (แบบ CE-๖๒)					
แหล่งข้อมูล	๑.หน่วยบริการทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ๒.ทะเบียนราษฎร์ /แบบรายงานการตายมารดา CE-๖๒ ๓. ฐานข้อมูล Health Data Center					
รายการข้อมูล ๑	ตัวตั้ง A = จำนวนมารดาตายระหว่างตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอดภายใน ๔๒ วันทุกสาเหตุยกเว้นอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาที่กำหนด					
รายการข้อมูล ๒	ตัวหาร B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน					
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(AxB) x ๑๐๐,๐๐๐					
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก ๓ เดือน					

Small Success ปี ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
ไม่เกิน ๑๖	ไม่เกิน ๑๖	ไม่เกิน ๑๖	ไม่เกิน ๑๖
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน	ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

วิธีการประเมิน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน				
	Baseline Data	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
		ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	
	การตายมารดาไทยไม่เกิน ๑๗ ต่อการ เกิดมีชีพแสนคน	๒๒.๘๑ (๔ คน)	๒๓.๕๕ (๓ คน)	
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสมพร สุระเทมียกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ... โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๕-๓๙๕๖๔๖๖ E-mail : narinratkaewla@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน				
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน				
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราการตายทารกแรกเกิด				
ชื่อตัวชี้วัด	๙.อัตราการตายทารกแรกเกิด ไม่เกิน ๓.๖ ต่อการเกิดมีชีพพันคน				
คำนิยาม	ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกที่มีน้ำหนัก ≥ 500 กรัม ที่คลอดมามีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึง ๒๘ วัน ในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช.)				
เกณฑ์เป้าหมาย					
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	≤ 2.6 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.5 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.3 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.2 ต่อการเกิดมีชีพพันคน	≤ 2.0 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้ทั่วถึง ๒.เพื่อลดอัตราการตายทารกแรกเกิด				
กลุ่มเป้าหมาย	ทารกที่คลอดและมีชีวิตจนถึง ๒๘ วัน				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.บันทึกข้อมูลการให้บริการในโปรแกรมของแต่ละสถานบริการและส่งออกข้อมูลตามแนวทาง ๔๓ แฟ้ม ๒.รายงานการตายทารก จากโปรแกรม Newborn registry เขตสุขภาพที่ ๗				
แหล่งข้อมูล	๑.หน่วยบริการทุกระดับในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ๒.ฐานข้อมูล Health Data Center				
รายการข้อมูล ๑	A = จำนวนทารกที่เสียชีวิต ≤ 28 วัน				
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนเด็กเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A \times B) \times 1,000$				
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก ๓ เดือน				
Small Success ปี ๒๕๖๗					
รอบ ๓ เดือน		รอบ ๖ เดือน		รอบ ๙ เดือน	
ไม่เกิน ๒.๕		ไม่เกิน ๒.๕		ไม่เกิน ๒.๕	
ต่อการเกิดมีชีพพันคน		ต่อการเกิดมีชีพพันคน		ต่อการเกิดมีชีพพันคน	

วิธีการประเมิน		เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน					
Baseline Data		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ		
อัตราตายทารกแรกเกิด	อัตราตายทารกแรกเกิดต่อ เกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	
		๓.๒๐	๒.๘๐	๒.๖๐	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสมาพร สุระเทมียกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๙ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๕-๓๙๕๖๔๖๖ E-mail : narinratkaewla@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดกระทรวง	๑.ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง ๒.ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) ๓.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
ชื่อตัวชี้วัด	๑๐.ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง
คำนิยาม	๑.ผู้สูงอายุ หมายถึง ตามความ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ๒.ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี หมายถึง ผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๑ (กลุ่มติดสังคม) จากการประเมิน ADL คะแนน ตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป ที่สามารถให้การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น ในชุมชน และสังคมได้ พร้อมทั้งมี พฤติกรรมสุขภาพอันพึงประสงค์ และไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุ ๓.แผนการดูแลส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล (Individual Wellness Plan) หมายถึง เครื่องมือในการ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้ให้ ความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ทักษะทางปัญญาและสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนด แรงจูงใจและความสามารถของปัจเจกในการแสวงหา ทำความเข้าใจและการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและ ดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี ๔.ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) หมายถึง หน่วยบริการ สาธารณสุขร่วมกับชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุมีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) เข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ๒) ประเมินตนเองตามแนวทางการประเมินเพื่อรับรู้สถานการณ์สุขภาพ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ ๓) จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ๔) นำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) สู่การปฏิบัติจริง ๕) หลังจากปฏิบัติตามแผนแล้วประเมินภาวะสุขภาพตนเองหรือประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ ๖) ปรับปรุง/พัฒนาแผนและนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ๗) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อแก่เพื่อนสมาชิกชมรม/กลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุในชุมชน ๘) เสริมเส้นกระบวนการและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อการมีสุขภาพดี ๕. คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลทุกระดับ ตามรูปแบบที่กรมการแพทย์กำหนด (ทั้งในระดับเกณฑ์พื้นฐานและระดับคุณภาพ) การดูแลรักษา หมายถึง มีระบบการดูแลรักษา ตั้งแต่การตรวจยืนยัน วินิจฉัยสาเหตุการตรวจรักษา และการดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตกหกล้ม ๖. กลุ่มอาการความเสื่อมผู้สูงอายุ Geriatric Syndromes ของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ๑) ด้านความคิดความจำ ๒) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ๓) ด้านการขาดสารอาหาร ๔) ด้านการมองเห็น ๕) ด้านภาวะซึมเศร้า ๖) ด้านการกลืนปัสสาวะ ๗) ด้านการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน(ADL) ๘) ด้านภาวะสุขภาพช่องปาก ๗. คลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ หมายถึง มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพมาตรฐานกรมการแพทย์ ประกอบด้วยเกณฑ์ดังนี้ ๑) มีคลินิกผู้สูงอายุ

	๒) มีสถานที่ชัดเจน เป็นสัดส่วน ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ๓) ความเหมาะสมของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม (๓.๑) มีป้ายบ่งชี้คลินิกผู้สูงอายุ/หน่วยบริการอย่างชัดเจน (๓.๒) มีประตูและพื้นที่ห้องตรวจกว้างเพียงพอที่จะให้ผู้ที่นั่งรถเข็น เข้ารับบริการได้ (๓.๓) มีราวจับทางเดินอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลจนถึงคลินิกผู้สูงอายุ (๓.๔) มีทางลาดที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ด้านหน้าโรงพยาบาลจนถึงคลินิก ผู้สูงอายุ (๓.๕) มีห้องน้ำผู้สูงอายุ/ผู้พิการบริเวณใกล้ๆคลินิกผู้สูงอายุ ๔) มีพยาบาลปฏิบัติงานประจำที่คลินิกผู้สูงอายุ ๕) มีแพทย์ปฏิบัติงานที่คลินิกผู้สูงอายุ ๖) มีบุคลากรสหสาขาวิชาชีพร่วมเป็นทีมปฏิบัติงานคลินิกผู้สูงอายุ (แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข ฯลฯ) ๗) บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกผู้สูงอายุได้รับการอบรมด้านเวช ศาสตร์ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง) การจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ ๘) ความถี่ของการเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ๙) คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน ADL, IADL ๑๐) คลินิกผู้สูงอายุมีการประเมิน GS ในผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหามาจาก ประวัติ/ตรวจ ๑๑) การรับส่งต่อภายในโรงพยาบาล ๑๒) มีการดูแลต่อเนื่อง ๑๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑๔) มีนวัตกรรมในการจัดการปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ ๑๕) มีการจัดการองค์ความรู้ (KM) ๑๖) มีการวางแผนการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุในอนาคต ๑๗) มีข้อมูลการได้รับวัคซีนของผู้สูงอายุ				
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	NA	๙๕	๙๕.๕	๙๖	๙๖.๕
วัตถุประสงค์	๑) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ หรือคงสมรรถภาพทางร่างกาย สมอง สุขภาพจิต และสังคมของผู้สูงอายุป้องกันหรือลดการเกิดภาวะพึ่งพิงในผู้สูงอายุ ๒) เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) ๓) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษากลุ่มอาการ Geriatric Syndromes และปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างเหมาะสมหลังจากได้รับการคัดกรองสุขภาพในการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการคลินิกผู้สูงอายุ				
กลุ่มเป้าหมาย	๑) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ ๑ (กลุ่มติดสังคม) จากการประเมิน ADL คะแนนตั้งแต่ ๑๒ คะแนนขึ้นไป				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑) บันทึกการคัดกรองกลุ่มอาการความเสี่ยงในฐานข้อมูล HDC ๒) รายงานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ http://geriatricclinic.dms.go.th/ ๓) รายงานผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) https://care.anamai.moph.go.th/ ๔) รายงานผู้สูงอายุที่คัดกรองพบว่าเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตกหกล้มได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ รายไตรมาส http://geriatricclinic.dms.go.th/				

แหล่งข้อมูล	๑) ฐานข้อมูลการคัดกรองกลุ่มอาการความเสี่ยง Health Data Center ๒) รายงานการประเมินมาตรฐานการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุ ๓) รายงานผู้สูงอายุที่คัดกรองพบว่าเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะพลัดตกหกล้ม ได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ													
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง(กลุ่มติดสังคม) ADL ๑๒ คะแนนขึ้นไป B = จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองกลุ่มอาการความเสี่ยงในผู้สูงอายุทั้งหมด													
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ๑	$\frac{A \times 100}{B}$													
ระยะเวลาประเมินผล	ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗													
Small Success ปี ๒๕๖๗														
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน											
- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ภาวะถดถอย ๙ ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผน ส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่ง ต่อเข้าดูแลรักษาในคลินิก ผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง >ร้อยละ ๘๐	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ภาวะถดถอย ๙ ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผน ส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่ง ต่อเข้าดูแลรักษาในคลินิก ผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง >ร้อยละ ๘๕	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ภาวะถดถอย ๙ ด้าน กลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริม สุขภาพดี และดูแลส่งต่อเข้า ดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง >ร้อยละ ๙๐	- ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองภาวะ ถดถอย ๙ ด้าน กลุ่มเสี่ยงได้รับการ ดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี และดูแลส่งต่อเข้าดูแลรักษาใน คลินิกผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง >ร้อยละ ๙๕											
วิธีการประเมิน	๑) อสม.ประเมินสุขภาพและคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุ ๙ ด้าน ๒) ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะถดถอยได้รับการส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ๓) ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงภาวะถดถอยได้รับการส่งต่อดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ ๔) โรงพยาบาลทุกระดับจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์คุณภาพ													
ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี ๒๕๖๔</th><th>ปี ๒๕๖๕</th><th colspan="2">ปี ๒๕๖๖</th></tr><tr><td>ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง</td><td>NA</td><td>NA</td><td colspan="2">๙๔.๖</td></tr></table>				ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง	NA	NA	๙๔.๖	
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖											
ร้อยละของผู้สูงอายุไม่มีภาวะพึ่งพิง	NA	NA	๙๔.๖											
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางอังคณา อึ้งปีติมานะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๔๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ. ๐๖๑๗๙๒๙๔๒๕ E-mail :ungpitimana.ang@gmail.com													

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน														
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน														
ตัวชี้วัด กระทรวง	ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก														
ชื่อตัวชี้วัด	๑๑.ร้อยละสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test														
คำนิยาม	การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หมายถึง สตรีกลุ่มเป้าหมาย (อายุ๓๐-๔๖๐ ปี) ได้รับการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ทั้งแบบตรวจโดยเจ้าหน้าที่ และแบบ Self Collection เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ความ เสี่ยงสูง ๑๔ สายพันธุ์ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก โดยวิธีการตรวจคือเก็บเซลล์บริเวณปากมดลูกช่องคลอดด้านใน ส่งตรวจด้วยวิธีการตรวจด้วยน้ำยา เมื่อคัดกรองแล้วมีผลปกติ/ผล ลบ (Negative) จากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ แนะนำให้เข้า ร ับ ก า ร ต ร ว จ คั ด ก ร อ ง ม เ ร ื ง ป า ก ม ด ลู ก ดั ว ย วิ ธี HPV DNA Test ครั้งต่อไปในอีก ๕ ปี														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ ๘๐</td><td>ร้อยละ ๘๐</td><td>ร้อยละ ๘๐</td><td>ร้อยละ ๘๐</td><td>ร้อยละ ๘๐</td></tr></table>					ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐											
ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐											
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะลูกกลม														
กลุ่มเป้าหมาย	สตรีไทยอายุ ๓๐-๖๐ ปี ในพื้นที่รับผิดชอบ (การนับอายุ ๕๙ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ณ วันที่ให้บริการ) (ประชากร Type area ๑,Type area ๓) ในช่วงเวลาที่กำหนด														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.การบันทึกข้อมูล ๑.๑ บันทึกการคัดกรองผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ คือ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test รหัส ๑B๐๐๔๖ ๑.๒ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test จากโปรแกรม HPVcx๙๒๐๒๐ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒.ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง ๓.พื้นที่รับผิดชอบ : Type area ๑ = มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่ Type area ๓ = ไม่มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่มากกว่า ๖ เดือน														
แหล่งข้อมูล	HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น														
รายการข้อมูล	A = จำนวนสตรีไทยอายุ ๓๐-๖๐ ปี กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test B = จำนวนสตรีไทยอายุ ๓๐-๖๐ ปี ตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๗														
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐														

ระยะเวลาประเมินผล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - รอบการนิเทศที่กำหนด				
Small Success ปี ๒๕๖๗					
รอบ ๓ เดือน		รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	
ร้อยละ ๔๐		ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๘๐	≥ ร้อยละ ๘๐	
วิธีการประเมิน					
	๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน
	<๔๐.๐๐ %	๔๐.๐๐-๕๙.๙๙ %	๖๐.๐๐-๖๙.๙๙ %	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙ %	≥๘๐ %
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)					
	ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	
	จังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ ๓๑.๓๕	ร้อยละ ๒๑.๘๒	ร้อยละ ๒๖.๐๒	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางยุภาพร ดีแป้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๒๐๑๖๐ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗ E-mail : smallbody@hotmail.com				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน														
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน														
ตัวชี้วัดกระทรวง	ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง														
ชื่อตัวชี้วัด	๑๒.ประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test														
คำนิยาม	๑.ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรเพศชายและหญิง อายุ ๕๐-๗๐ ปี รายใหม่ (กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ไส้ตรงในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และไม่เคยได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy จากการคัดกรอง FIT Test มีผลเป็นบวก ในระยะ ๕ ปีที่ผ่านมา) ๒.วิธีนับอายุกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิง ที่เกิด ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗-วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๓.การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง หมายถึง การตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (Fecal Immunochemical Test : FIT test) โดยอาศัยปฏิกิริยาทาง อิมมูโนที่จำเพาะต่อฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่มีความจำเพาะของคนเท่านั้น โดยตรวจผ่านชุดตรวจที่มีค่า cut-off ๑๐๐ ng/ml ผู้รับการตรวจไม่จำเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>NA</td><td>ร้อยละ ๕๕</td><td>ร้อยละ ๖๐</td><td>ร้อยละ ๗๐</td><td>ร้อยละ ๘๐</td></tr></table>					ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	NA	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐											
NA	ร้อยละ ๕๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐											
วัตถุประสงค์	เพื่อ ค้น หา มะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรงในระยะเริ่มต้น และลดอัตราการตายในผู้ป่วยมะเร็ง ๕ อันดับแรก														
กลุ่มเป้าหมาย	๑.ประชากรเพศชายและหญิง อายุระหว่าง ๕๐-๗๐ ปี ทุกสิทธิการรักษา ๒.เป็นประชากร Type area ๑,Type area ๓ ในช่วงเวลาที่กำหนด ๓.จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๗														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.การบันทึกข้อมูล : ผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ ด้วยรหัส ๑B๐๐๖๐ (ผลลบ) หรือรหัส ๑B๐๐๖๑ (ผลบวก) และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ๒.ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้รับผิดชอบงานโรคมะเร็ง ๓.พื้นที่รับผิดชอบ : Type area ๑ = มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่ Type area ๓ = ไม่มีในทะเบียนบ้านและอยู่ในพื้นที่มากกว่า ๖ เดือน														
แหล่งข้อมูล	๑.สถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทุกระดับในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) ๒.HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น														
รายการข้อมูล	A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test รายใหม่ B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๗														

สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐											
ระยะเวลา ประเมินผล	เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-รอบการนิเทศที่กำหนด											
Small Success ปี ๒๕๖๗												
	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน								
	ร้อยละ ๑๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๕๕								
วิธีการประเมิน	ประเมินผลงาน รอบการนิเทศ											
รายละเอียด ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการ ดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	<table><tr><td>ผลงาน</td><td>ปี ๒๕๖๔</td><td>ปี ๒๕๖๕</td><td>ปี ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>จังหวัดขอนแก่น (ตัวชี้วัดใหม่)</td><td>NA</td><td>NA</td><td>NA</td></tr></table>				ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	จังหวัดขอนแก่น (ตัวชี้วัดใหม่)	NA	NA	NA
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖									
จังหวัดขอนแก่น (ตัวชี้วัดใหม่)	NA	NA	NA									
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นางยุภาพร ดีแป้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๒๐๑๖๐ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗ E-mail : smallbody@hotmail.com											

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน														
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน														
ตัวชี้วัดกระทรวง	ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy														
ชื่อตัวชี้วัด	๑๓. กลุ่มเป้าหมาย FIT Test ที่มีผล Positive ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy														
คำนิยาม	๑.ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุ ๕๐-๗๐ ปี ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) เป็นบวก (Positive) คือ ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในตัวอย่างอุจจาระ ๒.การส่องกล้อง Colonoscopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้องขยายเพื่อการค้นหาโรคร้ายก่อนการเกิดมะเร็งและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้น														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ ๕๐</td><td>ร้อยละ ๗๐</td><td>ร้อยละ ๘๐</td><td>ร้อยละ ๙๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td></tr></table>					ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐											
ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐											
วัตถุประสงค์	เพื่อค้นหาโรคร้ายก่อนการเกิดมะเร็งและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้น														
กลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี (รายใหม่) กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงด้วยวิธี FIT Test ที่มีผล Positive ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗														
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และรายงานผ่านระบบ Google Sheets โดย Node Colonoscopy จังหวัดขอนแก่น														
แหล่งข้อมูล	HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น														
รายการข้อมูล	A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test รายใหม่ ที่มีผล Positive ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยวิธี FIT test รายใหม่ ที่มีผล Positive ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy														
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐														
ระยะเวลาประเมินผล	เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-รอบการนิเทศที่กำหนด														
Small Success ปี ๒๕๖๗															
		รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน										
		ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๗๐										
วิธีการประเมิน		๑ คะแนน	๒ คะแนน	๓ คะแนน	๔ คะแนน	๕ คะแนน									
		< ๑๐%	๑๐.๐๐-๒๙.๙๙%	๓๐.๐๐-๔๙.๙๙%	๕๐.๐๐-๖๙.๙๙%	≥ ๗๐%									

ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี ๒๕๖๔</th><th>ปี ๒๕๖๕</th><th>ปี ๒๕๖๖</th></tr><tr><td>จังหวัดขอนแก่น</td><td>ร้อยละ ๔๕.๕๔</td><td>ร้อยละ ๔๖.๕๖</td><td>ร้อยละ ๕๗.๕๔</td></tr></table>	ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	จังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ ๔๕.๕๔	ร้อยละ ๔๖.๕๖	ร้อยละ ๕๗.๕๔
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖						
จังหวัดขอนแก่น	ร้อยละ ๔๕.๕๔	ร้อยละ ๔๖.๕๖	ร้อยละ ๕๗.๕๔						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางยุภาพร ดีแป้น ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๐ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐-๔๖๒๐๑๖๐ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗ E-mail : smallbody@hotmail.com								

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครอง ผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน					
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน					
ตัวชี้วัดกระทรวง	ความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่					
ชื่อตัวชี้วัด จังหวัด	๑๔. อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เผื่อระวางติดตามครบ ๒ ปี)					
คำนิยาม	๑.การประเมินการค้นหาวัณโรคใน ๗ กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการค้นหาวัณโรคใน ๗ กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ๒.กลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองวัณโรคด้วยวิธีการการคัดกรองด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ได้แก่ ๑) ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน ผู้สัมผัสใกล้ชิด ๒) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ หรือมี DM หรือมี COPD ๓) ผู้ใช้ยาเสพติด ติดสุราเรื้อรัง ๔) ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วยที่รับประทานยากดภูมิคุ้มกันตัวใดตัวหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เช่น steroid ที่มีขนาดเท่ากับ prednisolone ๒๐ mg/วัน เป็นเวลา ๑ เดือน, sulfasalazine, cyclosporin หรือ metotrexate เป็นต้น, ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน ที่มี HbA๑c $\geq$ ๗, ไตเรื้อรัง ตั้งแต่ stage ๔ ขึ้นไป ๕) ผู้ต้องขัง ๖) ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ๗) บุคลากรสาธารณสุข ๓.ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact) หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย ถิ่นนอนห้องเดียวกัน (household intimate) มีโอกาสรับ และติดเชื้อสูงกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกันแต่นอนแยกห้อง (household regular) ไม่นับรวมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่นอกบ้าน แต่ไปมาหาสู่เป็นครั้งคราว และนับระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยก็วันก็ได้ในช่วงระหว่าง ๓ เดือน ที่ผ่านมา					
เกณฑ์เป้าหมาย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
		-	ร้อยละ ๘๕	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐
วัตถุประสงค์	เพื่อให้คัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน และค้นหาผู้ป่วยวัณโรค เพื่อเข้าถึงกระบวนการรักษา ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราป่วย และอัตราการเสียชีวิตได้					
กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (household contact) คือ หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย วัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)					
วิธีการจัดเก็บ ข้อมูล	๑. ทะเบียนผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๒. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (โปรแกรม NTIP online)					

แหล่งข้อมูล	โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (NTIP online)			
รายการข้อมูล	รายงานจำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านทุกเดือน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เผื่อระวางติดตามครบ ๒ ปี) คำนวณจาก สูตรคำนวณ = (A/B) x ๑๐๐ A = จำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ในโปรแกรม NTIP B = จำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ในทะเบียนผู้สัมผัสร่วมบ้าน			
ระยะเวลาประเมินผล	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน			
Small Success ปี ๒๕๖๗				
		รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน
		ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐
				ร้อยละ ๘๕
วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย อัตราความ ครอบ คลุม ของ การ ค้นหา ผู้ป่วย วัณ โรค ใน กลุ่ม ผู้สัมผัส ร่วม บ้าน (เผื่อระวางติดตามครบ ๒ ปี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ แยกสาย CUP			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)				
	Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.	
			๒๕๖๔	๒๕๖๕
			๒๕๖๖	
	อัตราความครอบคลุมของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เผื่อระวางติดตามครบ ๒ ปี)	ร้อยละ	N/A	N/A
			๗๕.๒๖	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวีระวรรณ เหล่าวิทวัส ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ๑๒๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๖๒๒-๔๕๑๕E-mail : - นางสาวเอ็มวิกา แสงชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ๑๒๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๘๒๐๙-๖๙๓๘E-mail : s.emviga@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน				
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน				
ตัวชี้วัดกระทรวง	-				
ชื่อตัวชี้วัด	๑๕.๑ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง				
คำนิยาม	ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ในปีงบประมาณปัจจุบัน และไม่ได้มีการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยเบาหวานมาก่อน ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบันลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๕				
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	-๕.๙๘	๕	๕	๕	๕
วัตถุประสงค์	เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากปีงบประมาณที่ผ่านมา				
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ในปีงบประมาณปัจจุบัน				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud				
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข				
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ในปีงบประมาณปัจจุบัน B = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(B-A/B) x ๑๐๐				
ระยะเวลาประเมินผล	๑๒ เดือน				
Small Success ปี ๒๕๖๗					
รอบ ๓ เดือน		รอบ ๖ เดือน		รอบ ๙ เดือน	
≥ร้อยละ ๒		≥ร้อยละ ๓		≥ร้อยละ ๔	
				รอบ ๑๒ เดือน	
				≥ร้อยละ ๕	

วิธีการประเมิน	A : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ในปีงบประมาณปัจจุบัน ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย E๑๐-E๑๔ ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (๑ , ๓) ๑ (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง) , ๓ (มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCARGE = “๙” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = “๐๙๙” (สัญชาติไทย) B : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน (E๑๐-E๑๔) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย E๑๐-E๑๔											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี ๒๕๖๔</th><th>ปี ๒๕๖๕</th><th>ปี ๒๕๖๖</th></tr><tr><td>ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง</td><td>๓.๙๘</td><td>-๑๘.๒๕</td><td>-๕.๙๘</td></tr></table>				ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง	๓.๙๘	-๑๘.๒๕	-๕.๙๘
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖									
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง	๓.๙๘	-๑๘.๒๕	-๕.๙๘									
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)												
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ E-mail : sangdern.sopa@gmail.com											

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน				
เป้าประสงค์ที่ ๒	ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน				
ตัวชี้วัดกระทรวง	-				
ชื่อตัวชี้วัด	๑๕.๒ ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง				
คำนิยาม	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคความดันโลหิตสูง และระดับความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มม.ปรอท หมายเหตุ ต้องไม่เคยได้รับการวินิจฉัยจากที่ใดมาก่อน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบันลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา				
เกณฑ์เป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๒.๕				
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	๒.๕	๒.๕	๓	๔	๕
วัตถุประสงค์	เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากปีงบประมาณที่ผ่านมา				
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่อาศัยในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณปัจจุบัน				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud				
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข				
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (๑๐-๑๕) ในปีงบประมาณปัจจุบัน B = จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (๑๐-๑๕) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(B-A/B) x ๑๐๐				
ระยะเวลาประเมินผล	๑๒ เดือน				
วิธีการประเมิน	A : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (๑๐-๑๕) ในปีงบประมาณปัจจุบัน ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย E๑๐-E๑๔ ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (๑ , ๓) ๑ (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง) , ๓ (มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCARGE = “๙” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = “๐๙๙” (สัญชาติไทย)				

	B : จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง (1๑๐-1๑๕) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ประมวลผลจาก DIAGNOSIS_OPD , DIAGNOSIS_IPD , CHORNIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย E๑๐-E๑๔			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง	-๘.๗๓	-๔.๗๕	๒.๐๖
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ E-mail : sangdern.sopa@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๓	ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด	๑๖.จำนวนโรงพยาบาลที่ยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge
คำนิยาม	โรงพยาบาลที่ยกระดับพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน) ที่มีกิจกรรมการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ ดังนี้
C : CLEAN	ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ - ๑๓ ได้ตามเงื่อนไข (คะแนน ๘๐ % ขึ้นไป)
G : Garbage	๑.มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพและสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospital อย่างมีส่วนร่วมของคนในองค์กร
	๒.มีการจัดการมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	๓.มีการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูกสุขลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	๔.มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
R : Rest room	๕.มีการพัฒนาส้วมตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก(OPD) และอาคารผู้ป่วยใน (IPD)
E : Energy	๖.มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
	๗.มีการกำหนดนโยบายและมาตรการประหยัดพลังงานที่เป็นปัจจุบัน และเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานและมีการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร
E : Environment	๘.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกร่อนคลายสอดคล้องกับชีวิต และวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มารับบริการ
	๙.มีกิจกรรมส่งเสริม GREEN และกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กิจกรรมทางกาย กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ
N : Nutrition	๑๐.สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔ หมวด) และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
	๑๑.ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ (๔ หมวด)และมีการเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร

Innovation Network	๑๒.จัดให้มีน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน																								
	๑๓.โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ตามคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลปลอดภัย Food Safety Hospital)																								
	ระดับดีเยี่ยม (Excellent) หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการ ตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ - ๑๕ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด (คะแนน ๙๐ % ขึ้นไป)																								
	๑๔. มีการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายในโรงพยาบาลและชุมชน																								
	๑๕. สร้างเครือข่ายพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community																								
	ระดับท้าทาย (Challenge) หมายถึง โรงพยาบาลที่สามารถดำเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ - ๑๕ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และพัฒนาได้ตามประเด็นท้าทาย เลือกจำนวน ๑ ด้าน																								
	๑.การจัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขึ้น) ๒.การพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care) ๓.การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.การจัดการของเสียทางการแพทย์																								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td></td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>ระดับมาตรฐาน</td><td>๒๖</td><td>๒๖</td><td>๒๖</td><td>๒๖</td></tr><tr><td>ระดับดีเยี่ยม</td><td>๑๔</td><td>๑๖</td><td>๑๘</td><td>๒๐</td></tr><tr><td>ระดับท้าทาย</td><td>๕</td><td>๖</td><td>๗</td><td>๘</td></tr></table>						ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ระดับมาตรฐาน	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖	ระดับดีเยี่ยม	๑๔	๑๖	๑๘	๒๐	ระดับท้าทาย	๕	๖	๗	๘
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐																					
ระดับมาตรฐาน	๒๖	๒๖	๒๖	๒๖																					
ระดับดีเยี่ยม	๑๔	๑๖	๑๘	๒๐																					
ระดับท้าทาย	๕	๖	๗	๘																					
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Challenge																								
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น																								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	โรงพยาบาลทุกแห่งบันทึกข้อมูลในโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital																								
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมการประเมิน GREEN & CLEAN Hospital																								
รายการข้อมูล ๑	A = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นที่ดำเนินการ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ผ่านเกณฑ์ระดับมาตรฐานขึ้นไป																								
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด																								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X ๑๐๐																								
ระยะเวลาประเมินผล	นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รอบ																								

Small Success ปี ๒๕๖๗																					
รอบ ๓ เดือน		รอบ ๖ เดือน		รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน																
-		โรงพยาบาลมีการประเมินตนเองในโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital		-	โรงพยาบาลผ่านตามเกณฑ์ G&CHC																
วิธีการประเมิน	๑. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองบันทึกข้อมูลในโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมข้อมูลการประเมินส่งรายงานให้ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ผ่านโปรแกรม GREEN & CLEAN Hospital ๓. ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น สุ่มประเมิน และรวบรวมข้อมูลภาพเขตและรายงานผลผ่านระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย และ Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม																				
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	<table><tr><th>ผลงาน</th><th>ปี ๒๕๖๔</th><th>ปี ๒๕๖๕</th><th>ปี ๒๕๖๖</th></tr><tr><td>ระดับมาตรฐาน</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๒๔</td></tr><tr><td>ระดับดีเยี่ยม</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๑๒</td></tr><tr><td>ระดับท้าทาย</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๓</td></tr></table>					ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	ระดับมาตรฐาน	NA	NA	๒๔	ระดับดีเยี่ยม	NA	NA	๑๒	ระดับท้าทาย	NA	NA	๓
ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖																		
ระดับมาตรฐาน	NA	NA	๒๔																		
ระดับดีเยี่ยม	NA	NA	๑๒																		
ระดับท้าทาย	NA	NA	๓																		
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	๑. นายณัฐวุฒิ จันทะแสง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๖ โทรสาร ๐๔๓ ๒๒๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๖๔ ๙๘๓ ๙๕๖๒ e-mail: pro_tb@yahoo.com ๒. นางสาวนภัสวรรณ สนธิнок ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๖ โทรสาร ๐๔๓ ๒๒๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๑ ๘๖๗ ๓๐๗๕ e-mail: aom.napass@gmail.com																				

ยุทธศาสตร์ที่ ๑	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน				
เป้าประสงค์ที่ ๓	ประชาชนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ				
ข้อตัวชี้วัด	๑๗.ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการด้านสุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์				
คำนิยาม	ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ยา เครื่องสำอางค์ อาหาร วัตถุอันตราย สมุนไพร ตามนิยามพรบ.ที่เกี่ยวข้องที่มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ สถานประกอบการด้านสุขภาพ หมายถึง สถานที่ผลิตอาหาร และร้านขายยา (ประเภท ขย.๑-๓) ที่มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์สุขภาพรายการที่มีการเฝ้าระวังผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด สถานประกอบการมีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการเฝ้าระวังผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังนี้ -สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศเกณฑ์ GMP -ร้านขายยา(ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตามเกณฑ์ GPP				
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑. ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ > ๘๓% ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP (baseline) ๓.ร้านขายยา (ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP (baseline)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑. ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพผ่าน เกณฑ์ > ๘๕% ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP ≥๘๐% ๓.ร้านขายยา (ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP ≥๘๐%	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๑. ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพผ่าน เกณฑ์ > ๙๐% ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP ≥๘๕% ๓.ร้านขายยา (ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP ≥๘๕%	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๑. ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพผ่าน เกณฑ์ > ๙๕% ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP ≥๙๐% ๓.ร้านขายยา (ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP ≥๙๐%	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ๑. ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพผ่าน เกณฑ์ > ๙๘% ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP ≥๙๕% ๓.ร้านขายยา (ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP ≥๙๕%
วัตถุประสงค์	เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้วให้คงคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด				
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานประกอบการด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาตแล้ว และมีการตรวจเฝ้าระวังในปีงบประมาณนั้นๆ				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกรายงานการดำเนินงานตรวจเฝ้าระวังประจำปีไตรมาส กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น				

แหล่งข้อมูล	รายงานการดำเนินงานตรวจเฝ้าระวังประจำไตรมาส กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น								
รายการข้อมูล	A.ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ B.ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวัง C.สถานที่ผลิตอาหารที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ GMP D.สถานที่ผลิตอาหารทั้งหมดที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังตามเกณฑ์ GMP E.ร้านขายยา(ประเภท ขย.๑-๓) ที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังและมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ GPP F.ร้านขายยา(ประเภท ขย.๑-๓) ทั้งหมดที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังตามเกณฑ์ GPP								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 85\% = (A \times 100)/B$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศเกณฑ์ GMP $\geq 80\% = (A \times 100)/B$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตามเกณฑ์ GPP $\geq 80\% = (A \times 100)/B$								
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส								
Small Success ปี ๒๕๖๗									
	<table><tr><th>รอบ ๓ เดือน</th><th>รอบ ๖ เดือน</th><th>รอบ ๙ เดือน</th><th>รอบ ๑๒ เดือน</th></tr><tr><td>๑.กำหนดจำนวน กลุ่มเป้าหมาย</td><td>๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 50\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศ เกณฑ์ GMP $\geq 50\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขย. ๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP $\geq 50\%$</td><td>๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 60\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศ เกณฑ์ GMP $\geq 60\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขาย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GPP $\geq 60\%$</td><td>๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 85\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP $\geq 80\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขาย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GPP $\geq 80\%$</td></tr></table>	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	๑.กำหนดจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 50\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศ เกณฑ์ GMP $\geq 50\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขย. ๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP $\geq 50\%$	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 60\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศ เกณฑ์ GMP $\geq 60\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขาย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GPP $\geq 60\%$	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 85\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP $\geq 80\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขาย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GPP $\geq 80\%$
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน						
๑.กำหนดจำนวน กลุ่มเป้าหมาย	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 50\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศ เกณฑ์ GMP $\geq 50\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขย. ๑-๓) ผ่าน มาตรฐานตาม เกณฑ์ GPP $\geq 50\%$	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 60\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตามประกาศ เกณฑ์ GMP $\geq 60\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขาย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GPP $\geq 60\%$	๑.ผลิตภัณฑ์สุขภาพมี คุณภาพผ่านเกณฑ์ $\geq 85\%$ ๒.สถานที่ผลิตอาหาร ผ่าน มาตรฐานตาม ประกาศเกณฑ์ GMP $\geq 80\%$ ๓.ร้านขายยา(ประเภท ขาย.๑-๓) ผ่าน มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GPP $\geq 80\%$						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางศศิธร เอื้ออนันต์ ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ... โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๙๑๐๑๙๙ E-mail : sasitorneu@gmail.com								

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราการสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ชื่อตัวชี้วัดจังหวัด	๑๘.ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค
ค่านิยาม	๑.ความสำเร็จการรักษา หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ ๑.๑ รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่มี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อวัณโรคก่อนเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเชื้อวัณโรคอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา และในเดือนสุดท้ายของการรักษา ๑.๒ รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่รักษาครบกำหนดโดยไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซึ่งผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือนสุดท้ายของการรักษา ทั้งนี้ผลตรวจเสมหะเป็นลบอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา รวมทั้งผู้ป่วยที่ไม่ได้ตรวจหรือไม่ผลตรวจ ๒.ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคน้อยกว่า ๑ เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๒.๑ ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อวัณโรค (Bacteriologically confirmed: B+) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลตรวจเสมหะเป็นบวก อาจจะเป็นการตรวจด้วยวิธี Smear microscopy หรือ Culture หรือวิธี Molecular หรือวิธีการอื่นๆ ที่องค์การอนามัยโลกรับรอง ๒.๒ ผู้ป่วยที่วินิจฉัยด้วยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed: B-) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่มีผลตรวจเสมหะเป็นลบ หรือไม่มีผลตรวจ แต่ผลการวินิจฉัยด้วยวิธีการตรวจเอกซเรย์รังสีทรวงอกหรือผลการตรวจชิ้นเนื้อผิดปกติเข้าได้กับวัณโรค ร่วมกับมีลักษณะทางคลินิกเข้าได้กับวัณโรค และแพทย์ตัดสินใจรักษาด้วยสูตรยารักษาวัณโรค ๓.การประเมินการค้นหาวัณโรคใน ๗ กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการค้นหาวัณโรคใน ๗ กลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการคัดกรองด้วยวิธีการถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-Ray) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ๔.ความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ หมายถึง อัตราการตรวจพบและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เทียบกับค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (๑๔๓ ต่อประชากรแสนคน) เมื่อเทียบกับค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดขอนแก่นจะมีอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค จำนวน ๒,๕๖๑ ราย

	๕.ค่าคาดประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับเป็นซ้ำ) หมายถึง อุตบัติการณ์วัณโรค (๑๔๓ ต่อประชากรแสนคน) หรือจำนวน คาดประมาณผู้ป่วยวัณโรค (๑๐๓,๐๐๐ ราย) ในประเทศไทยจากข้อมูลรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO, Global Tuberculosis Report) ๖.การประเมิน ๖.๑ การประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน ๖.๒ การประเมินอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ที่ เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจำ ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน														
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ ๘๘</td><td>ร้อยละ ๘๘</td><td>ร้อยละ ๙๐</td><td>ร้อยละ ๙๕</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td></tr></table>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐				
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐											
ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๑๐๐											
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อให้ผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในด้านการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานและรักษาหาย รักษาครบ ๒.เพื่อพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุข														
กลุ่มเป้าหมาย	๑. กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ คือ ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๖) ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทยและผู้ป่วยในเรือนจำที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไม่รวมโรงพยาบาลเอกชน ๒. กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินอัตราความครอบคลุมการรักษา ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) คือ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ที่ เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทย และผู้ป่วยในเรือนจำที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน ๓. กลุ่มเป้าหมายสำหรับการประเมินการค้นหาวัณโรคใน ๗ กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ๓.๑ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด ๓.๒ ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง ๓.๓ ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป หรือที่สูบบุหรี่ หรือมี DM หรือมี COPD ๓.๔ ผู้ป่วยโรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ได้แก่ ผู้ป่วย CKD ตั้งแต่ stage ๔ ขึ้นไป,														

	ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ (HbA๑c ตั้งแต่ ๗ ขึ้นไป), ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิ (ยากดภูมิทุกชนิด steroid prednisolone ๒๐ mg/d, sulfasalazine cyclosporine mtx เป็นต้น) ๓.๕ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ๓.๖ ผู้ต้องขัง ๓.๗ บุคลากรทางการแพทย์
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (โปรแกรม NTIP online)
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลรายผู้ป่วยวัณโรคแห่งชาติ (NTIP online)
รายการข้อมูล	-
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อัตราการสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) คำนวณจากสูตรคำนวณ = $(A/B) \times 100$ A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ ๑ ของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยมีผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) โดยครบรอบรายงานผลการรักษาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ B = จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยการเปลี่ยนแปลงวินิจฉัยและพบว่าเป็น RR/MDR/XDR-TB ไม่ถูกนำมานับรวม อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) คำนวณจาก สูตรคำนวณ = $(A/B) \times 100$ A = จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ที่เป็นผู้ป่วยไทย ผู้ป่วยไม่ใช่ไทยและผู้ป่วยในเรือนจำที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน B = จำนวนคาดการณ์การผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) คิดจากอัตรา ๑๔๓ ต่อประชากรแสนคน หมายเหตุ ข้อมูลประชากรอ้างอิงจากฐานข้อมูล HDC

ระยะเวลาประเมินผล	ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือน			
Small Success ปี ๒๕๖๗				
	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate)	-	ร้อยละ ๔๔	ร้อยละ ๖๘	ร้อยละ ๘๘
อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage)	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๖๐	ร้อยละ ๗๕	ร้อยละ ๙๐
วิธีการประเมินผล	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมาย ๑.อัตราผลสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ (ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๗) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ แยกเป็นระดับ CUP ๒.อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ แยกเป็นระดับ CUP			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)				
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่**	ร้อยละ	๗๘.๔๒	๗๐.๘๓	๗๕.๒๖
หมายเหตุ ** อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน ในไตรมาสที่ ๑ ของแต่ละปีงบประมาณ *** ไม่คิดรวมอยู่ระหว่างการรักษา ร้อยละ ๖.๕๕				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวีระวรรณ เหล่าวิหวัธ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ๑๒๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘-๙๖๒๒-๔๕๑๕E-mail : - นางสาวเอมิกา แสงชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ หน่วยงาน สสจ.ขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ๑๒๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๙-๘๒๐๙-๖๙๓๘E-mail : s.emviga@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	๑๙.การจัดบริการมะเร็งครบวงจร ในมะเร็งสำคัญ ๕ โรคมะเร็ง (Cancer Warrior)
ชื่อตัวชี้วัด	ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นโรคมะเร็งไ้ไม่ดับลดลง
คำนิยาม	ประชากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ประชากรจังหวัดขอนแก่น (ตาม ๔๓ แฟ้ม Typearea = ๑,๓ และ Nation = ๐๙๙) ที่มีปัจจัยเสี่ยงในข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ๑. มีประวัติการกินปลาตระกูลมีเกล็ดน้ำจืดสุกๆดิบๆ ๒. เคยเป็นหรือมีประวัติการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ๓. มีญาติสายตรงป่วยมะเร็งท่อน้ำดีหรือพยาธิใบไม้ตับ ๔. เป็นคนอีสานโดยกำเนิดหรืออาศัยอยู่ในอีสานมากกว่า ๑๕ ปี การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งไ้ไม่ดับ หมายถึง การตรวจหาพยาธิใบไม้ตับ (OV; Opisthorchis viverrini) ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ด้วยวิธีตรวจอุจจาระ และ/หรือ ปัสสาวะ โดย วิธีตรวจอุจจาระ ได้แก่ Formalin ether concentration technique (FECT) หรือ Modified Kato thick smear หรือ Modified Kato-Katz หรือ JIK-PARASITE TRAP วิธีตรวจปัสสาวะ (OV-RDT; OV-Rapid diagnostic test) คือ การใช้ตัวตรวจจับจำเพาะ หรือโมโนโคลนอลแอนติบอดี (monoclonal antibody) ที่มีความจำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ และเป็นสารตรวจจับสิ่งคัดหลั่งหรือแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับในปัสสาวะ การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ หมายถึง การตรวจมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับจากการตรวจหาการติดเชื้อจากปัสสาวะ (OV-RDT) และอุจจาระ ในกลุ่มประชากรที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป โดยจังหวัดขอนแก่นมุ่งเน้นในกลุ่มที่มีอายุระหว่าง ๕๐-๗๐ ปี แนวทางดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน รักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ตาม ๘ มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ ๑ คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชากรกลุ่มเป้าหมาย เมื่อพบผู้ติดเชื้อพยาธิให้รักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มาตรการที่ ๒ คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ มาตรการที่ ๓ จัดระบบสุขภาพีบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลในทุกพื้นที่ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการที่ ๔ สนับสนุนให้มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคมะเร็งไ้ไม่ดับและมะเร็งท่อน้ำดี ในเด็กนักเรียน เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ประกอบการ และประชาชน มาตรการที่ ๕ รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารตามบริบทพื้นที่ มาตรการที่ ๖ บริหารจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยรักษาอย่างเป็นระบบและมีระบบการ รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนมีหมอครอบครัวเข้าไป

	ดูแลระดับประจักษ์ด้วยการแพทย์ผสมผสานทั้ง แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก มาตรการที่ ๗ รายงานข้อมูล ตามระบบงานเฝ้าระวัง ได้แก่ ฐานข้อมูลจังหวัด อำเภอ , HDC , Isan cohort, รง. ๕๐๖ มาตรการที่ ๘ พัฒนานวัตกรรม และพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ และการรักษามะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี					
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	
	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพการคัดกรองวินิจฉัย การส่งต่อดูแลรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งระบบอย่างบูรณาการ ๓.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างมีระบบ					
กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐ ของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ฐานข้อมูลจังหวัด อำเภอ , HDC , Isan cohort , รง. ๕๐๖					
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลรายงานของหน่วยบริการ					

รายการข้อมูล					
ข้อมูลจำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายอำเภอ					
ลำดับ ที่	อำเภอ	เป้าหมายดำเนินการดำเนินการ ปี ๒๕๖๗			
		ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ			ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน ๒,๐๐๐ ราย
		Quick Win OV-RDT (๔,๐๐๐ราย)	พื้นที่ดำเนินการ (๒๙,๙๐๖ราย)	รวม (๓๓,๙๐๖ ราย)	
๑	เมืองขอนแก่น	๕๐๐	๗,๖๓๐	๘,๑๓๐	๑๐๐
๒	บ้านฝาง	๔๐	๑,๐๔๒	๑,๐๘๒	๕๐
๓	พระยืน	๔๐	๖๙๗	๗๓๗	๕๐
๔	หนองเรือ	๒๐๐	๑,๑๒๕	๑,๓๒๕	๑๐๐
๕	ชุมแพ	๖๐๐	๑,๙๓๘	๒,๕๓๘	๕๐
๖	สีชมพู	๔๐๐	๗๐๖	๑,๑๐๖	๕๐
๗	น้ำพอง	๓๐๐	๒,๐๖๑	๒,๓๖๑	๑๐๐
๘	อุบลรัตน์	๒๐๐	๔๐๘	๖๐๘	๕๐
๙	กระนวน	๕๐	๑,๕๖๖	๑,๖๑๖	๕๐
๑๐	บ้านไผ่	๔๐	๒,๑๘๘	๒,๒๒๘	๑๐๐
๑๑	เปือยน้อย	๔๐	๓๓๐	๓๗๐	๕๐
๑๒	พล	๔๐	๑,๖๙๗	๑,๗๓๗	๕๐
๑๓	แวงใหญ่	๑๐๐	๔๒๓	๕๒๓	๕๐
๑๔	แวงน้อย	๔๐	๘๓๔	๘๗๔	๑๐๐
๑๕	หนองสองห้อง	๕๐	๑,๓๑๑	๑,๓๖๑	๑๐๐
๑๖	ภูเวียง	๔๐๐	๘๒๗	๑,๒๒๗	๕๐
๑๗	มัญจาคีรี	๓๐๐	๘๙๙	๑,๑๙๙	๒๐๐
๑๘	ชนบท	๒๐๐	๕๕๒	๗๕๒	๕๐
๑๙	เขาสวนกวาง	๕๐	๕๙๖	๖๔๖	๑๐๐
๒๐	ภูผาม่าน	๔๐	๔๔๘	๔๘๘	๕๐
๒๑	ซำสูง	๔๐	๔๔๗	๔๘๗	๕๐
๒๒	โคกโพธิ์ไชย	๕๐	๔๖๖	๕๑๖	๒๐๐
๒๓	หนองนาคำ	๑๐๐	๔๑๓	๕๑๓	๕๐
๒๔	บ้านแฮด	๔๐	๕๘๒	๖๒๒	๑๐๐
๒๕	โนนศิลา	๔๐	๓๗๑	๔๑๑	๕๐
๒๖	เวียงเก่า	๑๐๐	๓๔๙	๔๔๙	๕๐
รวม		๔,๐๐๐	๒๙,๙๐๖	๓๓,๙๐๖	๒,๐๐๐

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (A/B)×๑๐๐ A = ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ B = ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ (A/B)×๑๐๐ A = ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ B = ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด			
ระยะเวลาประเมินผล	รายไตรมาส ตามเอกสารแนบท้าย ๑			
Small Success ปี ๒๕๖๗				
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	
๑. จัดทำแผนงาน/โครงการ เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ ๒. คัดเลือกประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด	๑.ดำเนินงานตาม มาตรการหลัก ๒.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ตามเป้าหมายที่กำหนด ≥ ร้อยละ ๕๐	๑.ดำเนินงานตาม มาตรการหลัก ๒.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ตามเป้าหมายที่กำหนด ≥ ร้อยละ ๗๐	๑.ดำเนินงานตาม มาตรการหลัก ๒.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐ ๓.ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ ในประชากรที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ ตามเป้าหมายที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	
วิธีการประเมิน				
ประเมินการดำเนินงานจากการนิเทศงานระดับ CUP ตามรอบประเมินผล				
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	ผลงาน	ผลการดำเนินงาน		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
	ร้อยละความครอบคลุมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชากรกลุ่มเสี่ยง จากประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไปด้วยวิธีการตรวจอุจจาระ	๐.๔๔	๐.๕๒	๐.๕๖
	ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการอัลตราซาวด์	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	๑. นางอนุรักษ์ สะตะ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารจัดการภัยพิบัติ และนอนพยาธิ ๒. นางสาวลดาพรรณ ช่างศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๕๕๔๑ ๖๔๒๘ E-mail : kkcd.eoc@gmail.com			

คัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	อำเภอ	ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ(ด้วยอุจจาระ/ปัสสาวะ)				ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี(ด้วยอัลตราซาวด์)			
		เป้าหมาย ๓๓,๙๐๖ ราย				เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย			
		ไตรมาส ๑ (Quick Win) ๔,๐๐๐ ราย	ไตรมาส ๒ ๕๐%	ไตรมาส ๓ ๘๐%	ไตรมาส ๔(๑๕ส.ค. ๖๖) ๑๐๐%	ไตรมาส ๑ ๔๐%	ไตรมาส ๒ ๖๐%	ไตรมาส ๓ ๘๐%	ไตรมาส ๔(๑๕ส.ค. ๖๖) ๑๐๐%
๑	เมือง ขอนแก่น	๕๐๐	๔,๐๖๕	๖,๕๐๔	๘,๑๓๐	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๒	บ้านฝาง	๔๐	๕๔๑	๘๖๖	๑,๐๘๒	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๓	พระยืน	๔๐	๓๖๙	๕๙๐	๗๓๗	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๔	หนองเรือ	๒๐๐	๖๖๓	๑,๐๖๐	๑,๓๒๕	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๕	ชุมแพ	๖๐๐	๑,๒๖๙	๒,๐๓๐	๒,๕๓๘	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๖	สีชมพู	๔๐๐	๕๕๓	๘๘๕	๑,๑๐๖	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๗	น้ำพอง	๓๐๐	๑,๑๘๑	๑,๘๘๙	๒,๓๖๑	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๘	อุบลรัตน์	๒๐๐	๓๐๔	๔๘๖	๖๐๘	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๙	กระนวน	๕๐	๘๐๘	๑,๒๙๓	๑,๖๑๖	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๐	บ้านไผ่	๔๐	๑,๑๑๔	๑,๗๘๒	๒,๒๒๘	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๑๑	เปือยน้อย	๔๐	๑๘๕	๒๙๖	๓๗๐	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๒	พล	๔๐	๘๖๙	๑,๓๙๐	๑,๗๓๗	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๓	วางใหญ่	๑๐๐	๒๖๒	๔๑๘	๕๒๓	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๔	วางน้อย	๔๐	๔๓๗	๖๙๙	๘๗๔	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๑๕	หนองสอง ห้อง	๕๐	๖๘๑	๑,๐๘๙	๑,๓๖๑	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๑๖	ภูเวียง	๔๐๐	๖๑๔	๙๘๒	๑,๒๒๗	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐

ลำดับ ที่	อำเภอ	ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ(ด้วยอุจจาระ/ปัสสาวะ) เป้าหมาย ๓๓,๙๐๖ ราย				ตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี(ด้วยอัลตราซาวด์) เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ราย			
		ไตรมาส๑ (Quick Win) ๔,๐๐๐ ราย	ไตรมาส๒ ๕๐%	ไตรมาส๓ ๘๐%	ไตรมาส๔(๑๕ส.ค. ๖๖) ๑๐๐%	ไตรมาส๑ ๔๐%	ไตรมาส๒ ๖๐%	ไตรมาส๓ ๘๐%	ไตรมาส๔(๑๕ส.ค. ๖๖) ๑๐๐%
๑๗	มัญจาคีรี	๓๐๐	๖๐๐	๙๕๙	๑,๑๙๙	๘๐	๑๒๐	๑๖๐	๒๐๐
๑๘	ชนบท	๒๐๐	๓๗๖	๖๐๒	๗๕๒	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๑๙	เขาสวนกวาง	๕๐	๓๒๓	๕๑๗	๖๔๖	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๒๐	ภูผาม่าน	๔๐	๒๔๔	๓๙๐	๔๘๘	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๒๑	ซำสูง	๔๐	๒๔๔	๓๙๐	๔๘๗	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๒๒	โคกโพธิ์ไชย	๕๐	๒๕๘	๔๑๓	๕๑๖	๘๐	๑๒๐	๑๖๐	๒๐๐
๒๓	หนองนาคำ	๑๐๐	๒๕๗	๔๑๐	๕๑๓	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๒๔	บ้านแฮด	๔๐	๓๑๑	๔๙๘	๖๒๒	๔๐	๖๐	๘๐	๑๐๐
๒๕	โนนศิลา	๔๐	๒๐๖	๓๒๙	๔๑๑	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
๒๖	เวียงเก่า	๑๐๐	๒๒๕	๓๕๙	๔๔๙	๒๐	๓๐	๔๐	๕๐
รวม		๔,๐๐๐	๑๖,๙๕๓	๒๗,๑๒๕	๓๓,๙๐๖	๘๐๐	๑,๒๐๐	๑,๖๐๐	๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	๒๐. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ๒๐.๑ อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ๒๐.๒ ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำในระยะเวลา ๑ ปี
ชื่อตัวชี้วัด	๒๐.อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
คำนิยาม	การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การเสียชีวิตจากพฤติกรรมที่มุ่งทำร้ายตนเองโดยตั้งใจจะให้ตายจากพฤติกรรมนั้น ผู้พยายามฆ่าตัวตาย หมายถึง ผู้ที่มีพฤติกรรมมุ่งทำร้ายตนเองแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตโดยตั้งใจจะให้ตายจากพฤติกรรมนั้นและผลของการพยายามฆ่าตัวตายอาจบาดเจ็บหรือไม่บาดเจ็บ ซึ่งวิธีการที่ใช้มีลักษณะสอดคล้องตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ ๑๐ (ICD - ๑๐ : International Classification of Diseases and Health Related Problems - ๑๐) หมวด Intentional self-harm (X๖๐-X๘๔) หรือเทียบเคียงในกลุ่มโรคเดียวกันกับการวินิจฉัยตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ ๕ (DSM-๕: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders ๕) ผู้พยายามฆ่าตัวตายซ้ำ หมายถึง ผู้พยายามฆ่าตัวตายที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายมากกว่า ๑ ครั้งในรอบปีงบประมาณ ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา ๑ ปี หมายถึง ผู้ที่เคยพยายามฆ่าตัวตายในช่วงปีงบประมาณได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมและติดตามเฝ้าระวังจนไม่เกิดพฤติกรรมทำร้ายตนเองอีกครั้งในรอบปีงบประมาณเดียวกัน (ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเหมาะสมจะประกอบด้วย ๗ กิจกรรม ดังต่อไปนี้ ๑) ได้รับการช่วยชีวิตและยับยั้งพฤติกรรมฆ่าตัวตายจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯ/๑๖๖๙/ตำรวจ/ อื่นๆ รวมทั้งส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขได้ทันทั่วถึง ๒) ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคหมวด Intentional self-harm (X๖๐-X๘๔) ๓) ได้รับการสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายและกระทำรุนแรงต่อตนเองเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยปกป้อง และดำเนิน รวมทั้งประเมินการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในครอบครัวและชุมชนโดยทีมสอบสวนโรครณีฆ่าตัวตายของจังหวัด/อำเภอ หรือ และ ร่วมกับ ทีมจังหวัด ทีมจิตเวชพี่เลี้ยง ในกรณีมีความยุ่งยากซับซ้อน มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน สังคม ๔) ได้รับการช่วยเหลือจัดหรือบรรเทาปัจจัยกระตุ้น ปัจจัยเสี่ยง จากบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยบริการทั้งในระดับ รพ.สต. /รพช. /รพท/รพศ. /หน่วยบริการในสังกัด กรมสุขภาพจิต

	๕) ได้รับการสร้างเสริมปัจจัยปกป้อง และต้านกั้นการเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์หรือสารพิษที่ใช้ฆ่าตัวตาย จาก แกนนำชุมชน/อปท และบุคลากรสาธารณสุข จากหน่วยบริการทั้งในระดับ รพ.สต. /รพช. /รพท./รพศ. ๖) ญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดได้รับการพัฒนาทักษะสังเกตสัญญาณเตือนและมีช่องทางติดต่อที่สะดวกกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในพื้นที่ ๗) ได้รับการเฝ้าระวังติดตามประเมินความคิดและการกระทำฆ่าตัวตายอย่างสม่ำเสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ปีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ จาก อสม./บุคลากรสาธารณสุข จากหน่วยบริการทั้งในระดับ รพ.สต./รพช. /รพท./รพศ. /หน่วยบริการในสังกัด กรมสุขภาพจิต ครอบคลุมร้อยละ ๙๐																
เกณฑ์เป้าหมาย	๒๐.๑ อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ <table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>≤๗.๘ ต่อประชากร แสนคน</td><td>≤๗.๘ ต่อประชากร แสนคน</td><td>≤๗.๕ต่อประชากร แสนคน</td><td>≤๗.๕ ต่อประชากร แสนคน</td></tr></table> ๒๐.๒ ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำ ในระยะเวลา ๑ ปี <table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ ๙๒</td><td>ร้อยละ ๙๔</td><td>ร้อยละ ๙๖</td><td>ร้อยละ ๙๘</td></tr></table>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	≤๗.๘ ต่อประชากร แสนคน	≤๗.๘ ต่อประชากร แสนคน	≤๗.๕ต่อประชากร แสนคน	≤๗.๕ ต่อประชากร แสนคน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๙๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐														
≤๗.๘ ต่อประชากร แสนคน	≤๗.๘ ต่อประชากร แสนคน	≤๗.๕ต่อประชากร แสนคน	≤๗.๕ ต่อประชากร แสนคน														
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐														
ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๖	ร้อยละ ๙๘														
วัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก ๑.เพื่อใช้แสดงและติดตามภาวะสุขภาพอนามัยที่สำคัญด้านสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายย่อย ๑.เพื่อใช้วัดผลลัพธ์ของการดูแลช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการฆ่าตัวตายหรือผู้พยายามฆ่าตัวตายและการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำที่ดำเนินการภายใต้ระบบสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น																
กลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายหลัก : ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายย่อย : ผู้พยายามฆ่าตัวตายที่กระทำในช่วงเวลา ๑ ปีงบประมาณ																
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๒๐.๑ : จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายสำเร็จ รวบรวมจาก รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง ๕๐๖S version ๑๑. ๒๐.๒ : จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตาย และฆ่าตัวตายซ้ำ รวบรวมจาก รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง ๕๐๖S version ๑๑. **หมายเหตุ : เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วของการรายงานข้อมูล																
แหล่งข้อมูล	รายงานการเฝ้าระวังการพยายามฆ่าตัวตาย รง ๕๐๖ S version ๑๑. ในโปรแกรม online://๕๐๖s.dmh.go.th กรมสุขภาพจิต																

รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗																					
	B = จำนวนประชากรกลางปี ๒๕๖๗																					
	**หมายเหตุ สำหรับไตรมาส ๒ ใช้ประชากรปลายปี ๒๕๖๖ สำหรับไตรมาส ๓ และ ๔ ใช้ประชากรกลางปี ๒๕๖๗																					
	C = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำ = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมดในปีงบประมาณ - จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายมากกว่า ๑ ครั้งในปีงบประมาณ หน่วยนับ (คน)																					
	D = จำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗																					
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๐.๑ : (A/B) x ๑๐๐,๐๐๐ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๐.๒ : (C/D) x ๑๐๐																					
ระยะเวลาประเมินผล	ตัวชี้วัดหลักที่ ๒๐.๑ : ไตรมาส ๔ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒๐.๒ : ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔																					
Small Success ปี ๒๕๖๗																						
<table><tr><td>รอบ ๓ เดือน</td><td>รอบ ๖ เดือน</td><td>รอบ ๙ เดือน</td><td>รอบ ๑๒ เดือน</td></tr><tr><td>-</td><td>≤ ๕.๐ ต่อประชากรแสนคน</td><td>-</td><td>≤ ๗.๘ ต่อประชากรแสนคน</td></tr><tr><td>-</td><td>ร้อยละ ๕๐</td><td>ร้อยละ ๗๐</td><td>ร้อยละ ๙๒</td></tr></table>					รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	-	≤ ๕.๐ ต่อประชากรแสนคน	-	≤ ๗.๘ ต่อประชากรแสนคน	-	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๒						
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน																			
-	≤ ๕.๐ ต่อประชากรแสนคน	-	≤ ๗.๘ ต่อประชากรแสนคน																			
-	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๙๒																			
วิธีการประเมิน	นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบของอัตราต่อประชากรแสนคน																					
เอกสารสนับสนุน	รายงานการเฝ้าระวังผู้พยายามทำร้ายตนเอง (รจ ๕๐๖ S version ๑๑)																					
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	<table><tr><th rowspan="2">Baseline data</th><th rowspan="2">หน่วยวัด</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr><tr><th>๒๕๖๔</th><th>๒๕๖๕</th><th>๒๕๖๖</th></tr><tr><td>การฆ่าตัวตายสำเร็จ</td><td>อัตราต่อประชากรแสนคน</td><td>๖.๔๓</td><td>๕.๙๗</td><td>๕.๗๙</td></tr><tr><td>ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา ๑ ปี</td><td>ร้อยละ</td><td>๙๗.๗๐</td><td>๙๖.๘๙</td><td>๙๐.๓๔</td></tr></table> ที่มา http://๕๐๖s.dmh.go.th				Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	การฆ่าตัวตายสำเร็จ	อัตราต่อประชากรแสนคน	๖.๔๓	๕.๙๗	๕.๗๙	ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา ๑ ปี	ร้อยละ	๙๗.๗๐	๙๖.๘๙	๙๐.๓๔
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.																				
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖																		
การฆ่าตัวตายสำเร็จ	อัตราต่อประชากรแสนคน	๖.๔๓	๕.๙๗	๕.๗๙																		
ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา ๑ ปี	ร้อยละ	๙๗.๗๐	๙๖.๘๙	๙๐.๓๔																		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	๑) นางกิตติมา ก้านจักร หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๗-๗๗๐๗๗๖๑ E-mail : Kittima_๑๒๓๔@hotmail.com ๒) นางรุ่งฤดี ไชยทองศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๖-๘๖๑๖๔๙๗ E-mail : mintrachaimaha@gmail.com กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๗๐ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗																					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ ๒๖
ชื่อตัวชี้วัด	๒๑.อัตราการตายผู้ป่วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) แบบรุนแรงชนิด Community - acquired sepsis น้อยกว่าร้อยละ ๒๖
คำนิยาม	ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญ พบว่า อัตราอุบัติการณ์ มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา ได้แก่ ภาวะช็อก, ไตวาย, การทำงานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด ๑. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe sepsis หรือ septic shock ๑.๑ ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ ๒ ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ ๑) ที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ ๒) โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ ข้อใดข้อหนึ่งใน ๔.๒ - ๔.๔ ๑.๒ ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ ๒ ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ ๑) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥ 65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level > 2 mmol/L (๑๘ mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม ๒. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยอัตราการตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด จาก community-acquired sepsis เพียงอย่างเดียว ๓. กลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ ๔. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) คือ Modified Early Warning Score (MEWS) (ตารางที่ ๕) ๕. การดูแลรักษาผู้ป่วย ในที่นี้ ครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการแต่ละคน ระบบและกระบวนการที่เกี่ยวข้องครอบคลุมทั้งการที่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยหรือการรักษาได้หรือการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามอย่างที่เราควรจะเป็น

เกณฑ์เป้าหมาย	ผ่านเกณฑ์ระดับ ๕ จำนวน ๒๔ โรงพยาบาล
วัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis ให้น้อยกว่าร้อยละ ๒๖
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.รายงานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือด ตามแนวทางการเก็บข้อมูลจาก ICD-๑๐ ในฐานข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ๒.บันทึกข้อมูลการดูแลรักษาและส่งต่อ Realtime ตาม Checklist Khon Kaen Sepsis Protocol
แหล่งข้อมูล/ข้อมูลสนับสนุน :	๑.แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดจังหวัดขอนแก่น KK Sepsis Protocol ๒.แนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
รายการข้อมูล ๑	A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD ๑๐ รหัส R ๖๕.๑ และ R๕๗.๒ ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z ๕๑.๕)
รายการข้อมูล ๒	B = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD ๑๐ รหัส R ๖๕.๑ และ R๕๗.๒ ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z ๕๑.๕) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย (Discharge status) = ๒ ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = ๒ ดีขึ้น
รายการข้อมูล ๓	C = จำนวนผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษาเพื่อกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน (against advise) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่ลง ICD ๑๐ รหัส R ๖๕.๑ และ R๕๗.๒ ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z ๕๑.๕) โดยมีสถานภาพการจำหน่าย(Discharge status) = ๒ ปฏิเสธการรักษา, และวิธีการจำหน่าย (Discharge type) = ๓ ไม่ดีขึ้น
รายการข้อมูล ๔	D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมด ที่ลง ICD ๑๐ รหัส R ๖๕.๑ และ R๕๗.๒ ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน Post Admission Comorbidity (complication) และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z ๕๑.๕)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อัตราการตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired sepsis(A+C) / D × ๑๐๐
ระยะเวลาประเมิน	รายงาน Cockpit ทุก ๓ เดือน และนิเทศงานจังหวัด ๒ ครั้ง/ปี (ไตรมาส ๑ และ ไตรมาส ๓)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม			
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ			
ตัวชี้วัดกระทรวง	อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รายใหม่)			
ชื่อตัวชี้วัด	๒๒.อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (รายใหม่)			
คำนิยาม	ผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยในที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal diagnosis: pdx) จากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง รหัส IDC ๑๐ (I๖๐-I๖๙) ในปีงบประมาณทุกกลุ่มอายุ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยโรคหลักซ้ำภายในระยะเวลาเกินกว่า ๒๘ วันขึ้นไป ให้นับเป็นผู้ป่วยรายใหม่อีกครั้ง			
เกณฑ์เป้าหมาย	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมอง (อัตราต่อประชากรแสนคน)			
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	๒๓๗	๒๓๒	๒๒๗	๒๒๒
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่			
กลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ ทุกกลุ่มอายุ ในจังหวัดขอนแก่น			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการและส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud			
แหล่งข้อมูล	HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยรายใหม่จากโรคหลอดเลือดสมองในปีงบประมาณ B = จำนวนประชากรทะเบียนราษฎร์			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100,000$			
ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ ๑ ครั้ง			
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)				
	ผลงาน	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
	จังหวัดขอนแก่น	NA	NA	๒๗๔.๐๖
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	HDC ณ ๓ พ.ย. ๖๖			
	นางประภัสสร แสนละมุน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข			
	กลุ่มงาน : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๐			
	โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๘๓๖๕๒๓๗			
	โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	E-mail : matoom.๒๗๒๙๐@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึง ระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ตัวชี้วัดกระทรวง	๓๕.๑) ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง และ ติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจน Barthel index = ๒๐ ก่อนครบ ๖ เดือน ๓๕.๒) ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care (ผู้ป่วยใน) มีค่าคะแนน Barthel index เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๒ คะแนน เมื่อได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางในหอผู้ป่วย IMC ward/bed ๓๕.๓) ร้อยละของผู้ป่วย Intermediate care (ผู้ป่วยนอก) ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๖ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๖ เดือน
ชื่อตัวชี้วัด	๒๓.ร้อยละผู้ป่วย Intermediate care* (ผู้ป่วยนอก) ให้ได้รับการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๖ ครั้ง หรือจน Barthel index = ๒๐ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน
คำนิยาม	การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care; IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ ๖ เดือน ตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางในโรงพยาบาลทุกระดับ (A/S/M/F) โดยให้บริการผู้ป่วยใน (Intermediate bed/ward) ผู้ป่วยนอก และให้บริการในชุมชน เช่น ศูนย์ฟื้นฟูชุมชน เยี่ยมบ้าน เป็นต้น *ผู้ป่วย Intermediate care หมายถึง ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury, Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำภายในระยะเวลา ๖ เดือน และ Fragility hip fracture รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดที่รอดชีวิต และมีคะแนน Barthel index < ๑๕ รวมทั้งคะแนน Barthel index ≥ ๑๕ with multiple impairments ตามเกณฑ์การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (IPD-IMC protocol) สำหรับโรงพยาบาลระดับ M และ F Intermediate ward คือ การให้บริการ Intensive inpatient rehabilitation program หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูแบบผู้ป่วยในอย่างน้อย วันละ ๓ ชั่วโมง และอย่างน้อย ๕ วัน/ สัปดาห์ หรือ อย่างน้อย ๑๕ ชั่วโมง/ สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care) โดยมีรายละเอียดการให้บริการ Intermediate ward ตามภาคผนวก ๑ Intermediate bed คือ การให้บริการ Inpatient rehab program หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๑ ชั่วโมงอย่างน้อย ๓ ครั้ง/สัปดาห์ (ไม่รวมชั่วโมง nursing care)

การพยาบาลฟื้นฟูสภาพ หมายถึง กิจกรรมการพยาบาลที่ใช้กระบวนการหรือกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้ป่วย คนพิการ สามารถฟื้นคืนสภาพให้เร็วที่สุด ยอมรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ โดยกระบวนการหรือกิจกรรม ต่าง ๆ นั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย คนพิการ ญาติผู้ดูแล และทีมสหวิชาชีพเพื่อ ส่งเสริมให้ผู้ป่วย คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้ตามศักยภาพ รวมถึงการพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ให้กับผู้ป่วย คนพิการ

กิจกรรมการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยนอก ได้แก่ กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และแก้ไขการพูด ทั้งในสถานพยาบาลภาครัฐ และภายนอก เช่น ศูนย์ฟื้นฟูชุมชนคลินิก กายภาพบำบัดเอกชนที่ขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ - การให้บริการ intermediate bed/ward สามารถให้บริการได้ในโรงพยาบาลทุกระดับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขขึ้นกับความพร้อมและบริบทของพื้นที่ในแต่ละจังหวัดและ เขตสุขภาพ

คำย่อ	คำเต็ม	คำอธิบาย
BI	Barthel ADL index	แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตรประจำวันบาร์เทิล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ ๒๐
IMC	Intermediate care	การบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลาง
IPD	In-patient department	หอผู้ป่วยในที่รับผู้ป่วยเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อการบำบัดรักษา
Stroke	Cerebrovascular accident	การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ได้แก่ ICD๑๐ ต่อไปนี้ I๖๐ - I๖๔
TBI	Traumatic brain injury	การวินิจฉัยบาดเจ็บสมองที่เกิดจากภยันตราย ได้แก่ ICD๑๐ ต่อไปนี้ S๐๖๑ - S๐๖๙
SCI	Spinal cord injury	การวินิจฉัยบาดเจ็บไขสันหลังจากภยันตราย (traumatic) ได้แก่ ICD ๑๐ ต่อไปนี้ S๑๔.๐ - S๑๔.๑, S๒๔.๐ - S๒๔.๑, S๓๔.๐ -S๓๔.๑, S๓๔.๓
	Fracture Hip (Fragility fracture)	การวินิจฉัยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) ได้แก่ ICD ๑๐ ต่อไปนี้ S๗๒.๐-S๗๒.๒
	Multiple Impairments	ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องตั้งแต่ ๒ ระบบขึ้นไป ได้แก่ swallowing problem, communication problem, mobility problem, cognitive and perception problem, bowel and bladder problem

	<table><tr><th>คำย่อ</th><th>คำเต็ม</th><th>คำอธิบาย</th></tr><tr><td>M๒</td><td>โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย</td><td>โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลน้ำพอง บ้านไผ่ และพล</td></tr><tr><td>F๑</td><td>โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่</td><td>โรงพยาบาลหนองสองห้อง มัญจาคีรี ภูเวียง และหนองเรือ</td></tr><tr><td>F๒</td><td>โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง</td><td>โรงพยาบาลบ้านฝาง พระยืน สีชมพู ภูผาม่าน เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ ชนบท แวงใหญ่ แวงน้อย เปือยน้อย และ ชำสูง</td></tr><tr><td>F๓</td><td>โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก</td><td>โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย หนองนาคำ โนนศิลา และเวียงเก่า</td></tr><tr><td>A</td><td>โรงพยาบาลศูนย์</td><td>โรงพยาบาลขอนแก่น</td></tr><tr><td>M๑</td><td>โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก</td><td>โรงพยาบาลสิรินธรฯ และ โรงพยาบาลชุมแพ</td></tr></table>	คำย่อ	คำเต็ม	คำอธิบาย	M๒	โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลน้ำพอง บ้านไผ่ และพล	F๑	โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	โรงพยาบาลหนองสองห้อง มัญจาคีรี ภูเวียง และหนองเรือ	F๒	โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	โรงพยาบาลบ้านฝาง พระยืน สีชมพู ภูผาม่าน เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ ชนบท แวงใหญ่ แวงน้อย เปือยน้อย และ ชำสูง	F๓	โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย หนองนาคำ โนนศิลา และเวียงเก่า	A	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลขอนแก่น	M๑	โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	โรงพยาบาลสิรินธรฯ และ โรงพยาบาลชุมแพ
คำย่อ	คำเต็ม	คำอธิบาย																				
M๒	โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลน้ำพอง บ้านไผ่ และพล																				
F๑	โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	โรงพยาบาลหนองสองห้อง มัญจาคีรี ภูเวียง และหนองเรือ																				
F๒	โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง	โรงพยาบาลบ้านฝาง พระยืน สีชมพู ภูผาม่าน เขาสวนกวาง อุบลรัตน์ ชนบท แวงใหญ่ แวงน้อย เปือยน้อย และ ชำสูง																				
F๓	โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย หนองนาคำ โนนศิลา และเวียงเก่า																				
A	โรงพยาบาลศูนย์	โรงพยาบาลขอนแก่น																				
M๑	โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก	โรงพยาบาลสิรินธรฯ และ โรงพยาบาลชุมแพ																				
เกณฑ์เป้าหมาย	๑).ร้อยละของ ผู้ป่วย Intermediate care* ได้รับการบริหารฟื้นฟูสภาพระยะกลาง และ ติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจน Barthel index = ๒๐ ก่อนครบ ๖ เดือน <table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>≥ ๘๕</td><td>≥ ๙๐</td><td>≥ ๙๕</td><td>≥ ๑๐๐</td><td>≥ ๑๐๐</td></tr></table>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	≥ ๘๕	≥ ๙๐	≥ ๙๕	≥ ๑๐๐	≥ ๑๐๐											
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐																		
≥ ๘๕	≥ ๙๐	≥ ๙๕	≥ ๑๐๐	≥ ๑๐๐																		
วัตถุประสงค์	๑.พัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วย Stroke, Traumatic brain injury, Spinal cord injury และ Hip Fracture (Fragility fracture) โดยผู้ป่วยได้รับการต่อเนื่องอย่างน้อย ๖ เดือน ๒.สร้างเครือข่ายบริการโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ๓.เพิ่มคุณภาพชีวิต ป้องกันและลดความพิการของผู้ป่วย ๔.เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติพร้อมเชื่อมโยงแผนการดูแลต่อเนื่องสู่ที่บ้านและชุมชน																					
กลุ่มเป้าหมาย	๑.ผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury รายใหม่ หรือกลับเป็นซ้ำทั้งหมดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัด ๒.ผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป ทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในจังหวัดด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภัยอันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility hip fracture)																					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และกรมการแพทย์																					

แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลระดับ A, S, M๑, M๒, F๑, F๒ และ F๓ ภายในจังหวัดที่เริ่มให้การรักษา และรับส่งต่อผู้ป่วย หรือระบบรายงาน HDC ของแต่ละโรงพยาบาล																											
รายการข้อมูล	ข้อมูล A = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่ได้รับการบริบาลพื้นสภาวะระยะกลาง* และติดตามจนครบ ๖ เดือน หรือจนกว่า Barthel index = ๒๐																											
	ข้อมูล B = จำนวนผู้ป่วย IMC ที่เข้าสู่ระบบบริบาลพื้นสภาวะระยะและติดตามทั้งหมด																											
สูตรคำนวณ ตัวชี้วัด	(A/B) × ๑๐๐																											
ระยะเวลา ประเมินผล	ปีละ ๑ ครั้ง																											
รายละเอียด ข้อมูล พื้นฐาน ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)	<table><tr><td rowspan="2">หน่วยวัด</td><td colspan="5">ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</td></tr><tr><td>๒๕๖๒</td><td>๒๕๖๓</td><td>๒๕๖๔</td><td>๒๕๖๕</td><td>๒๕๖๖</td></tr><tr><td>ร้อยละ</td><td>-</td><td>๓๖.๖๘</td><td>๙๙.๕๗</td><td>๘๘.๖๔</td><td>๘๐.๐๑</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">ผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข</td></tr></table>					หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.					๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	ร้อยละ	-	๓๖.๖๘	๙๙.๕๗	๘๘.๖๔	๘๐.๐๑		ผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข				
หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.																											
	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖																							
ร้อยละ	-	๓๖.๖๘	๙๙.๕๗	๘๘.๖๔	๘๐.๐๑																							
	ผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข																											
ผู้รับผิดชอบการ รายงานผลการดำเนินงานและ กำกับตัวชี้วัด	๑. นางกัญฐณิ สีนพิทักษ์เขต โทรศัพท์มือถือ : ๐๙-๔๒๙๑๔-๒๘๙ ๒. นางพัชราวดี พิรุณสุนทร โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๑๒๖๐-๔๔๓๓ งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ E-mail : Khunsin๙๙๙๙@gmail.com นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ E-mail : porror๒๐๒๐@gmail.com																											

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม				
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิและตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบ ส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ				
ตัวชี้วัดกระทรวง	-				
ชื่อตัวชี้วัด	๒๔.อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดลดลง ≤ ๕๐%				
คำนิยาม	จังหวัดส่งเสริมการใช้อย่างสมเหตุผลและจัดการเชื้อดื้อยา (RDU Province) หมายถึง จังหวัดขอนแก่นมีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ๓ รายการ ได้แก่ ๑. มีร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU hospital≥๓๐% ๒. อัตราเชื้อดื้อยาลดลงของจังหวัดขอนแก่นลดลงจากปี ๒๕๖๐ ≤ ๕๐% ๓. มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการร้านยาลดแออัดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑ แห่ง				
เกณฑ์เป้าหมาย					
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
วัตถุประสงค์	๑.ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด > ๓๐% ๒. อัตราเชื้อดื้อยาลดลงจากปี ๒๕๖๐ ≤ ๕๐%				
กลุ่มเป้าหมาย	๑.ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด > ๓๐% กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่น (๒๖ แห่ง) ๒.อัตราเชื้อดื้อยาของจังหวัดขอนแก่นลดลงจากปี ๒๕๖๐ ≤ ๕๐% กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น สิรินคร และชุมแพ ๓.โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการร้านยาลดแออัด ได้แก่ รพท. หรือ รพช.อย่างน้อย ๑ แห่ง				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑.รายงาน ๔๒ แฟ้ม (RDU Hospital) ๒.รายงานข้อมูลอัตราการติดเชื้อของโรงพยาบาล				

	๓.จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการร้านยาลดแออัด
แหล่งข้อมูล	๑.โปรแกรม HDC (RDU Hospital) ๒.โปรแกรม AMESS (อัตราการติดเชื้อของโรงพยาบาล) ๓.รายงานร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
รายการข้อมูล	๑.จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด ๒.รายการตัวชี้วัด RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด (กระทรวงอยู่ระหว่างการปรับปรุง) ๓.อัตราเชื้อดื้อยาของโรงพยาบาลในปีปัจจุบันเทียบกับปี ๒๕๖๐ ๔.จำนวนร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการร้านขายยาลดแออัด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑.ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด > ๓๐% = (จำนวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU hospitalx๑๐๐)/ (โรงพยาบาล ๒๖ แห่ง) ๒. (อัตราเชื้อดื้อยาปีปัจจุบัน-อัตราเชื้อดื้อยาปี ๒๕๖๐)*๑๐๐/อัตราเชื้อดื้อยาปี ๒๕๖๐
ระยะเวลาประเมินผล	ทุกไตรมาส

Small Success ปี ๒๕๖๗

รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๑.กำหนดโรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ RDU hospital ๒.ประมวลผลข้อมูลอัตราเชื้อดื้อยาปี ๒๕๖๖ ๓. กำหนดโรงพยาบาลเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการร้านยาลดแออัด	๑.ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด > ๑๐% ๒.อัตราเชื้อดื้อยาลดลงจากปี ๒๕๖๐ ≤ ๕๐% ๓. มีจำนวนร้านขายยาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการร้านยาลดแออัดในอำเภอเป้าหมายอย่างน้อย ๑ แห่ง	๑.ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด > ๒๐% ๒. อัตราเชื้อดื้อยาลดลงจากปี ๒๕๖๐ ≤ ๕๐% ๓. โรงพยาบาลกำหนดจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะกระจายไปร้านขายยาและกำหนดรูปแบบ model การรับยาที่ร้านขายยา	๑.ร้อยละโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ RDU Hospital ที่กระทรวงกำหนด > ๓๐% ๒. อัตราเชื้อดื้อยาลดลงจากปี ๒๕๖๐ ≤ ๕๐% ๓. มีการส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการลดแออัด

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางศศิธร เอื้ออนันต์ ตำแหน่ง เกษัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗
-----------------------	--

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อและเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ
ชื่อตัวชี้วัด	๒๕. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คำนิยาม	การบริหารป็นสภาวะระยะกลาง (Intermediate care, IMC) หมายถึง การบริหาร พันฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติ และมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ ๖ เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ (A, S: เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย M, F: โรงพยาบาลลูกข่ายและให้บริการ intermediate bed ward) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีรหัส ๓ ตัวหลัก ขึ้นต้นด้วย I๖๐-I๖๔ คำนิยามด้านการแพทย์แผนไทย อัมพฤกษ์ (Paresis) อัมพาต (paralysis) เป็นกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้อง กับความผิดปกติ ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตกหรือเกิดจาก สมองไขสันหลังหรือเส้นประสาท ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการอักเสบ เป็นต้น ในทางการแพทย์แผนไทยได้มรการระบุสมุฏฐานไว้ว่า เกิดจากลมอโรคมาวาตา และลมอุทังคมาวาตา พัดระคนกัน(แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์,๒๕๔๒ ๒๕๔๖) เป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยรหัสโรคด้านการแพทย์แผนไทย U๖๑.๐,U๖๑.๑ การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ได้แก่ ๑) การตรวจประเมินทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๒) การรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - การนวดเพื่อการรักษา พันฟูสภาพ - การประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา พันฟูสภาพ - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษาพันฟูสภาพ - ฝังเข็ม

	๓) การรักษาด้วยยาสมุนไพร ตามข้อบ่งใช้บัญชียาหลักชาติ อาจพิจารณานำยาในกลุ่มรายการยารักษาอาการกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ตำรับยาสมุนไพรที่มีกัญชาปรุงผสม ยาแก้ลมอัมพฤกษ์, ยาผสมโคคลาน, ยาผสมเถาวัลย์เปรียง และยาหสธารา มาใช้เพื่อร่วมรักษาอาการ ของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต (บัญชียาหลักแห่งชาติ, ๒๕๕๘) ผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) หมายถึง ผู้ที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองที่มีรหัส ๓ ตัวหลัก ขึ้นต้นด้วย I๖๐-I๖๙ ตามด้วย - รหัสโรคด้านการแพทย์แผนไทย U๖๑.๐, U๖๑.๑ ควบคู่กับการให้หัตถการแผนไทย(๙๐๐-๗๗-๐๐) ถึง (๙๐๐-๗๘-๘๘) หรือการส่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยวหรือยาสมุนไพรที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย ๔๑ หรือ ๔๒ - รหัสโรคด้านการแพทย์แผนจีน U๗๘๑๑๐ - U๗๘๑๑๗ ควบคู่กับการให้หัตถการการแพทย์แผนจีน ๙๙๙๑๘๐๑, ๙๙๙๑๘๑๐, ๙๐๒๑๘๐๑, ๙๙๙๑๘๑๑,๙๐๓๐๑๘๐๑										
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ ๒๐ <table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>-</td><td>≥๒๐</td><td>≥๒๑</td><td>≥๒๒</td><td>≥๒๓</td></tr></table>	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	-	≥๒๐	≥๒๑	≥๒๒	≥๒๓
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐							
-	≥๒๐	≥๒๑	≥๒๒	≥๒๓							
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base)										
กลุ่มเป้าหมาย	สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)										
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนไทยจากข้อมูล ๔๓ แฟ้ม HDC จังหวัดขอนแก่น										
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม จาก HDC จังหวัดขอนแก่น										
การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ) ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก = จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (คน) X ๑๐๐ จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) (คน)											

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทย <table><tr><td>๒๕๖๔</td><td>๒๕๖๕</td><td>๒๕๖๖</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>๘.๗๑</td></tr></table>	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	-	-	๘.๗๑																																																																																																										
๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖																																																																																																															
-	-	๘.๗๑																																																																																																															
๑๖. รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ แยกรายอำเภอ	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาต ระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก <table><tr><th>Baseline data</th><th colspan="3">ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr><tr><th></th><th>๒๕๖๔</th><th>๒๕๖๕</th><th>๒๕๖๖</th></tr><tr><td>เมืองขอนแก่น</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>บ้านฝาง</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>พระยืน</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>หนองเรือ</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>ชุมแพ</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>สีชมพู</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๑๘.๑๘</td></tr><tr><td>น้ำพอง</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>อุบลรัตน์</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๖.๖๗</td></tr><tr><td>กระนวน</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๕.๓๐</td></tr><tr><td>บ้านไผ่</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>เปือยน้อย</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๑๐.๕๓</td></tr><tr><td>พล</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>เวียงใหญ่</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>เวียงน้อย</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๑๔.๗๑</td></tr><tr><td>หนองสองห้อง</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>ภูเวียง</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>มีนบุรี</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๒.๔๑</td></tr><tr><td>ชนบท</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>เขาสวนกวาง</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>ภูผาม่าน</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>ซำสูง</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>โคกโพธิ์ไชย</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๑๗.๓๙</td></tr><tr><td>หนองนาคำ</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>บ้านแฮด</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>โนนศิลา</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr><tr><td>เวียงเก่า</td><td>NA</td><td>NA</td><td>๐</td></tr></table>	Baseline data	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.				๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	เมืองขอนแก่น	NA	NA	๐	บ้านฝาง	NA	NA	๐	พระยืน	NA	NA	๐	หนองเรือ	NA	NA	๐	ชุมแพ	NA	NA	๐	สีชมพู	NA	NA	๑๘.๑๘	น้ำพอง	NA	NA	๐	อุบลรัตน์	NA	NA	๖.๖๗	กระนวน	NA	NA	๕.๓๐	บ้านไผ่	NA	NA	๐	เปือยน้อย	NA	NA	๑๐.๕๓	พล	NA	NA	๐	เวียงใหญ่	NA	NA	๐	เวียงน้อย	NA	NA	๑๔.๗๑	หนองสองห้อง	NA	NA	๐	ภูเวียง	NA	NA	๐	มีนบุรี	NA	NA	๒.๔๑	ชนบท	NA	NA	๐	เขาสวนกวาง	NA	NA	๐	ภูผาม่าน	NA	NA	๐	ซำสูง	NA	NA	๐	โคกโพธิ์ไชย	NA	NA	๑๗.๓๙	หนองนาคำ	NA	NA	๐	บ้านแฮด	NA	NA	๐	โนนศิลา	NA	NA	๐	เวียงเก่า	NA	NA	๐
Baseline data	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.																																																																																																																
	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖																																																																																																														
เมืองขอนแก่น	NA	NA	๐																																																																																																														
บ้านฝาง	NA	NA	๐																																																																																																														
พระยืน	NA	NA	๐																																																																																																														
หนองเรือ	NA	NA	๐																																																																																																														
ชุมแพ	NA	NA	๐																																																																																																														
สีชมพู	NA	NA	๑๘.๑๘																																																																																																														
น้ำพอง	NA	NA	๐																																																																																																														
อุบลรัตน์	NA	NA	๖.๖๗																																																																																																														
กระนวน	NA	NA	๕.๓๐																																																																																																														
บ้านไผ่	NA	NA	๐																																																																																																														
เปือยน้อย	NA	NA	๑๐.๕๓																																																																																																														
พล	NA	NA	๐																																																																																																														
เวียงใหญ่	NA	NA	๐																																																																																																														
เวียงน้อย	NA	NA	๑๔.๗๑																																																																																																														
หนองสองห้อง	NA	NA	๐																																																																																																														
ภูเวียง	NA	NA	๐																																																																																																														
มีนบุรี	NA	NA	๒.๔๑																																																																																																														
ชนบท	NA	NA	๐																																																																																																														
เขาสวนกวาง	NA	NA	๐																																																																																																														
ภูผาม่าน	NA	NA	๐																																																																																																														
ซำสูง	NA	NA	๐																																																																																																														
โคกโพธิ์ไชย	NA	NA	๑๗.๓๙																																																																																																														
หนองนาคำ	NA	NA	๐																																																																																																														
บ้านแฮด	NA	NA	๐																																																																																																														
โนนศิลา	NA	NA	๐																																																																																																														
เวียงเก่า	NA	NA	๐																																																																																																														

๑๗. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

๑) นางวรารณ ชูคันหอมตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๒) นางสาววีรินทร์ วงษ์โศภิตตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓) นางฐิติญา ดุลย์จินดาชาพร ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๒๓๖,๒๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๒๓๖๖๑๕๕
โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗ e-mail : veerinvong@hotmail.co.th

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับทั่วถึง ไร้รอยต่อและเป็นธรรม				
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ ตติยภูมิขั้นสูง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพและไร้รอยต่อ				
ชื่อตัวชี้วัด	๒๖.ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก				
คำนิยาม	ผู้ป่วยนอก หมายถึง ประชาชนที่มาใช้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ แบบไม่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐานการบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ เช่น - การรักษาด้วยยาสมุนไพร - การนวดเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ - การอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ - การประคบสมุนไพรเพื่อรักษา-ฟื้นฟูสภาพ - การพอกยาสมุนไพรเพื่อการรักษา - การบำบัดหม้อเกลือ - การทำหัตถการอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย หรือการบริการอื่นๆที่มีการเพิ่มรหัสภายหลัง การบริการด้านการแพทย์ทางเลือก หมายถึง บริการรักษาพยาบาล นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น - ผิงเข็ม - การแพทย์ทางเลือกอื่นๆ หรือการบริการอื่นๆที่มีการเพิ่มรหัสภายหลัง สถานบริการสาธารณสุขสุขภาพรัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล				
เกณฑ์เป้าหมาย	ร้อยละผู้ป่วยนอกที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๒๑				
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	≥๒๑	≥๒๑	≥๒๑	≥๒๑	≥๒๑
วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มีการวินิจฉัยโรคข้อเข่าเสื่อม เข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ ครอบคลุมสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ (Community base)				
กลุ่มเป้าหมาย	สถานบริการสุขภาพทุกแห่ง ในเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP)				

วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ข้อมูลการให้บริการการแพทย์แผนไทยจากข้อมูล ๔๓ แฟ้ม HDC จังหวัดขอนแก่น											
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม จาก HDC จังหวัดขอนแก่น											
การประมวลผลตัวชี้วัด (สูตรการคำนวณ) ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก = $\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ครั้ง)} \times 100}{\text{จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่มารับบริการ (ครั้ง)}}$												
เกณฑ์การให้คะแนน	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้มาตรฐาน											
ระยะเวลาประเมินผล	ตามรอบการนิเทศและประเมินผล ๒ ครั้ง/ปี											
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data)	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก <table><tr><th colspan="3">ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.</th></tr><tr><th>๒๕๖๔</th><th>๒๕๖๕</th><th>๒๕๖๖</th></tr><tr><td>๒๐.๖๙</td><td>๒๐.๓๕</td><td>๒๑.๔๓</td></tr></table>			ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๐.๖๙	๒๐.๓๕	๒๑.๔๓
ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.												
๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖										
๒๐.๖๙	๒๐.๓๕	๒๑.๔๓										

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๖ แยกรายอำเภอ	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก			
	อำเภอ	ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
	เมืองขอนแก่น	๑๘.๘๙	๑๘.๔๑	๑๐.๓๐
	บ้านฝาง	๒๑.๒๒	๑๘.๓๓	๒๕.๙๕
	พระยืน	๒๗.๓๙	๒๙.๖๑	๒๑.๖๖
	หนองเรือ	๑๘.๐๗	๑๘.๘๙	๑๑.๖๖
	ชุมแพ	๑๕.๔๓	๑๕.๙๕	๘.๕๗
	สีชมพู	๑๔.๑๑	๑๕.๘๕	๕.๑๔
	น้ำพอง	๒๐.๓๒	๑๘.๘๙	๑๕.๑๙
	อุบลรัตน์	๑๗.๕๖	๒๓.๐๒	๘.๖๓
	กระนวน	๒๐.๓๔	๑๗.๗๘	๑๓.๘๑
	บ้านไผ่	๒๒.๘๗	๑๙.๔๕	๑๗.๓๗
	เปือยน้อย	๑๗.๕๘	๒๘.๑๑	๑๒.๑๑
	พล	๓๑.๕๐	๒๘.๐๘	๑๙.๑๔
	แก้งใหญ่	๑๗.๙๖	๒๑.๗๘	๑๗.๗๙
	แก้งน้อย	๒๗.๑๔	๒๒.๐๑	๓๐.๖๕
	หนองสองห้อง	๓๐.๐๒	๒๖.๓๓	๒๑.๓๔
	ภูเวียง	๒๔.๓๙	๒๔.๔๔	๘.๗๐
	มัญจาคีรี	๒๔.๙๕	๒๒.๐๘	๑๒.๙๒
	ชนบท	๒๒.๕๖	๒๖.๐๕	๑๒.๗๖
	เขาสวนกวาง	๑๘.๑๒	๑๖.๔๔	๑๒.๔๑
	ภูผาม่าน	๑๗.๘๒	๒๙.๕๕	๙.๔๕
	ซำสูง	๑๕.๖๐	๑๗.๔๘	๕.๙๗
	โคกโพธิ์ไชย	๒๒.๙๔	๒๕.๕๐	๑๑.๙๕
	หนองนาคำ	๒๒.๐๓	๒๒.๐๓	๙.๕๔
	บ้านแฮด	๑๕.๐๓	๑๖.๐๘	๑๒.๗๕
โนนศิลา	๓๒.๕๑	๓๓.๒๔	๒๖.๕๒	
เวียงเก่า	๒๑.๖๐	๒๐.๘๖	๑๔.๙๔	

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	
๑) นางวรารักษ์ ชูคันหอมตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๒) นางสาววิริณทร์ วงษ์โคกวินท์ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓) นางฐิติญา ดุลย์จินดาชาพร ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๒๓๖,๒๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๒๓๖๖๑๕๕ โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗	
e-mail : veerinvong@hotmail.co.th	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทัวถึง ไร้รอยต่อและเป็นธรรม				
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพ ตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทติยภูมิ และตติยภูมิ ขึ้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ				
ตัวชี้วัดกระทรวง	-				
ชื่อตัวชี้วัด	๒๗.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี				
คำนิยาม	๑.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน ด้วยรหัส E๑๐-E๑๔ และได้รับการขึ้นทะเบียนโรคเบาหวาน โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ Type area ๑,๓ ๒.ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA๑C หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ HbA๑C ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๓.ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ๓.๑ ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มีโรคร่วม มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด HbA๑C ครั้งสุดท้าย < ร้อยละ ๗ หรือ ๓.๒ ผู้ป่วยเบาหวาน มีโรคร่วม มีค่าระดับน้ำตาลในเลือด HbA๑C ครั้งสุดท้าย < ร้อยละ ๘ หมายเหตุ : รหัส ICD๑๐ มีโรคร่วม ได้แก่ ๑.รหัสโรคเบาหวาน E๑๐-E๑๔ (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคหัวใจขาดเลือด I๒๐-I๒๕ ๒.รหัสโรคเบาหวาน E๑๐-E๑๔ (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคหัวใจล้มเหลว I๕๐ ๓.รหัสโรคเบาหวาน E๑๐-E๑๔ (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคหลอดเลือดสมอง I๖๐-I๖๙ ๔.รหัสโรคเบาหวาน E๑๐-E๑๔ (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ ๔-๕ N๑๘.๔-N๑๘.๕ ๕.รหัสโรคเบาหวาน E๑๐-E๑๔ (นับทุกจุดที่ตามหลังรหัส) ร่วมกับรหัสโรคลมชักและโรคลมชักชนิดต่อเนื่อง G๔๐-G๔๑				
เกณฑ์เป้าหมาย		ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๔๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔๐	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๔๐	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ๔๐
วัตถุประสงค์	เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังทางระบบต่างๆ เช่น ตา ไต ระบบประสาทส่วนปลาย ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือด				
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด Type area ๑ , ๓				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม				
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม				

รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานในเขตรับผิดชอบทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาประเมินผล	๑๒ เดือน			
วิธีการประเมินผล	ติดตามจากระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข คิดจาก ๔๓ แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย E๑๐ – E๑๔ ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“๑”, “๓”) ๑ (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบและอยู่จริง), ๓ (มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHARGE = “๙” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION = “๐๙๙” (สัญชาติไทย) และได้รับการตรวจ HbA๑c (LABFU.LABTEST = “๐๕๓๑๖๐๑”) ระดับ HbA๑c ครั้งสุดท้ายใช้ข้อมูลจาก LABFU.LABRESULT – HbA๑c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่าร้อยละ ๗ ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่มีโรคร่วม – HbA๑c ครั้งสุดท้ายน้อยกว่า ร้อยละ ๘ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย E๑๐ – E๑๔ ที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ PERSON.TYPE AREA IN (“๑”, “๓”) ๑ (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่ รับผิดชอบและอยู่จริง), ๓ (มาอาศัยอยู่ในเขต รับผิดชอบ แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขต) และ PERSON.DISCHARGE= “๙” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION= “๐๙๙” (สัญชาติไทย) ๒๓.๙๔ ๒๔.๕๑ ๒๖.๕๖๘๑๖๑๑๑			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)	ตัวชี้วัด	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
	ร้อยละ ของ ผู้ ป่วย โรคเบาหวานที่ควบคุม ระดับน้ำตาลได้ดี	๒๓.๙๔	๒๔.๕๑	๒๖.๖๐
ผู้รับผิดชอบ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๓ - ๒๒๑๑๕๒ , ๒๒๑๗๕๐ ต่อ ๑๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๒๒๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐๓๒๑๙ E-mail : sangdern.sopa@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทัวถึง ไร้รอยต่อและเป็นธรรม				
เป้าประสงค์ที่ ๔	ระบบบริการสุขภาพ ตั้งแต่ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ขึ้นสูง มีคุณภาพได้มาตรฐาน ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพ และไร้รอยต่อ				
ตัวชี้วัดกระทรวง	-				
ชื่อตัวชี้วัด	๒๘.ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี				
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง รหัส ๑๐-๑๕ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย < ๑๔๐/๙๐ mmHg ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะมีโรคเบาหวานร่วมด้วยหรือไม่				
เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	
	๖๐	๖๐	๖๐	๖๐	
วัตถุประสงค์	เพื่อควบคุมและลดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคอัมพาต				
กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด Type area ๑ , ๓				
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม				
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม				
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย < ๑๔๐/๙๐ mmHg ในปีงบประมาณ B : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐				
ระยะเวลาประเมินผล	๑๒ เดือน				
วิธีการประเมินผล	คิดจาก ๔๓ แฟ้ม (ช่วงปีงบประมาณ) A : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย ๑๐ – ๑๕ ในเขตรับผิดชอบ PERSON.TYPEAREA IN (“๑” , “๓”) ๑ (มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และอยู่จริง) ,๓ (มาอาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่ทะเบียนอยู่นอกเขตรับผิดชอบ) และ PERSON.DISCHAGE = “๙” (ไม่จำหน่าย) PERSON.NATION= “๐๙๙” (สัญชาติไทย) และมีค่าระดับความดันโลหิตครั้งสุดท้าย ใช้ข้อมูลจาก CHRONICFU (CHRONICFU.SBP BETWEEN ๕๐ and ๑๓๙ mmHg), (CHRONICFU.DBP BETWEEN ๕๐ and ๘๙ mmHg)				

	B : จำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD, DIAGNOSIS_IPD, CHRONIC รหัส ICD-๑๐ ๓ หลักขึ้นต้นด้วย 1๐ - 1๕ (สัญชาติไทย) ในเซตรับผิดชอบPERSON.TYPE AREA IN (“๑”, “๓”)			
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	Baseline data	ผลการดำเนินงานในรอบงบประมาณ พ.ศ.		
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
	ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี	๖๒.๕๔	๕๗.๘๒	๕๓.๒๒
ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงานตัวชี้วัด/ กลุ่มงาน	ชื่อ-สกุล นางแสงเดือน โสภา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ที่ทำงาน ๐๔๓ - ๒๒๑๑๕๒ , ๒๒๑๗๕๐ ต่อ ๑๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๒๒๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๓๘๐๓๒๑๙ E-mail : sangdern.sopa@gmail.com			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทัวถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม
เป้าประสงค์ที่ ๕	ประชาชนได้รับบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดกระทรวง	จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
ชื่อตัวชี้วัด	๒๙.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
คำนิยาม	หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หมายความว่า แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวจากหลักสูตรที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้ความเห็นชอบ ๑.หลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic Course of Family Medicine for Primary Care Doctor ๒.หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น “เวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว” พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมด้านสุขภาพปฐมภูมิเพื่อเป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดูแลสุขภาพของบุคคลในบัญชีรายชื่อ ซึ่งมีขอบเขต ดังต่อไปนี้ (๑) บริการสุขภาพอย่างองค์รวม แต่ไม่รวมถึงการดูแลโรคหรือปัญหาสุขภาพที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ซับซ้อน การปลูกถ่ายอวัยวะ และการผ่าตัด ยกเว้น การผ่าตัดขนาดเล็กซึ่งสามารถฉีดยาเฉพาะที่ (๒) บริการสุขภาพตั้งแต่แรก ครอบคลุมทุกระบวนการสาธารณสุข ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ แต่ไม่รวมถึงการบริการแบบผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การบริการแบบผู้ป่วยใน การคลอด และการปฏิบัติการฉุกเฉิน ยกเว้น กรณีการปฐมพยาบาลและการดูแลในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้รอดพ้นภาวะฉุกเฉิน (๓) บริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทุกช่วงวัยตั้งแต่ การตั้งครรภ์ ทารก วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอายุ จนกระทั่งเสียชีวิต (๔) การดูแลสุขภาพของบุคคลแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การดูแลสุขภาพโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์ทางเลือก

	(๕) การบริการข้อมูลด้านสุขภาพและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคลในบัญชีรายชื่อตลอดจน คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือเข้าสู่ระบบการส่งต่อ (๖) การส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพและมีความรู้ในการจัดการสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ตลอดจนอาจสามารถร่วมตัดสินใจในการวางแผนการดูแลสุขภาพร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้ (๗) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคในระดับชุมชน								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>๑๒๐ ทีม ร้อยละ ๗๐</td><td>๑๒๘ ทีม ร้อยละ ๗๕</td><td>๑๓๖ ทีม ร้อยละ ๘๐</td><td>๑๔๗ ทีม ร้อยละ ๘๕</td></tr></table> เหตุผลความจำเป็นในการปรับลดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด การขับเคลื่อนพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะมีผลบังคับใช้ ตุลาคม ๒๕๖๕ จากสถานการณ์ดังกล่าว นับเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่า รพ.สต./สอ. ที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน ๓,๒๖๓ หน่วย ทำให้คุณสมบัติที่จะคงสภาพเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิมีไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การขาดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ถ่ายโอน รพ.สต. แต่ เจ้าหน้าที่ไม่ถ่ายโอนไป ทำให้ขาดบุคลากรในส่วนที่เป็นตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จังหวัดจึงปรับลดตามเป้าของกระทรวงสาธารณสุข	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	๑๒๐ ทีม ร้อยละ ๗๐	๑๒๘ ทีม ร้อยละ ๗๕	๑๓๖ ทีม ร้อยละ ๘๐	๑๔๗ ทีม ร้อยละ ๘๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐						
๑๒๐ ทีม ร้อยละ ๗๐	๑๒๘ ทีม ร้อยละ ๗๕	๑๓๖ ทีม ร้อยละ ๘๐	๑๔๗ ทีม ร้อยละ ๘๕						
วัตถุประสงค์	๑.เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ๒.เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง สามารถดูแลตนเองและครอบครัวเบื้องต้นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยได้อย่างเหมาะสม ๓.เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ								
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกสังกัด								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	- จัดเก็บจากข้อมูลจำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในระบบขึ้นทะเบียน - การจัดเก็บการประเมินคุณภาพมาตรฐาน จากระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU)								
แหล่งข้อมูล	ระบบขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU)								
รายการข้อมูล	A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียน B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามแผนการจัดตั้ง								

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × ๑๐๐						
ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ ๑ ครั้ง						
วิธีการประเมิน	ประเมินผลจากระบบลงทะเบียนจากระบบขึ้นทะเบียน และส่งลงประเมินในพื้นที่						
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	<table><tr><td>ปี ๒๕๖๔</td><td>ปี ๒๕๖๕</td><td>ปี ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>๑๐๔ ทีม</td><td>๑๑๐ ทีม</td><td>๑๒๖ ทีม</td></tr></table>	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	๑๐๔ ทีม	๑๑๐ ทีม	๑๒๖ ทีม
ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖					
๑๐๔ ทีม	๑๑๐ ทีม	๑๒๖ ทีม					
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางสาวกรรณก บุญมาหล้า ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงาน...พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ...๐๘๖ - ๒๙๑๗๘๕๐ E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงาน..พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๐ - ๓๕๗๐๙๑๐ E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com ชื่อ-สกุล...นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง...หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงาน...พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗						

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงระบบบริการทุกระดับ ทั้งถึง ไร้รอยต่อ และเป็นธรรม									
เป้าประสงค์ที่ ๕	ประชาชนได้รับการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ									
ตัวชี้วัดกระทรวง	-									
ชื่อตัวชี้วัด	๓๐.อัตราส่วนการใช้บริการผู้ป่วยนอกที่หน่วยบริการปฐมภูมิเทียบกับ รพ.แม่ข่าย (๖๐ : ๔๐)									
คำนิยาม	หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุกสังกัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการแม่ข่าย หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นสถานพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ ที่ดูแลระบบส่งต่อด้าน การบำบัดรักษา ฟันฟูของ รพ.สต เครือข่ายระดับปฐมภูมิ OP VISIT หมายถึง ข้อมูลผู้ป่วยนอกที่มารับบริการในรูปแบบ ไป-กลับ โดยไม่มีการเข้ารับรักษาตัวหรือนอนที่สถานพยาบาล และไม่รวมงานด้านส่งเสริม ป้องกัน และฟันฟู สุขภาพ โดยใช้รหัสการวินิจฉัยตามหลัก ICD-๑๐-TM									
เกณฑ์เป้าหมาย										
	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐						
	ผ่านเกณฑ์ ๖๐ : ๔๐ ร้อยละ ๘๐	ผ่านเกณฑ์ ๖๐ : ๔๐ ร้อยละ ๘๕	ผ่านเกณฑ์ ๖๐ : ๔๐ ร้อยละ ๙๐	ผ่านเกณฑ์ ๖๐ : ๔๐ ร้อยละ ๙๕						
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ๒. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน									
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกสังกัด									
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	เก็บข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข HDC datacenter (OP visit)									
แหล่งข้อมูล	ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข HDC datacenter									
รายการข้อมูล	A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ ๖๐ : ๔๐ B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด									
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A / B) x ๑๐๐									
ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ ๑ ครั้ง									
วิธีการประเมิน	ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสุข HDC datacenter									
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data)	<table><tr><td>ปี ๒๕๖๔</td><td>ปี ๒๕๖๕</td><td>ปี ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>-</td><td>ร้อยละ ๔๗</td><td>ร้อยละ ๑๒</td></tr></table>				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	-	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๑๒
ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖								
-	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๑๒								

ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางสาวกรรณก บัญมาหล้า ตำแหน่ง..นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงาน...พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ...๐๘๖ - ๒๙๑๗๘๕๐ E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com
ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐ - ๓๕๗๐๙๑๐ E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com นางศิริมา นามประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๖	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
ชื่อตัวชี้วัด	๓๑. ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างน้อย ๒ เรื่อง
คำนิยาม	๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้าง อย่างน้อย ๖ เดือนขึ้นไป ๒. สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานโดดเด่นได้ในองค์กร สมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งและในทุกระดับในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำเป็นที่จะต้อง มี สมรรถนะที่กำหนดขึ้นเพราะมีความจำเป็นสำหรับภารกิจการทำงานในหน้าที่ และตำแหน่งงานนั้น ๆ ประกอบด้วย สมรรถนะภารกิจหลัก ๑. สมรรถนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ ๒. สมรรถนะด้านการดำเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข สมรรถนะภารกิจรอง ๑. สมรรถนะด้านการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ /ตำบล ๒. สมรรถนะด้านการประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ ๔. สมรรถนะด้านการควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ๕. สมรรถนะด้านการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและจังหวัด ๖. สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ๑. สมรรถนะด้านสนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
ระดับการแสดงผล	เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เกณฑ์เป้าหมาย ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะหลัก ได้แก่ สมรรถนะด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่และ สมรรถนะด้านการดำเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข ๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะรอง อย่างน้อย ๑ ด้าน	

วัตถุประสงค์	๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้มีขีดความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจของส่วนราชการให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น		
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเข้ารับการอบรม ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองการอบรม ในระบบ online และ onsite เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเอกสารการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ การตรวจมาตรฐานการดำเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์ และการสาธารณสุข		
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส ๔		
การประเมินผล			
	รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน
	รอบ ๑๒ เดือน		
	๑. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite	๑. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite	๑. บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอได้รับการอบรมพัฒนาสมรรถนะหลัก ๒ เรื่อง สมรรถนะรอง อย่างน้อย ๒ เรื่อง ทั้งระบบ online หรือ onsite
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	๑.นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๓ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๔๑๙๙๔๖๔ ๒.นายวีระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๓ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๗-๗๒๓๒๒๑๒ ๓.นางสาวสิริพรรณ พร้อมไพล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๖ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๕๕๔๔๖๒๖ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น		

หมายเหตุ จัดส่งรายงานได้ทาง E-mail : hrdkhonkaenrbr@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๖	บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับมีขีดความสามารถในการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ
ข้อตัวชี้วัด	๓๒.หน่วยบริการสุขภาพได้รับการพัฒนากำลังคนตามแผนยกระดับระดับบริการการจัดระบบบริการสุขภาพ (SAP)
คำนิยาม	๑. การยกระดับการจัดระบบบริการสุขภาพ (SAP) หมายถึง การยกระดับโรงพยาบาลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพิ่มศักยภาพการบริการตามความต้องการของประชาชนบริบท ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ ๒. พัฒนาสมรรถนะกำลังคน หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะความสามารถ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานโดดเด่นได้ในองค์กรสมรรถนะที่ผู้ปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งและในทุกระดับในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำเป็นที่จะต้องมีความสมรรถนะที่กำหนดขึ้นเพราะมีความจำเป็นสำหรับภารกิจการปฏิบัติงานในหน้าที่ และตำแหน่งงานนั้น ๆ
ระดับการแสดงผล	เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

เกณฑ์เป้าหมาย

- ๑.โรงพยาบาลระดับ P⁺ ได้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับการ พัฒนากำลังคนให้มีแพทย์ ครบทุกสาขา ภายในปี พ.ศ.๒๕๗๐
- ๒.โรงพยาบาลระดับ P ได้แก่ โรงพยาบาลชุมแพ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ให้มีแพทย์ ๕ สาขาหลัก ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ และ ออร์โธปิดิกส์ รวมถึงสาขาที่จำเป็น อย่างน้อยสาขาละ ๔ คน ภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๐
- ๓.โรงพยาบาลระดับ A⁺ ได้แก่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ได้รับการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ให้มีแพทย์ ๕ สาขาหลัก ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ และ ออร์โธปิดิกส์ รวมถึงสาขาที่จำเป็น อย่างน้อยสาขาละ ๔ คน ภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๐
- ๔.โรงพยาบาลระดับ A ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลพล และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ได้รับการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ให้มีแพทย์ ๔ สาขาหลัก ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ และศัลยแพทย์ รวมถึงสาขาที่จำเป็น อย่างน้อยสาขาละ ๔ คน ภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๐
- ๕.โรงพยาบาลระดับ S⁺ ได้แก่ โรงพยาบาลภูเวียง โรงพยาบาลมัญจาคีรี โรงพยาบาลสีชมพู โรงพยาบาลหนองเรือ และโรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้รับการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ให้มีแพทย์ สาขาหลัก ได้แก่ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว อย่างน้อยสาขาละ ๓ คน ภายในปีพ.ศ. ๒๕๗๐
- ๖.โรงพยาบาลระดับ S ได้แก่ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ โรงพยาบาลแวงน้อย โรงพยาบาลชนบท โรงพยาบาลแวงใหญ่ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลเปือยน้อย โรงพยาบาลภูผาม่านโรงพยาบาลข้าสูง โรงพยาบาลบ้านฝาง โรงพยาบาลโนนศิลา โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย โรงพยาบาลหนองนาคำโรงพยาบาลเวียงเก่า ได้รับการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ให้มีแพทย์สาขา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

วัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับโรงพยาบาล เพิ่มการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานเพิ่มศักยภาพการบริการตามความต้องการของประชาชน บริบท ศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๖ แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการเข้ารับการศึกษาต่อฝึกอบรม การจัดสรรบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส ๓ และ ๔
วิธีการประเมินผล	
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	๑. นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๓ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๔๑๙๙๔๖๔ ๒. นายวีระพงษ์ กิตติศิริวัฒนกุล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๓ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๗-๗๒๓๒๒๑๒ ๒. นางสาวสิริพรรณ พร้อมไพล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๖ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๕๕๔๔๖๒๖ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ จัดส่งรายงานได้ทาง E-mail : hrdkhonkaenrbr@gmail.com

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๗	เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด	๓๓.จำนวนผลงานวิจัย/ R๒R/ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอดที่แก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น
คำนิยาม	๑. ผลงานวิจัย/ ผลงาน R๒R (Routine to Research) หมายถึง ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีการที่เชื่อถือได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีหรือกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง/ การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด เพื่อให้ได้ความรู้ที่เชื่อถือได้มีเหตุผลเป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และนำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ในการให้บริการด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญจังหวัดขอนแก่นได้ ๒. นวัตกรรม (Innovative) หมายถึง สิ่งที่ทำขึ้นใหม่ หรือแตกต่างจากเดิม ซึ่งอาจเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ๓. นวัตกรรมจัดการบริการสุขภาพ (Innovative Healthcare Management) หมายถึง นวัตกรรมการบริหารและการจัดบริการสุขภาพใหม่ แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รวดเร็ว สะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ๔. เทคโนโลยีทางสุขภาพ หมายถึง การรวบรวมความรู้และวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย เพื่อให้บุคคลหรือชุมชนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิต ทั้งนี้หมายรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์สุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์หรือเครื่องมือสุขภาพ) และบริการสุขภาพ (เทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ) ๕. การพัฒนาต่อยอด หมายถึง การนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่เคยมีการศึกษา วิจัยประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นที่สำเร็จแล้ว นำมาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดประโยชน์เพิ่มเติมจากเดิม ๖. การนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การมีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษา วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ๗. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หมายถึง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุข ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมายเหตุ: ผลงานวิจัย/ R๒R/ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด ต้องเป็นผลงานที่มีการดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ และไม่เป็นผลงานที่เป็นวิทยานิพนธ์ /ไม่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน/การศึกษาต่อ หรือไม่เป็นผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับให้สูงขึ้น (อวช.)

	๘. ปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มอายุคาดเฉลี่ย LE /HALE และยุทธศาสตร์การยกระดับหน่วยบริการ SAP/Service Plan/Health Need ได้แก่ ๑. มะเร็งทุกชนิด ๒. หลอดเลือดสมอง ๓. เบาหวานและความดันโลหิตสูง** (Multi center วิจัยร่วม สสจ.ขก (Owner) CUP (Supporter) ๔. วัณโรคปอด ๕. ไตวายเรื้อรัง ๖. อุบัติเหตุจราจร ๖. ความดันโลหิตสูง ๘. แม่และเด็ก ๙. ปอดบวม ๑๐. โลหิตเป็นพิษ ** วิจัยร่วม *เลือกตามบริบทปัญหาของพื้นที่
ระดับการแสดงผล	เครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เกณฑ์เป้าหมาย	๑. เครือข่ายบริการสุขภาพมีผลงานวิจัย/ R๒R/ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญจังหวัดขอนแก่น ๒. เครือข่ายบริการสุขภาพมีการนำผลงานวิจัย/ R๒R/ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด ไปใช้ประโยชน์
วัตถุประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น โดยงานวิจัย/ R๒R/ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	รวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายบริการสุขภาพสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลผลงานวิจัย/R๒R/นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเครือข่ายบริการสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส ๔

แนวทางการประเมิน			
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน
๑. จำนวนผลงาน ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง ปัญหาในพื้นที่ ๒. ผลงานวิจัย ที่เป็นปัญหาร่วมในระดับจังหวัด ๑ เรื่อง	๑. จำนวนผลงาน ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง ปัญหาในพื้นที่ ๒. ผลงานวิจัย ที่เป็นปัญหาร่วมในระดับจังหวัด ๑ เรื่อง	๑. จำนวนผลงาน ไม่น้อยกว่า ๔ เรื่อง ปัญหาในพื้นที่ ๒. ผลงานวิจัย ที่เป็นปัญหาร่วมในระดับจังหวัด ๑ เรื่อง	๑. จำนวนผลงาน ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง ปัญหาในพื้นที่ ๒. ผลงานวิจัย ที่เป็นปัญหาร่วมในระดับจังหวัด ๑ เรื่อง
วิธีการประเมินผล	ประเมินผลจาก ๑.จำนวนวิจัย หรือ นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอดที่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ๒.จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเชิงพาณิชย์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	๑. นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๓ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๔๑๙๙๔๖๔ ๒. นายณรินทร์ บัวอิน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๓ โทรศัพท์มือถือ : - ๓. นางสาวสิริพรรณ พร้อมไพล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๓ ๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๑๖ โทรศัพท์มือถือ : ๐๘๔ ๕๕๔๔๖๒๖ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๗	เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ
ชื่อตัวชี้วัด	๓๔.จำนวนหน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล
นิยาม	๑.หน่วยงานสาธารณสุขที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล หมายถึง หน่วยงานที่มีการพัฒนาองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ด้าน คือ มีโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์ตามเกณฑ์มีโปรแกรมสนับสนุนการให้บริการ/บริหารและมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ เกณฑ์มาตรฐาน HAIT ในประเด็นการเชื่อมต่อข้อมูล และการให้บริการประชาชนผ่าน Telemedicine Tele pharmacy และลดการรอคอยแออัดด้วยระบบคิวออนไลน์รายละเอียดดังนี้ ๑. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAIT ๒. โรงพยาบาล ให้บริการผ่านระบบ Tele medicine อย่างน้อย ๑ ช่องทาง ๓. โรงพยาบาล ให้บริการผ่านระบบ Tele pharmacy อย่างน้อย ๑ ช่องทาง ๔. โรงพยาบาลมีระบบให้บริการคิวออนไลน์ ๕. โรงพยาบาลแม่ข่ายมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รพ.สต. ภายใน CUP โดยประสานงานกับ รพ.สต. ภายใต้ MOU รพ.สต. ส่งข้อมูลไปยังฐานกลางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้วยวิธี Replication ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (Real Time)
วิธีรายงาน	ผู้รับผิดชอบรายงานผลงานเป็นรายไตรมาสไปยังระบบรายงานองค์กรดิจิทัล (ออนไลน์) ๑.การเชื่อมต่อฐานข้อมูล แสดงผลจากระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล ๒.โรงพยาบาลสื่อสารและให้บริการประชาชนผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลทุกไตรมาส ที่ link https://ict.kkpho.go.th/org
แหล่งข้อมูล	(ออนไลน์) https://ict.kkpho.go.th/org
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานที่พัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล รพ.(รพ.ศ./รพ.ท/รพ.ช.) ทุกแห่ง
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	
นางสาวสมจิตร เดชาเสถียร โทรศัพท์มือถือ ๐๙๘-๑๐๑-๐๗๕๔	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ e-mail :
นายศิริศักดิ์ พิมพาเรือ โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑-๔๑๕-๑๔๔๙	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน e-mail : sirisakppr@gmail.com
นายสุทธิศักดิ์ ธรรมพล โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒-๓๐๕-๗๕๗๒	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ e-mail : buboocs@gmail.com
นายอนิวัฒน์ พูนมณี โทรศัพท์มือถือ ๐๙๕-๑๘๖-๗๒๘๗	ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ e-mail : bomb.aniwat@gmail.com
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลการแพทย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๖๔	โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๗	เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในการให้บริการสุขภาพ และบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดกระทรวง	จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด
ชื่อตัวชี้วัด	๓๕.อำเภอที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด
คำนิยาม	การบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) หมายถึง การจัดระบบให้บริการปรึกษา แนะนำ รักษา ติดตาม เยี่ยมบ้าน ระหว่างโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง เช่น บ้าน คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.สต. หรือสถานพยาบาลเครือข่ายอื่นๆ โดยอาศัยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกกลุ่มโรคตามความเห็นของแพทย์ และบริบทของพื้นที่ ตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ให้บริการด้วยกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน อย่างน้อยประกอบด้วย ดังนี้ ๑. กระบวนการให้บริการมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ๒. ปฏิบัติด้วยความรอบคอบภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และทำการบันทึก RoPA (กิจกรรมการประมวลผลขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๓๔ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒) ๓. การให้บริการการแพทย์ทางไกล สามารถเรียกเก็บค่าบริการรักษาจากกองทุนต่างๆ ได้ตามสิทธิ์ ๔. บันทึกข้อมูลการให้บริการฯ ในระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS: Hospital Information System) ด้วยรหัสมาตรฐานแฟ้ม Service (๑๔) รหัสประเภทการมารับบริการ “๕ รับบริการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth / Telemedicine)” และจัดส่งข้อมูลบริการฯ ดังกล่าวเข้าสู่คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC: Health Data Center) ๕. การให้บริการการแพทย์ทางไกล เชื่อมโยงกับการส่งยาที่บ้านได้ ๖. มีจำนวนครั้งการให้บริการฯ ภาพรวมทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ครั้ง หน่วยบริการ หรือ รพ. หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ / ทัวไป / ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มาตรการที่ดำเนินงานในพื้นที่ ๑. หน่วยบริการมีการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามที่แพทย์เห็นสมควร หรือตามบริบทของพื้นที่ ๒. อสม. มีส่วนร่วมในการให้บริการการแพทย์ทางไกล โดยใช้กลไก ๓ หมอ ๓. การให้บริการการแพทย์ทางไกล สามารถเชื่อมต่อบันทึกการให้บริการ (Visit) กับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ๔. หน่วยบริการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการการแพทย์ทางไกล ๕. หน่วยบริการจัดทำรายงานสิ้นปีแสดงสถิติจำนวนครั้งการนัดหมายรับบริการในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและกลุ่มติดตามอาการทั้งหมด เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการคำนวณร้อยละของตัวชี้วัดในปีงบประมาณถัดไป ๖. คณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพระดับจังหวัด ติดตามและกำกับดูแลหน่วยบริการให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด

มาตรฐานเพิ่ม อ้างอิงจากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(<https://bps.moph.go.th/healthdata/standardcode๔๓๖๒-๔๑๕๐oct๑๙/>)

รหัสที่ใช้บันทึก	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	มารับบริการเอง	
2	มารับบริการตามนัดหมาย	
3	ได้รับการส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น	
4	ได้รับการส่งต่อจากบริการ EMS	
5	รับบริการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth / Telemedicine)	ปรับปรุงจากศูนย์มาตรฐานรหัสฯ กยพ. (พ.ศ. 2564)

แนวทางการตรวจ ติดตาม

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลข้อมูลจำนวนครั้งในการให้บริการ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC: Health Data Center) และแสดงรายงานในเว็บไซต์ <https://hdcservice.moph.go.th>

เกณฑ์เป้าหมาย	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
	อำเภอที่มีบริการ การแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (เกณฑ์ให้บริการ การแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์และ มีการให้บริการแพทย์ ทางไกลในกลุ่ม IMC และ PC ร้อยละ ๑๐๐)	อำเภอที่มีบริการ การแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ (เกณฑ์ให้บริการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำนวนครั้ง การนัดหมายรับบริการ ในกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ เรื้อรังและกลุ่มติดตาม อาการทั้งหมด)	อำเภอที่มีบริการ การแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (เกณฑ์ให้บริการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนครั้งการนัด หมายรับบริการในกลุ่ม ผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังและ กลุ่มติดตามอาการ ทั้งหมด)	อำเภอที่มีบริการ การแพทย์ทางไกล ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ (เกณฑ์ให้บริการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนครั้งการนัด หมายรับบริการในกลุ่ม ผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยโรค ไม่ติดต่อเรื้อรังและกลุ่ม ติดตามอาการทั้งหมด)
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้มีการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ทางไกลทั่วประเทศ ๒. เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ ได้มากขึ้น			
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล			
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	หน่วยบริการส่งข้อมูลจำนวนครั้งของการให้บริการการแพทย์ทางไกล (รหัสประเภท การมารับบริการ รหัส ๕ รับบริการสาธารณสุขทางไกล (Telehealth / Telemedicine)) ไปยังระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC: Health Data Center)			

แหล่งข้อมูล	Health Data Center https://hdcservice.moph.go.th								
รายการข้อมูล	A = จำนวนอำเภอที่มีจำนวนครั้งการให้บริการการแพทย์ทางไกล ตามกำหนด B = จำนวนอำเภอทั้งหมด								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A /B) x ๑๐๐								
ระยะเวลาประเมินผล	ไตรมาส ๓								
Small Success ปี ๒๕๖๗									
รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน						
มีจำนวนครั้งการให้บริการการแพทย์ทางไกลใน HDC Service	มีจำนวนครั้งการให้บริการการแพทย์ทางไกลใน HDC Service เพิ่มขึ้นจากไตรมาสแรก	มีจำนวนครั้งการให้บริการการแพทย์ทางไกลใน HDC Service เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสอง	มีจำนวนครั้งการให้บริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนดแสดงใน HDC Service จำนวน ๕,๕๐๐ ครั้ง มีการให้บริการแพทย์ทางไกลในกลุ่ม IMC และ PC ร้อยละ ๑๐๐						
วิธีการประเมิน	ประเมินจำนวนครั้งการให้บริการฯ ภาพรวมทั้งจังหวัดไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ครั้ง และมีการให้บริการแพทย์ทางไกลในกลุ่ม IMC และ PC ร้อยละ ๑๐๐								
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	<table><tr><td>ปี ๒๕๖๔</td><td>ปี ๒๕๖๕</td><td>ปี ๒๕๖๖</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>๑๒,๓๓๙ ครั้ง</td></tr></table>			ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	-	-	๑๒,๓๓๙ ครั้ง
ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖							
-	-	๑๒,๓๓๙ ครั้ง							
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ชื่อ-สกุล...นางสาวกรรณก บุษมาหล้า ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงาน...พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ...๐๘๖ - ๒๙๑๗๘๕๐ E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com								
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐ - ๓๕๗๐๙๑๐ E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒... โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗								

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาศูนย์สาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๘	หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดกระทรวง	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขึ้น ๓
ชื่อตัวชี้วัด	๓๖.โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการรับรอง HA ขึ้น ๓
คำนิยาม	• HA (Hospital Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) มีกระบวนการรับรอง ๓ ขึ้น ดังนี้ - HA ขึ้นที่ ๑ หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการสำรวจและป้องกันความเสี่ยง นำปัญหามาทบทวนเพื่อแก้ไขป้องกัน ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง - HA ขึ้นที่ ๒ หมายถึง โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เป้าหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเป้าหมาย/ครอบคลุมกระบวนการสำคัญทั้งหมด ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ตามเกณฑ์ขึ้น ๒ - HA ขึ้นที่ ๓ หมายถึง โรงพยาบาลที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ เริ่มต้นด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่างเชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน • ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล หมายถึง กระบวนการทำงานงานที่สำคัญของโรงพยาบาล ดังนี้ การบริหารคุณภาพ ความเสี่ยงและความปลอดภัย การกำกับดูแลด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ระบบเวชระเบียน ระบบการจัดการด้านยา การตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ และการทำงานกับชุมชน • การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๑. การพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล มีเป้าหมาย ดังนี้ ๑) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ๒) เพื่อลดความแออัดลดระยะเวลาการรอคอยในการรับบริการ ๓) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ ๒. การประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ประกอบด้วย ๓ ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมดี (Environment) ด้านความทันสมัย (Modernization) และด้านบริการด้วยหัวใจ (Smart Service) โรงพยาบาลวิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการ จากข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำและส่ง QR code ให้โรงพยาบาลเป็นผู้ดำเนินการ พร้อมนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงการจัดบริการที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน • โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๖ แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป ๒ แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๑๙ แห่ง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก ๔ แห่ง โดยแบ่งสถานการณการ

	รับรองคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA เป็น ๓ กลุ่มโรงพยาบาล ดังนี้ ๑) โรงพยาบาลที่เตรียมรับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ และเตรียมรับการรับรองซ้ำ (Re-Accreditation) หรือ โรงพยาบาลที่มีผลการรับรอง Re-Accreditation ครั้งต่างๆ แต่ผลการรับรองหมดอายุ (e) และอยู่ระหว่างต่ออายุการรับรอง จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น, พระยืน, หนองเรือ, อุบลรัตน์, ชนบท, มัญจาคีรี, กระนวน, ภูเวียง, สิรินธร จ.ขอนแก่น, สีชมพู, บ้านฝาง, น้ำพอง, เขาสวนกวาง ๒) โรงพยาบาลที่ดำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้น ๓ และยังคงดำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง (ผลการรับรองคุณภาพยังไม่หมดอายุการรับรอง) จำนวน ๙ แห่ง ได้แก่ แวงใหญ่ , เปือยน้อย, หนองสองห้อง, ชุมแพ, ภูผาม่าน, ชำสูง, พล, แวงน้อย, บ้านไผ่ ๓) โรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น ๒ หมายถึง โรงพยาบาลขนาดเล็ก จำนวน ๔ แห่ง คือ โนนศิลา, โคกโพธิ์ไชย, เวียงเก่า, หนองนาคำ																								
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><th rowspan="2">ประเภท</th><th colspan="4">ปีงบประมาณ</th></tr><tr><th>๒๕๖๗</th><th>๒๕๖๘</th><th>๒๕๖๙</th><th>๒๕๗๐</th></tr><tr><td>โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป (๓ แห่ง)</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td></tr><tr><td>โรงพยาบาลชุมชน (๑๙ แห่ง)</td><td>๙๒</td><td>๙๔</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td></tr><tr><td>โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F๓) (๔ แห่ง)</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td><td>๑๐๐</td></tr></table>	ประเภท	ปีงบประมาณ				๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป (๓ แห่ง)	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	โรงพยาบาลชุมชน (๑๙ แห่ง)	๙๒	๙๔	๑๐๐	๑๐๐	โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F๓) (๔ แห่ง)	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
ประเภท	ปีงบประมาณ																								
	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐																					
โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป (๓ แห่ง)	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐																					
โรงพยาบาลชุมชน (๑๙ แห่ง)	๙๒	๙๔	๑๐๐	๑๐๐																					
โรงพยาบาลขนาดเล็ก (F๓) (๔ แห่ง)	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐																					
วัตถุประสงค์	รพศ./รพท./รพช. ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาระบบคุณภาพ ผ่านการรับรอง HA ขั้น ๓ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) พร้อมดำรงรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับบริการมีความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ																								
กลุ่มเป้าหมาย	๒๖ โรงพยาบาล																								
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) www.ha.or.th ๒. รายงานสถานการณ์การรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ๓. ระบบรายงานข้อมูลประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น																								
แหล่งข้อมูล	๑.ข้อมูลจากเว็บไซต์สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (สรพ.) www.ha.or.th สำหรับประชาชน/โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ๒.ข้อมูลสถานการณ์รับรองคุณภาพ HA สสจ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๓.ผลสำรวจการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล																								
รายการข้อมูล	๑.สถานการณ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ๒.รายงานข้อมูลผลการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ๓.แผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพจาก สรพ.																								

ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ ๑ ครั้ง					
Small Success ปี ๒๕๖๗						
ประเภท		รอบ ๓ เดือน	รอบ ๖ เดือน	รอบ ๙ เดือน	รอบ ๑๒ เดือน	
โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป		๙๘	๙๙	๑๐๐	๑๐๐	
โรงพยาบาลชุมชน		๙๐	๙๑	๙๒	๙๒	
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน(Baseline Data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ -๒๕๖๖)	ผลงาน		หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน		
				๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
	โรงพยาบาลศูนย์ ,โรงพยาบาลทั่วไป		ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
	โรงพยาบาลชุมชน		ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๘๔.๒
	โรงพยาบาลระดับ F๓ (๔ แห่ง)		ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด						
นางประเพ็ญพร ชำนาญพงษ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทร ๐๖๒ ๖๑๔๘๒๓๑						
นางนุชศรินทร์ แพงมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เบอร์โทร ๐๘๙ ๙๔๔๖๗๗๙						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด						
นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ						
กลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น						
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗						
โทรศัพท์มือถือ ๐๖๒ ๖๑๔๘๒๓๑ E-mail : e-mail: hakhonkaen63@gmail.com						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๘	หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดกระทรวง	-
ตัวชี้วัด	๓๗.จำนวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผ่านเกณฑ์พัฒนาศักยภาพเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Smart สสอ.
คำนิยาม	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ : ยุทธการเปลี่ยนผ่านภายใต้รูปแบบฉาบทันใหม่ หมายถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรภายใต้หลักการ Smart สสอ. ประกอบด้วย S : Standard Service การดำเนินงาน Community Care/Health Station/ PCU/ทันตกรรม/คลินิกแพทย์แผนไทย M : Monitoring &Evaluation การพัฒนาแผนสุขภาพระดับอำเภอ การควบคุมและประเมินผลทางการแพทย์และสาธารณสุข A : Academic การพัฒนาเป็นศูนย์บริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข/วิจัย/นวัตกรรม R : Regulator การดำเนินการภายใต้ Law/Health Regulator T : Transformation การพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลระบบสุขภาพและสารสนเทศ
เกณฑ์เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาองค์กรสมรรถนะสูง Smart สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๒๖ อำเภอ รอความชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุข	
วัตถุประสงค์	เพื่อยกระดับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง นำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๒๖ แห่ง
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด นายจักรสันต์ เลยหยุด ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๙ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล												
เป้าประสงค์ที่ ๘	หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน												
ชื่อตัวชี้วัด	๓๘. ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖												
คำนิยาม	หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ทุกสังกัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ เกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ หมายถึง เกณฑ์ประเมินคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.๒๕๖๖ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้ ส่วนที่ ๑ ด้านระบบบริหารจัดการ ส่วนที่ ๒ ด้านการจัดบุคคลากรและศักยภาพในการให้บริการ ส่วนที่ ๓ ด้านสถานที่ตั้งหน่วยบริการ อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ ๔ ด้านระบบสารสนเทศ ส่วนที่ ๕ ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ส่วนที่ ๖ ด้านระบบห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ส่วนที่ ๗ ด้านการจัดบริการเภสัชกรรมคลังานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ส่วนที่ ๘ ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยมีการแปลผลดังนี้ ส่วนที่ ๑ - ๔ หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ส่วนที่ ๕ - ๘ หน่วยบริการต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป												
เกณฑ์เป้าหมาย	<table><tr><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</td><td>ปีงบประมาณ ๒๕๗๐</td></tr><tr><td>ร้อยละ ๙๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td><td>ร้อยละ ๑๐๐</td></tr></table>					ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐										
ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐										
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ๒. เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน												
กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง ทุกสังกัด												
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	การจัดเก็บการประเมินคุณภาพมาตรฐาน จากระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU)												
แหล่งข้อมูล	ระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU)												
รายการข้อมูล	A = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบสุขภาพปฐมภูมิ B = จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมดทุกสังกัด												
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x ๑๐๐												
ระยะเวลาประเมินผล	ปีละ ๑ ครั้ง												

วิธีการประเมิน	ระบบทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ (GIS Health/PCU) และสุ่มประเมินในพื้นที่		
ผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)	ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖
	-	-	ร้อยละ ๙๗
ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด	นางศิริพร อุทธากิจ ตำแหน่ง..พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๐ - ๓๕๗๐๙๑๐. E-mail : pcunpcu๒๐๒๒@gmail.com		
ผู้กำกับดูแล ตัวชี้วัด	นางศิริมา นามประเสริฐ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๑๒๕ ต่อ ๑๒๒ โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๔๐๓๗		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔	การพัฒนาองค์กรสาธารณสุขให้มีสมรรถนะสูง บริการด้วยความทันสมัยและธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ ๙	มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อตัวชี้วัด	๓๙.โรงพยาบาลมีการบริหารการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
คำนิยาม	ส่วนที่ ๑ ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ๕ มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ ๑. จัดตั้งงานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๐) ๑.๑ มีคำสั่ง หรือ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Audit Chart เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเวชระเบียน ๑.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลของหน่วยงาน ๒. การบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ๒.๑ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ๒.๒ การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ๒.๓ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บรายได้ส่งรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางให้กับงานบัญชี ๒.๔ รายงานสรุปผลการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) สิทธิกรมบัญชีกลาง ๓. กระบวนการเร่งรัดติดตามการเรียกเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ๓.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระและผู้รับผิดชอบการรับชำระหนี้ แยกออกจากกัน ๓.๒ มีการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V ๓.๐ (TPS) น้ำหนักเน้นในเรื่องต่อไปนี้ ๒.๑ ประเมินการดำเนินงานในตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators) ๑) การบริหารแผนทางการเงิน (Planfin) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน ๕% - มิติรายได้ - มิติค่าใช้จ่าย ๒) การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน - ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้า&เวชภัณฑ์มิใช่ยา ≤ ๙๐ วัน หรือ ≤ ๑๘๐ วัน

	- ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ UC ≤ 60 วัน - ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิข้าราชการ ≤ 60 วัน - การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน ยกเว้น รพ.พื้นที่เกาะ ≤ 90 วัน ๓) การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย - Unit Cost for OP - Unit Cost for IP - LC ค่าแรงบุคลากร - MC ค่ายา - MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ - MC ค่าเวชภัณฑ์มีชีวะและวัสดุการแพทย์ ๔) คะแนนตรวจสอบงบประมาณเบื้องต้น ๕) ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ - อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน มากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ % - Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่มโรงพยาบาล หรือ เพิ่มขึ้น ๕ % ๒.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงาน (Operating Indicators) ๑) ความสามารถในการทำกำไร - ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin) - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset) - ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐ ๒) การวัดสภาพคล่องทางการเงิน - ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) มากกว่าหรือเท่ากับ ๐ - Cash Ratio มากกว่าหรือเท่ากับ ๐.๘
เกณฑ์เป้าหมาย	-
วัตถุประสงค์	โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ในจังหวัดขอนแก่น มีการบริหาร การเงิน การคลังอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีความเสี่ยงด้านการเงิน (ระดับ ๔-๗) ศูนย์จัดเก็บรายได้มีคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๖ แห่ง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	ตามรอบประเมินผล CUP ๒ ครั้ง/ปี โดยกำกับติดตามข้อมูล ผ่านกระบวนการ บริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด และผลงานตามแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูล	โรงพยาบาลที่รับการตรวจประเมิน กลุ่มงานตรวจสอบภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
รายการข้อมูล	๑. สรุปผลการประเมินมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการ ควบคุมภายใน (Internal Control : IC) จากหน้าเว็บไซต์กลุ่มงานตรวจสอบ

	ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒. งบประมาณเงิน จากงบทดลอง และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล ๓. รายงานการประชุม และรายงานที่กำหนดให้ส่งจังหวัด												
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	๑. คะแนนประเมินมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เว็บไซต์ https://iad.moph.go.th คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๒. ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V ๓.๐ (TPS) <u>รายไตรมาส</u> ในเว็บไซต์ http://hfo.cfo.in.th ไตรมาสล่าสุด คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน												
ระยะเวลาประเมินผล	ประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีเศษรอบที่ ๒/๒๕๖๗ โดยใช้คะแนน EIA ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และผลประเมิน TPS ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗												
เกณฑ์การประเมิน	: องค์ประกอบการประเมินข้อมูล ๒ ส่วน (ส่วนที่ ๑ = ๑๐๐ คะแนน ส่วนที่ ๒ = ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ใช้เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ๕ มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ตามการประเมินโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ๑ ส่วนที่ ๒ การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V ๓.๐ (TPS) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนโดยให้คะแนนตามผลการประเมิน โดยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ๒ ดังนี้												
	<table><tr><td>เกรด</td><td>เกรด A</td><td>เกรด B</td><td>เกรด C</td><td>เกรด D</td><td>เกรด F</td></tr><tr><td>คะแนนที่ได้</td><td>๑๐๐</td><td>๘๐</td><td>๗๐</td><td>๖๐</td><td>๕๐</td></tr></table> นำคะแนนที่ได้ทั้ง๒ส่วน มาบวกกันแล้วหาร ๒ เพื่อวัดระดับการดำเนินงาน	เกรด	เกรด A	เกรด B	เกรด C	เกรด D	เกรด F	คะแนนที่ได้	๑๐๐	๘๐	๗๐	๖๐	๕๐
เกรด	เกรด A	เกรด B	เกรด C	เกรด D	เกรด F								
คะแนนที่ได้	๑๐๐	๘๐	๗๐	๖๐	๕๐								

วิธีการประเมิน	คะแนนที่ได้แบ่งระดับการดำเนินการเป็น ๕ ระดับ ตามคะแนนดังนี้				
	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
	๖๕-๖๙	๗๐-๗๔	๗๕-๗๙	๘๐-๘๔	๘๕ ขึ้นไป
	เกณฑ์การดำเนินการปี ๒๕๖๗ จำนวนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การดำเนินการระดับ ๕ ขึ้นไป ๑๖ แห่ง และเป้าหมาย ในปีต่อๆ ไป ดังนี้				
	ปีงบประมาณ ๖๖	ปีงบประมาณ ๖๗	ปีงบประมาณ ๖๘	ปีงบประมาณ ๖๙	
	๑๒ แห่ง	๑๖ แห่ง	๒๐ แห่ง	๒๔ แห่ง	
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี (ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖)					
จากผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ๕ มิติ ในมิติด้านการจัดเก็บรายได้ ตามเกณฑ์การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (Internal Control : IC) ที่กำหนดโดยกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เว็บไซต์ https://iad.moph.go.th) และผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V ๓.๐ (TPS) ที่กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(เว็บไซต์					
Baseline data (ปี ๒๕๖๖ ไตรมาส ๓)	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	
ร้อยละ ๕๓.๘๔ (๑๔ แห่ง)	จำนวน รพ.	ร้อยละ ๑๕.๓๘ (๔ แห่ง)	ร้อยละ ๒๖.๙๒ (๗ แห่ง)	ร้อยละ ๕๓.๘๔ (๑๔ แห่ง)	
https://hfo.moph.go.th)					
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด					
นางบัวลักษณ์ จันทระ		ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ			
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๖๐ ๑๖๑		โทรศัพท์มือถือ ๐๘๔-๒๖๐๑๙๕๐			
โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗		E-mail : bualuk.j@gmail.com			
นายชัชวาลย์ มุ่งแสง		ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ			
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๖๐ ๑๖๑		โทรศัพท์มือถือ ๐๘๖-๖๔๓๔๘๐๑			
โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗		E-mail : chatchawan.m@gmail.com			
นางมลิวรรณ มะลิตัน		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี			
โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๒๑๑๒๕ ต่อ ๑๕๓		โทรศัพท์มือถือ ๐๙๑-๐๖๔๕๐๔๓			
โทรสาร ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗		E-mail : maliwan.financial@hotmail.co.th			

ภาคผนวก

ภาพประกอบการประชุม

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
วันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมหมัดหมี่ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น



ภาพประกอบการประชุม

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น



รายชื่อผู้ร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นายอภิชัย ลิมานนท์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒	นายประวีร์ คำศรีสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓	นายมนูณี เหมือนชาติ	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔	นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕	นางสาวกรรณิกา ตั้งวานิชกพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖	นางบัวบุญ อุดมทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๗	นางวีรวรรณ รุจิฉินากุล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๘	นางสาลินี ไวยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๙	นางรุ่งทอง วัชรนุกุลเกียรติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๐	นางบัวลักษณ์ จันทระ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๑	นายจักรสันต์ เลยหยุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๒	นางศิริมา นามประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๓	นางวราภรณ์ ชูคันหอม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๔	นางกิตติมา ก้านจักร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๕	นายสมพร ชมบุญ	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๖	น.ส.สมจิตร เดชาสเถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๗	นางวรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๘	นายเจษฎา สุรวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๙	นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๐	นางพิศวาท ชุมแวงวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๑	นางธีรนุช อยู่ลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๒	น.ส.สุภาวดี นาคอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๓	นางจิรฐิติกาฬ วิเศษดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๔	น.ส.วิราสินี สีสงคราม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๕	น.ส.จุฑามาศ ทองประเสริฐ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๖	นายบุญญฤทธิ์ จันทรมี	นักวิชาการสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๗	นางพินัญดา เหมือนชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๘	นายชุมพล รวมทวี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒๙	นางสิริลักษณ์ วุฒิพิริยะอังกูร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๐	น.ส.จกกลนี บุญอาษา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๑	นางศศิธร เอื้ออนันต์	เภสัชกรชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๒	นางอังคณา อั้งปีติมานะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๓	นางนรินทร์รัตน์ แก้วลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๔	นางวรวลัย เกษมศรีวิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๕	นางสมาพร สุธะเมียกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๖	นายณัฐวุฒิ จันทะแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๗	น.ส.นภัสวรรณ สนธินอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๘	นายรังสรรค์ พลหล้า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓๙	นางธัญญา อุพลเถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๐	นางชัชวาล มุ่งแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๑	นายสุรศักดิ์ สุตธรรม	นิติกรชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๒	นางลัดดาวัลย์ เทียมกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๓	นายวัฒนา นิลบรรพต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๔	น.ส.เทวารักษ์ ภูครองนาค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๕	นายณรงค์ชัย เต็กศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๖	น.ส.เอมวิกา แสงชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๗	นางสุกุลยา กิตติโพวานนท์	เภสัชกรชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๘	น.ส.วีรินทร์ วงษ์โคควินท์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๔๙	นายธนภุต สุระอามาศย์	แพทย์แผนไทย	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๐	นางสุพธิมา ยลโสภณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๑	นางนิธิดา ศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๒	นางพัชรารัตน์ พิรุณสุนทร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๕๓	นางประเพ็ญพร ชำนาญพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๔	นางวีระวรรณ เหล่าวิทวัส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๕	นางแสงเดือน โสภา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๖	นางวาสนา ทิพลีศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๗	นางรุ่งฤดี ไชยทองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๘	นางวนิดา จอมอาจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๕๙	นางจิรวรรณ ใจเที่ยง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๐	นางจิระวัฒน์ ไชยพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๑	น.ส.กุมวดี บุญฤทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๓	นางนุชจรินทร์ แพงมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๔	น.ส.ชัยณรงค์ นักศักดิ์	เภสัชกรชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๕	นางยุพาพร ดีแป้น	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๖	นางพัชรินทร์ ฤทธิรักษา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๗	น.ส.สกลรัตน์ พาลาฮาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๘	นางจิราภรณ์ บุญปก	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๖๙	น.ส.ปทุมณา โพธิ์สิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๗๐	น.ส.กรกนก บุญมาหล้า	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๗๑	น.ส.มณฑิยา เหลลามา	นักวิชาการสาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๗๒	นางรุจิราลักษณ์ พรหมเมือง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	โรงพยาบาลขอนแก่น
๗๓	น.ส.จริยา ปากดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	โรงพยาบาลขอนแก่น
๗๔	น.ส.สุภาพร ตรละคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โรงพยาบาลขอนแก่น
๗๕	นายพรพล เหล่าวิทวัส	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี	โรงพยาบาลมัญจาคีรี
๗๖	นางเรียมใจ พลเวียง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย	โรงพยาบาลหนองเปือยน้อย
๗๗	นายทิว อุดชาชน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
๗๘	นายสุรพงษ์ ผานาค	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า	โรงพยาบาลเวียงเก่า
๗๙	นายอูรส สิงห์งาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง	โรงพยาบาลน้ำพอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๘๐	น.ส.อภิสรรา อารงวรารังกูร	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์	โรงพยาบาลอุบลรัตน์
๘๑	นายพศวีร์ เผ่าเสรี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลชุมแพ
๘๒	นายอนันต์ คำอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	โรงพยาบาลชุมแพ
๘๓	นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์วัลลภ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โรงพยาบาลหนองสองห้อง
๘๔	น.ส.นุชนาฏ หินวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	โรงพยาบาลพระยืน
๘๕	นายวงศ์สนั่น เครื่องฉาย	สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง
๘๖	นายพิชิต แสนเสนา	สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ
๘๗	นายอาคม ปัญญาแก้ว	สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์
๘๘	นายคมกริช ศิริภาคย์โสภณ	สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่	สำนักงานสาธารณสุขบ้านไผ่
๘๙	นายบุญถม ชัยญวน	สาธารณสุขอำเภอพล	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพล
๙๐	นายสมเด็จ ก้วพิทักษ์	สาธารณสุขอำเภอเขาสนวนกวาง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสนวนกวาง
๘๑	นายวิฑูรย์ อาลัยลักษณ์	สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น
๙๒	นายถนิต จ่ากลาง	สาธารณสุขอำเภอชุมแพ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
๙๓	นายเหมชาติ นิละสมิต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำสูง
๙๔	นายสมหมาย ชาน้อย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเปือยน้อย
๙๕	นางสาวชนมเทียน สายบัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๙๖	นายธิตินันท์ ธวัชบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ที่ ๑๔๘/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภาและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ความเป็นเลิศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ระยะ ๕ ปี ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ปัญหาความต้องการจากพื้นที่ ในการจัดทำแผนให้สอดคล้องกันในทุกระดับ

เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีความสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง และนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน จังหวัดขอนแก่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

- | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|
| ๑. นายอภิชัย | ลิมานนท์ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น | ประธาน |
| ๒. นายประวีร์ | คำศรีสุข | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) | รองประธาน |
| ๓. นางพชรพร | ครองยุทธ | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) | รองประธาน |
| ๔. นายมนี | เหมือนชาติ | ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) | กรรมการ |
| ๕. นายเชิดชัย | อริยานุชิตกุล | เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) | กรรมการ |
| ๖. นางสาวกรรณิกา | ตั้งวานิชพงษ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) | กรรมการ |
| ๗. นายวิโรจน์ | เลิศพงศ์พิพัฒน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) | กรรมการ |
| ๘. นายอดุลย์ | บำรุง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) (ด้านเวชกรรม) | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น | | | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น | | | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ | | | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง | | | กรรมการ |
| ๑๓. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ | | | กรรมการ |

๑๔.	หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น	กรรมการ
๑๕.	นางบัวบุญ อุดมทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ
๑๖.	นางวรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗.	นางสาวสมจิตร เดชาเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘.	นายเจษฎา สุรารวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙.	นางมิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๑.	นายประวีร์ คำศรีสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	ประธาน
๒.	นางบัวบุญ อุดมทรัพย์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข	รองประธาน
๓.	นางวิวรรธน์ รุจิณากุล	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข	คณะทำงาน
๔.	นางสุมาลี บุญญรัตน์	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป	คณะทำงาน
๕.	นายพุทธา ศรีเกิน	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย	คณะทำงาน
๖.	นายจำเนียร มูลเทพ	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย	คณะทำงาน
๗.	นางสาลิณี ไวยานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	คณะทำงาน
๘.	นางสาวสิริพรรณ พร้อมไพล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๙.	นางรุ่งทอง วัชรนุกุลเกียรติ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	คณะทำงาน
๑๐.	นางสาวนพพร การถัก	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	คณะทำงาน
๑๑.	นางศิริมา นามประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบบริการ	คณะทำงาน
๑๒.	นางบัวลักษณ์ จันทระ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ	คณะทำงาน
๑๓.	นางกิตติมา ก้านจักร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด	คณะทำงาน
๑๔.	นางวราภรณ์ ชูคันหอม	หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐาน และระบบสุขภาพปฐมภูมิ	คณะทำงาน
๑๕.	นายจักรสันต์ เลยหยุด	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	คณะทำงาน
๑๖.	นางรุจิราลักษณ์ พรหมเมือง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลขอนแก่น	คณะทำงาน
๑๗.	นายศักดิ์ชัย เกียรติอำนาจ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	คณะทำงาน
๑๘.	นายพศวีร์ เผ่าเสรี	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมแพ	คณะทำงาน

ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชน

๑๙.	นายพรพล เหล่าวิหวัธ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี	คณะทำงาน
๒๐.	นางเรียมใจ พลเวียง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย	คณะทำงาน

๒๑.	นายทิว	อุดชาชน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย	คณะทำงาน
๒๒.	นายสุรพงษ์	ผานาค	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเก่า	คณะทำงาน
๒๓.	นายอุรส	สิงห์งาม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง	คณะทำงาน
๒๔.	นายเชิดชัย	กิตติไพบานนท์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท	คณะทำงาน
๒๕.	นางสาวอภิสร	ธำรงวราราม	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์	คณะทำงาน

ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอ

๒๖.	นายวิทวัส	อาลัยลักษณ์	สาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น	คณะทำงาน
๒๗.	นายณัฐ	จำกลาง	สาธารณสุขอำเภอชุมแพ	คณะทำงาน
๒๘.	นายวงศ์แสนท์	เครื่องฉาย	สาธารณสุขอำเภอน้ำพอง	คณะทำงาน
๒๙.	นายสมเด็จ	กั้วพิทักษ์	สาธารณสุขอำเภอเขาสนกวาง	คณะทำงาน
๓๐.	นายบุญถม	ชัยญวน	สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง	คณะทำงาน
๓๑.	นายอาคม	ปัญญาแก้ว	สาธารณสุขอำเภออุบลรัตน์	คณะทำงาน
๓๒.	นายธรรมบุญ	บุญจันทร์	สาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่	คณะทำงาน

ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์ โรงพยาบาล

๓๓.	นางธนัชฐา	ศุภวิชัย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น	คณะทำงาน
๓๔.	นายอนันต์	คำอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมแพ	คณะทำงาน
๓๕.	นางอุษณีย์	คุณภู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	คณะทำงาน
๓๖.	นางกนกทอง	ไพศาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพล	คณะทำงาน
๓๗.	นางสาวท	อ่อนแพง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระยืน	คณะทำงาน
๓๘.	นายเฉลิมชัย	คำอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง	คณะทำงาน

ผู้แทนผู้รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

๓๙.	นายชาญณรงค์	อรรคบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง	คณะทำงาน
๔๐.	นายสมหมาย	ชาน้อย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่	คณะทำงาน
๔๑.	นายวิระวัฒน์	นักร้อง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระยืน	คณะทำงาน
๔๒.	นายพงษ์ศักดิ์	ทรัพย์ศิลาทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสนกวาง	คณะทำงาน
๔๓.	นายณรงค์	บึงมุ่ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น	คณะทำงาน

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๔๔.	นางนรินทร์รัตน์	แก้วลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๕.	นางอังคณา	อึ้งปิติมานะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๖.	นางวรวลัย	เกษมศรีวิวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๗.	นางสมาพร	สุรเดมียกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๘.	นางวรรณกร	ตาบ้านตุ่	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๔๙.	นางวรินทร์รัตน์	ชั้นธสอาด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๐.	นายณัฐวุฒิ	จันตะแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๑.	นายชุมพล	รวมทวี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๒.	นางสาวนภัสวรรณ	สนธิ์นอก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕๓.	นางศิริลักษณ์	วุฒิพิริยะอังกูร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๕๔.	นางสาวจงกลณี	บุญอาษา	ทันตแพทย์ชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๕.	นายรังสรรค์	พลกล้า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๖.	นางมลิวรรณ	มะลิตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะทำงาน
๕๗.	นางสาวนรินทร์ลักษณ์	หมื่นพหล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๘.	นางธัญญา	อุพลเกียรติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๕๙.	นายชัชวาลย์	มุงแสง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๐.	นายสุทธิศักดิ์	ธรรมพล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖๑.	นายศิริศักดิ์	พิมพ์าเรือ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	คณะทำงาน
๖๒.	นายสมเพชร	ชมบุญ	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๓.	นายสุรศักดิ์	สุดธรรม	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๔.	นางสาวเทวรักษ์	ภูครองนาค	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๕.	นางลัดดาวัลย์	เทียมกลาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๖.	นายวัฒนา	นิลบรรพต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๗.	นางศิริพร	อุทธากิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๘.	นางอนุรักษ์	สะตะ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๖๙.	นางพินญาดา	เหมือนชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๐.	นางวีระวรรณ	เหล่าวีหวัส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๑.	นางสาวเอมิกา	แสงชาติ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗๒.	นางสุกัลยา	กิตติไพวานนท์	เภสัชกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๓.	นางสาววีรินทร์	วงษ์โกควินท์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗๔.	นายธนภุต	สุระอามาศย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗๕.	นางนุชศรีรินทร์	แพงมา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๖.	นางสุทธิมา	ยลโสภณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๗.	นางนิธิดา	ศรีแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๘.	นางพัชราวดี	พิรุณสุนทร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๗๙.	นางประเพ็ญพร	ชำนาญพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๐.	นางศศิธร	เอื้ออนันต์	เภสัชกรชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๑.	นางสาวชญญ์รัชต์	นกศักดิ์	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน

๘๒.	นางสาวมณูชดา	คำดีบุญ	เภสัชกร	คณะทำงาน
๘๓.	นางแสงเดือน	โสภะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๔.	นางวราสนา	ทิพเลิศ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๕.	นางวนิดา	จอมอาจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๖.	นางรุ่งฤดี	ไชยทองศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๗.	นางรุจิวรรณ	ยมศรีเคน แสงสุน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๘.	นางมิ่งขวัญ	ภูหงษ์ทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงาน
๘๙.	นางจิราวรรณ	ใจเที่ยง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๙๐.	นายจิระวัฒน์	ไชยพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๙๑.	นางสาวกมลวดี	บุญรัตน์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๙๒.	นางวรินทร์ทิพย์	ศรีกงพลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๓.	นางสาวสมจิตร	เดชาเสถียร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๔.	นายเจษฎา	สุราวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๕.	นางธีรนาถ	อยู่ลา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๖.	นางนิออน	ลีคะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ
๙๗.	นางพิศวาท	ชุมแวงวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๙๘.	นายธิตินันท์	ธะบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๙๙.	นางสาวชนมเทียน	สายบัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน นโยบายสภาพปัญหาในพื้นที่ (Strategy need) แหล่งข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ พร้อมทั้งทำการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำแผน
- ดำเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น ให้มีความสมบูรณ์ ครบคลุมเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดขอนแก่น (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นำสู่การวิพากษ์แผน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเสนอผู้บริหาร
- พัฒนาระบบการติดตาม ควบคุม กำกับแผนยุทธศาสตร์สุขภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายอภิชัย ลิมานนท์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

๒

(นางบัวบุญ อุดมทรัพย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๗๖ ๐๓
(นางพรพร ครองยุทธ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

(นางวรินทร์ทิพย์ ศรีกงพลี)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

คณะผู้จัดทำเอกสาร

หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

คณะที่ปรึกษา

๑. นายอภิชัย	ลิมานนท์	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒. นายประวีร์	คำศรีสุข	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๓. นายมนู	เหมือนชาติ	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
๔. นายเชิดชัย	อริยานุชิตกุล	เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
๕. นางสาวกรรณิกา	ตั้งวานิชพงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
๖. นางบัวบุญ	อุดมทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๗. นางวีรวรรณ	รุจิณากุล	หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
๘. นายจำเนียร	มูลเทพ	หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
๙. นางสาวสิริพรรณ	พร้อมไพล	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
๑๐. นางรุ่งทอง	วัชรนุกุลเกียรติ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
๑๑. นางสาวลิณี	ไวยนนท์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๑๒. นายจักรสันต์	เลยหยุด	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
๑๓. นางวรารณ	ชูคันหอม	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๔. นางบัวลักษณ์	จันทร์ระ	หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
๑๕. นางศิริมา	นามประเสริฐ	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
๑๖. นางกิตติมา	ก้านจักร	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
๑๗. นางศิริธร	ยอดสะอึก	หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
๑๘. นายสมเพชร	ชมบุญ	หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย
๑๙. นางสาวสมจิตร	เดชาเสถียร	หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้จัดทำ/รวบรวม : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

๑. นางวรินทร์ทิพย์	ศรีกงพลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๒. นางพิสวาท	ชุมแวงวาปี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๓. นายธนพนธ์	ธะบุรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔. นางสาวชนมเทียน	สายบัว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

.....



**กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๑๐๘ หมู่ ๔ ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : ๐๔๓-๒๒๐๐๒๕ โทรสาร : ๐๔๓-๒๒๔๐๓๗**